คู่มือ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ จังหวัดระยอง



สารบัญคู่มือ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ จังหวัดระยอง



ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง

เรื่อง การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง พ.ศ. 2569

ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง พ.ศ. 2569

หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าใช้จ่าย - เอกสารแนบท้าย (1)

การสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, การสนับสนุนการป้องกันโรค, การสนับสนุนการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก

หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าใช้จ่าย - เอกสารแนบท้าย (2)

โครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน

หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าใช้จ่าย - เอกสารแนบท้าย (3)

โครงการซ่อมบำรุง ดัดแปลงและจัดทำเฉพาะ อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ

หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าใช้จ่าย - เอกสารแนบท้าย (4)

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ป่วยระยะท้าย มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ

หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าใช้จ่าย - เอกสารแนบท้าย (5)

โครงการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน

หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าใช้จ่าย - เอกสารแนบท้าย (6)

การสนับสนุนและส่งเสริมด้านการพัฒนาศักยภาพ การมีส่วนร่วม และงานวิชาการ

หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าใช้จ่าย - เอกสารแนบท้าย (7)

โครงการเตรียมความพร้อมและรับมือโรคติดต่อ หรือภัยธรรมชาติ หรือภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและสังคม

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2569

แนวคิดและหลักการของระบบหลักประกันสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด

ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
จังหวัดระยอง

ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง
เรื่อง การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๙

โดยที่เป็นการสมควรจัดทำแนวทางบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง เพื่อให้บุคคลเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงให้มีความสอดคล้องกับบริบทการกระจายอำนาจด้านสุขภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๙ ข้อ ๒๑ (๓) ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๙ จึงออกระเบียบไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๙”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศใช้ระเบียบนี้เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

(๑) ระเบียบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดระยอง เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๒

(๒) ระเบียบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุนโครงการขอรับงบประมาณกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) ระเบียบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อ ๔ คำนิยาม

“องค์การบริหารส่วนจังหวัด” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล เมืองพัทยาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานคร

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง

“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง

“ประธานกรรมการกองทุน” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

“การจัดบริการสาธารณสุข” หมายความว่า การบริการสาธารณสุขในชุมชน เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต นอกเหนือจากการจัดบริการปกติของหน่วยบริการ

“การสร้าง...

“การสร้างเสริมสุขภาพ” หมายความว่า บริการที่มุ่งกระทำเพื่อให้บุคคลมีสุขภาพทางกายและจิตใจที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

“การป้องกันโรค” หมายความว่า บริการที่มุ่งกระทำเพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยหรือเป็นโรค และการป้องกันไม่ให้กลับเป็นซ้ำในกรณีที่หายจากการเจ็บป่วยหรือเป็นโรคแล้ว รวมถึงการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อการป้องกันโรค

“การฟื้นฟูสมรรถภาพ” หมายความว่า บริการที่มุ่งกระทำเพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพหรือความสามารถทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจให้ดีขึ้น โดยอาศัยกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพร่วมกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การจัดหาและสนับสนุนกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมของบุคคล เพื่อให้บุคคลสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ

“การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก” หมายความว่า การจัดบริการหรือการจัดกิจกรรมสาธารณสุข ซึ่งเป็นการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเบื้องต้นในชุมชน และนอกเหนือจากการจัดบริการปกติของหน่วยบริการ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการมากขึ้น

“สถานบริการ” หมายความว่า สถานบริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

“หน่วยบริการ” หมายความว่า สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

“หน่วยงานสาธารณสุข” หมายความว่า หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรง แต่มิได้เป็นสถานบริการหรือหน่วยบริการ

“หน่วยงานอื่น” หมายความว่า หน่วยงานที่มิได้มีภารกิจด้านการสาธารณสุข

“องค์กรหรือกลุ่มประชาชน” หมายความว่า องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน ภาคเอกชน หรือบุคคลที่มีการรวมตัวกันตั้งแต่ ๕ คนขึ้นไป ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลกำไร ทั้งนี้ จะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ข้อ ๕ คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการกองทุนประจำปีที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด และให้หมายความรวมถึงกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด แล้วเสนอต่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อทราบ

(๒) พิจารณาอนุมัติแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม รวมทั้งแผนดูแลรายบุคคลสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด และให้หมายความรวมถึงกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรม รวมทั้งแผนการดูแลรายบุคคลสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้เทียบเคียงตามระเบียบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด

(๓) ออกระเบียบที่จำเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุน ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๔) สนับสนุน...

(๔) สนับสนุนให้บุคคลในท้องถิ่นหรือพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชน หรือหน่วยบริการ ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

(๕) ให้คำแนะนำในการจัดทำข้อมูลและการดำเนินงานที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุขของกลุ่มเป้าหมาย แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กร หรือกลุ่มประชาชน

(๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุน

(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย และให้นำประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๙ ข้อ ๒๐ มาบังคับใช้กับการประชุมของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน โดยอนุโลม

ข้อ ๖ เพื่อให้การจ่ายเงินกองทุน ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไม่เป็นการซ้ำซ้อนกับการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้พิจารณาดำเนินงานในเขตจังหวัด ดังนี้

(๑) ดำเนินงานในโครงการขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือ

(๒) ดำเนินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่เป็นภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่มุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่นหรือประชาชนเป็นส่วนรวม และไม่เข้าไปดำเนินงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดสามารถดำเนินการได้เอง หรือ

(๓) ดำเนินงานตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมในลักษณะที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องหรือมีประชาชนที่ได้รับประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นมากกว่า ๑ แห่งขึ้นไป หรือ

(๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร้องขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานแทน

ข้อ ๗ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ให้ใช้จ่ายตามที่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยองอนุมัติ ดังต่อไปนี้

(๑) สนับสนุนและส่งเสริมแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม รวมทั้งแผนการดูแลรายบุคคลสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กร หรือกลุ่มประชาชนในจังหวัด เพื่อส่งเสริมประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่เข้าถึงการบริการสาธารณสุขและการแก้ปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆ ที่จำเป็นได้มากขึ้น

(๒) สนับสนุนและส่งเสริมโครงการด้านพัฒนาศักยภาพ การมีส่วนร่วม และวิชาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชนในจังหวัด เพื่อให้การบริการสาธารณสุขและการแก้ปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆ ที่จำเป็นในพื้นที่ให้มีศักยภาพและเข้มแข็งมากขึ้น

(๓) สนับสนุน...

(๓) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชนในจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือกับโรคติดต่อ หรือภัยธรรมชาติ หรือภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและสังคม ที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่

(๔) สนับสนุนและส่งเสริมแผนงาน หรือโครงการ ในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหรือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงิน ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๙ ข้อ ๗ (๑) และข้อ ๗ (๒) ในแต่ละปีงบประมาณนั้น และกรณีมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อจัดหาครุภัณฑ์หรือจัดจ้างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ให้สนับสนุนได้ในวงเงินตามความจำเป็น และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น

(๕) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขอื่นตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมอบหมาย

(๖) ทั้งนี้ เงินกองทุนที่ได้รับการอนุมัติ หากต้องจัดหาครุภัณฑ์เพื่อจัดบริการสาธารณสุขให้กับบุคคล คณะกรรมการกองทุนอาจพิจารณาสนับสนุนได้ในวงเงินตามความจำเป็น เว้นแต่กรณีองค์กรหรือกลุ่มประชาชนอาจสนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกินสองหมื่นบาทต่อโครงการตามความจำเป็นและเหมาะสม และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้เป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน ที่ได้รับการสนับสนุน

(๗) การพิจารณาเงินกองทุน คณะกรรมการกองทุนสามารถเชิญผู้แทนหน่วยงานหรือบุคคลต่างๆ ทั้งในภาครัฐบาลและภาคประชาสังคม มาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนได้

ข้อ ๘ การรายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าให้คณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ทราบ

ข้อ ๙ วิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทำบัญชี และการรายงานของกองทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อ ๑๐ ให้ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายปิยะ ปิตุเตชะ)
ประธานกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การสนับสนุนงบประมาณ
กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง
พ.ศ. 2569

เอกสารแนบท้าย (๑)

ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๙

หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าใช้จ่าย ที่สนับสนุนและส่งเสริมแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม รวมทั้งแผนการดูแลรายบุคคลสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชนในจังหวัด เพื่อส่งเสริมประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่เข้าถึงการบริการสาธารณสุขและการแก้ปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆ ที่จำเป็นได้มากขึ้น (ตามประกาศ ข้อ ๑๑ (๑)) โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง มีแนวทางดังนี้

๑. ประเภทการสนับสนุน

๑.๑ การสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

๑.๒ การสนับสนุนการป้องกันโรค

๑.๓ การสนับสนุนการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก

๒. หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง

๒.๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด สามารถขอรับงบประมาณตามความจำเป็นเหมาะสม ตามที่คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติ

๒.๒ โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป สามารถขอรับงบประมาณตามความจำเป็นเหมาะสม ในวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อครั้ง

๒.๓ โรงพยาบาลชุมชน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สามารถขอรับงบประมาณตามความจำเป็นเหมาะสม ในวงเงินไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อครั้ง

๒.๔ หน่วยบริการระดับปฐมภูมิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และองค์กรหรือกลุ่มประชาชน สามารถขอรับงบประมาณตามความจำเป็นเหมาะสม ในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อครั้ง

หมายเหตุ

(๑) กรณีหน่วยงานมีความจำเป็นต้องจัดโครงการ เกินวงเงินที่กำหนด ให้คณะกรรมการกองทุน เป็นผู้พิจารณาอนุมัติตามความจำเป็นและเหมาะสม

(๒) กรณีหน่วยงานมีความประสงค์จะขอรับสนับสนุนงบประมาณครั้งถัดไป หน่วยงานนั้นๆ จะต้องส่งรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว มายังกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ให้เรียบร้อยก่อนจะยื่นของบประมาณครั้งถัดไป

๓. อัตรา...

๓. อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ลำดับ	ประเภท/รายการ	หน่วย	ราคากลางต่อหน่วย (บาท)	หมายเหตุ
๑	อัตราการเบิกจ่ายค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม			
	๑.๑ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม (รัฐบาล)	คน	ไม่เกิน ๓๕ บาท	
	๑.๒ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม (เอกชน)	คน	ไม่เกิน ๕๐ บาท	
๒	อัตราการเบิกจ่ายค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม			
	๒.๑ ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม (รัฐบาล)	คน	ไม่เกิน ๘๐ บาท	
	๒.๒ ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม (เอกชน)	คน	ไม่เกิน ๒๕๐ บาท	
๓	อัตราการเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร			
	๓.๑ วิทยากร (รัฐบาล)	ชั่วโมง	ไม่เกิน ๖๐๐ บาท	
	๓.๒ วิทยากร (เอกชน)	ชั่วโมง	ไม่เกิน ๑,๒๐๐ บาท	
๔	อัตราค่าวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		ตามความจำเป็น เหมาะสม	
๕	อื่น ๆ เช่น สื่อประชาสัมพันธ์		ตามความจำเป็น เหมาะสม	

๔. การรายงานผล

๔.๑ รายงานผลการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์มที่กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยองกำหนด

๔.๒ รายละเอียดค่าใช้จ่าย (รายรับ-รายจ่าย)

๔.๓ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เช่น หนังสือเชิญวิทยากร, หนังสือตอบรับจากวิทยากร, ใบสำคัญรับเงินค่าวิทยากร, แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, การจัดซื้อจัดจ้าง, ใบสำคัญรับเงิน, ใบเสร็จรับเงิน, ใบส่งของ, สำเนาบัตรประจำตัวหรือเอกสารของผู้รับเงิน (เอกสารร้านค้า) เป็นต้น

๔.๔ เอกสารใบลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม

๔.๕ ภาพถ่ายกิจกรรม เช่น รูปพิธีเปิด, วิทยากรบรรยาย, รูปป้ายโครงการ, รูปผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด, รูปกิจกรรมออกเยี่ยม, รูปกิจกรรมรณรงค์, รูปอาหารว่างเช้า-บ่ายและรูปอาหารกลางวัน, รูปในโครงการ/กิจกรรมจะต้องเป็นรูปปัจจุบันเท่านั้น ไม่น้อยกว่า ๑๐ ภาพ

๔.๖ อื่น ๆ เช่น แบบทดสอบก่อน-หลังการอบรม แบบประเมินคะแนน (ถ้ามี)

ตัวอย่าง

แบบฟอร์มโครงการขอรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง

(โครงการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก)

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๙ ข้อ ๒๑ (๒) ให้คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจหน้าที่ “ให้พิจารณาอนุมัติแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม รวมทั้งแผนดูแลรายบุคคลสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ” ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ตามประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติฯ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑

จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ชื่อ ☐ **แผนงาน** ☐ **โครงการ** ☐ **กิจกรรม**

.....

๒. ชื่อ ☐ **หน่วยงาน** ☐ **องค์กร** ☐ **กลุ่มประชาชน**

.....

๓. หลักการและเหตุผล (สาเหตุและความจำเป็นต้องมีโครงการ)

สถานการณ์ของปัญหาสุขภาพในพื้นที่ ขนาดของปัญหาสุขภาพในพื้นที่ .....

.....

จึงมีความจำเป็นต้องจัดแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม.....ให้แก่ (กลุ่มเป้าหมาย) จำนวน.....คน เพื่อ .....

๔. วัตถุประสงค์ (แสดงความต้องการให้เกิดอะไร เพื่อประโยชน์ของประชาชนในจังหวัดที่ขอรับเงินกองทุนฯ)

๑.....

๒.....

๕. กลุ่มเป้าหมาย

.....

๖. วิธีดำเนินการ (การให้รายละเอียดในการดำเนินการ ทำอย่างไรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงระเบียบ ข้อบังคับหลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงิน)

๑.....

๒.....

๗. ระยะเวลาดำเนินการ (ควรมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการ)

.....

๘. สถานที่ดำเนินการ (ควรระบุสถานที่ให้ชัดเจน)

.....

๙. งบประมาณ (ให้สอดคล้องกับวิธีการดำเนินการ)

ขอรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง จำนวนเงิน.....บาท (.....)

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนด)

๑.....

๒.....

๑๑. คำรับรอง...

๑๑. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ

ข้าพเจ้า.....(ชื่อ-สกุล).....ตำแหน่ง.....
หน่วยงาน.....หมายเลขโทรศัพท์.....
ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.....
ขอรับรองว่าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม..... ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ในครั้งนี้

☐ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น และเพื่อให้การจ่ายเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม่ซ้ำซ้อนกับการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ ให้พิจารณาดำเนินงาน ดังนี้

☐ ดำเนินงานในโครงการขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

☐ ดำเนินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่เป็นภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดสามารถดำเนินการได้เอง

☐ ดำเนินงานตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมในลักษณะที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องหรือมีประชาชนที่ได้รับประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นมากกว่า ๑ แห่งขึ้นไป

☐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร้องขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานแทน

☐ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงาน ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๙ และตามระเบียบระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๙

๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล:.....ตำแหน่ง:.....
สถานที่ติดต่อ:.....โทรศัพท์:.....E-mail:.....

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(.....)
ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
(.....)
ประธานอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
(.....)
ประธานกรรมการกองทุนหลักประสุขภาพจังหวัดระยอง

<u>หมายเหตุ</u> : ผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง จะต้องเขียนโครงการให้ละเอียดเพื่อให้คณะกรรมการกองทุน พิจารณาว่าเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๙

(แบบประมาณการค่าใช้จ่าย)

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายแนบท้าย

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.....

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
๑		
๒		
๓		
๔		
๕		
๖		
๗		
๘		
๙		
๑๐		
๑๑		
๑๒		
๑๓		
๑๔		
๑๕		
รวม		

(ตัวหนังสือ) (..... ....)

<u>หมายเหตุ</u> ผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง จะต้องแสดงรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อให้ให้คณะกรรมการกองทุน พิจารณาว่าเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๙ และความจำเป็นเหมาะสมในการใช้งบประมาณกองทุน

ตัวอย่างแบบรายงานผลการดำเนินโครงการ

โครงการ.....

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....

รายงาน ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

๑. ชื่อหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณกองทุนฯ :.....

๒. งบประมาณ

๒.๑ งบประมาณโครงการที่ได้รับ.....บาท (.....)

๒.๒ งบประมาณที่ได้ใช้ไปในการดำเนินงานโครงการ.....บาท (.....)

๒.๓ งบประมาณคงเหลือ.....บาท (.....) (ถ้ามี)

๓. ผลการดำเนินการ

๓.๑ ผู้ได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ขอรายงานผลการดำเนินโครงการ ตามบันทึกข้อตกลงการรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง เลขที่...../วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....และเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่...เดือน.....พ.ศ.....

๓.๒ ผู้ได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ขอส่งสำเนาเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานอื่น จำนวน..... ฉบับ จำนวนเงิน.....บาท (.....) ของการดำเนินการตามโครงการที่ได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง มาพร้อมหนังสือฉบับนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อไป

๓.๓ ผู้ได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ขอส่งเงินงบประมาณคงเหลือ (ถ้ามี) จำนวน.....บาท มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

๓.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ (เขียนให้เห็นว่าเกิดประโยชน์กับประชาชนในเขตพื้นที่อย่างไร)

.....

.....

๔. ผู้ได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ เนื่องจาก..... จึงขอส่งเงินคืน จำนวน.....บาท (.....) มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

๕. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

☐ ไม่มี

☐ มี

ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ).....

แนวทางการแก้ไข (ระบุ).....

๖. เอกสารประกอบการรายงานผลการดำเนินแผนงาน

☐ ภาพถ่าย

☐ อื่น ๆ ระบุ.....

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน (ผู้ได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง)

(.....)

ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ : กรณีองค์กรหรือกลุ่มประชาชน ลงนามไม่น้อยกว่า จำนวน ๓ คน

เอกสารแนบท้าย (๒)

ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๙

หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าใช้จ่าย ที่สนับสนุนและส่งเสริมแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม รวมทั้งแผนการดูแลรายบุคคลสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชนในจังหวัด เพื่อส่งเสริมประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่เข้าถึงการบริการสาธารณสุขและการแก้ปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆ ที่จำเป็นได้มากขึ้น (ตามประกาศ ข้อ ๑๑ (๑)) โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง มีแนวทางดังนี้

๑. ประเภทการสนับสนุนการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

- โครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน

๒. หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน สามารถขอรับงบประมาณตามความจำเป็นเหมาะสม ในวงเงินไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อครั้ง

- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หน่วยบริการระดับปฐมภูมิ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สามารถขอรับงบประมาณตามความจำเป็นเหมาะสม ในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อครั้ง

หมายเหตุ

(๑) กรณีหน่วยงานมีความจำเป็นต้องจัดโครงการ เกินวงเงินที่กำหนด ให้คณะกรรมการกองทุน เป็นผู้พิจารณาอนุมัติตามความจำเป็นและเหมาะสม

(๒) กรณีหน่วยงานมีความประสงค์จะขอรับสนับสนุนงบประมาณครั้งถัดไป หน่วยงานนั้นๆ จะต้องส่งรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว มายังกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ให้เรียบร้อยก่อนจะยื่นของบประมาณครั้งถัดไป

๓. กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ

๓.๑ คนพิการ

๓.๒ ผู้สูงอายุ

๓.๓ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน (Intermediate Care: IMC)

๓.๔ ผู้ป่วยระยะท้าย (Palliative Care)

๓.๕ ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

<u>หมายเหตุ</u> **:** กลุ่มเป้าหมายต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรืออาศัยในจังหวัดระยอง ต้องได้รับการประเมินความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ตามวินิจฉัยของแพทย์ นักกายภาพบำบัด หรือพยาบาลวิชาชีพ (Care Manager)

๔. การประเมิน...

๔. การประเมินและคัดกรอง

คุณสมบัติผู้ยืม

(๑) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรืออาศัยในพื้นที่จังหวัดระยอง

(๒) มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ตามการวินิจฉัยของแพทย์ นักกายภาพบำบัด หรือพยาบาลวิชาชีพ (Care Manager)

(๓) ผู้ยืมหรือญาติยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของศูนย์ฯ

๕. ขั้นตอนการดำเนินงาน

๕.๑ การจัดตั้งและจัดหา

(๑) หน่วยงานเสนอโครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านต่อกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง

(๒) เมื่อได้รับอนุมัติ ดำเนินการจัดซื้อและลงทะเบียนครุภัณฑ์ (ทำทะเบียนคุมทรัพย์สินให้ชัดเจน)

๕.๒ การให้บริการยืม

(๑) ประเมินความจำเป็นของผู้ป่วยตามวินิจฉัยของแพทย์ นักกายภาพบำบัด หรือพยาบาลวิชาชีพ (Care Manager)

(๒) ทำสัญญาผู้ป่วย/ญาติ ยื่นบัตรประชาชน ทำสัญญาการยืม (MOU) จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง และผู้ยืมหรือญาติยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของศูนย์สาธิตฯ

(๓) ส่งมอบ/สอน/สาธิต อุปกรณ์

(๔) ต้องส่งคืนเมื่อ: ผู้ป่วยเสียชีวิต, หายป่วย/เลิกใช้, ย้ายภูมิลำเนา, หรือทำผิดเงื่อนไข

๕.๓ การติดตาม

(๑) เจ้าหน้าที่หรือ อสม. ติดตามเยี่ยมบ้าน ดูสภาพการใช้งานอุปกรณ์และอาการผู้ป่วย

(๒) หากอุปกรณ์ชำรุด ให้แจ้งศูนย์เพื่อนำกลับมาซ่อมแซม

๕.๔ การรับคืนและฟื้นฟูสภาพ

(๑) เมื่อนำส่งคืน ให้ศูนย์ฯ ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์

(๒) ทำความสะอาด/ฆ่าเชื้อ ต้องผ่านกระบวนการทำความสะอาดตามมาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ

(๓) หากชำรุด ให้ดำเนินการซ่อมแซมให้พร้อมการใช้งาน

(๔) นำเข้าระบบ ลงบันทึกรับคืน และเตรียมพร้อมให้รายต่อไปยืม

๕.๕ การบริหารจัดการทรัพย์สินของศูนย์สาธิตฯ

(๑) ทะเบียนคุม ศูนย์ยืม - คืน ต้องจัดทำทะเบียนคุมรายการอุปกรณ์ทั้งหมด (สถานะ: ว่าง, ถูกยืม, ส่งซ่อม, จำหน่ายออก)

(๒) ความเป็นเจ้าของ ให้ถือว่าอุปกรณ์ที่จัดซื้อเป็นทรัพย์สินของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ แต่ต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะตามโครงการเท่านั้น

(๓) การโอนย้ายครุภัณฑ์ กรณียืมนอกเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ให้ดำเนินการโอนย้ายครุภัณฑ์ตามระเบียบพัสดุไปยังพื้นที่นั้น เพื่อกำกับติดตามการใช้งานของครุภัณฑ์นั้น และรายงานให้กองทุนฯ ทราบ

(๔) การจำหน่าย กรณีอุปกรณ์ชำรุดจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ ให้ดำเนินการจำหน่ายออกจากบัญชีตามระเบียบพัสดุ และรายงานให้กองทุนฯ ทราบ

(๕) ศูนย์ยืม – คืน...

(๕) ศูนย์ยืม - คืน รายงานสถานการณ์หมุนเวียนอุปกรณ์ (จำนวนผู้ยืม, จำนวนอุปกรณ์คงเหลือ) ให้กองทุนฯ ทราบ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

(๖) คณะกรรมการกองทุนฯ ลงพื้นที่สุ่มตรวจเยี่ยมศูนย์ เพื่อดูความพร้อมของสถานที่ของการจัดเก็บอุปกรณ์

(๗) ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และความคุ้มค่าของงบประมาณ (Cost-Benefit Analysis) เทียบกับการที่ผู้ป่วยต้องซื้อเอง

๖. การรายงานผล

๖.๑ รายงานผลการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์มที่กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยองกำหนด

๖.๒ รายละเอียดค่าใช้จ่าย (รายรับ-รายจ่าย)

๖.๓ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง, ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ, ใบสำคัญรับเงิน, ใบเสร็จรับเงิน, ใบส่งของ, สำเนาบัตรประจำตัวหรือเอกสารของผู้รับเงิน (เอกสารร้านค้า) เป็นต้น

๖.๔ ภาพถ่ายกิจกรรม เช่น รูปป้ายโครงการ, รูปกิจกรรมมอบอุปกรณ์/ออกเยี่ยมบ้าน, รูปในโครงการ/กิจกรรมจะต้องเป็นรูปปัจจุบันเท่านั้น ไม่น้อยกว่า ๑๐ ภาพ

๖.๕ รายงานสถานะรายการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ (คงเหลือ) ตามแบบฟอร์มและเงื่อนไขที่กองทุนฯ กำหนด

๖.๖ อื่นๆ เช่น แบบประเมินความพึงพอใจ (ถ้ามี)

๗. รายการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่สามารถขอรับการสนับสนุน มีดังนี้

ลำดับ	รายการ	รายละเอียด	หน่วย	ราคาไม่เกิน (บาท)
๑	ไม้ค้ำยันรักแร้แบบอลูมิเนียม	**ลักษณะ:** ไม้ค้ำยันความสูงจากระดับรักแร้ถึงพื้น ส่วนค้ำยันทำจากอลูมิเนียม ความหนาของอลูมิเนียมไม่ต่ำกว่า ๑.๒ มม. มีที่มือจับอยู่ระหว่างกลาง มีลูกยางกันลื่น **ข้อบ่งชี้:** สำหรับคนพิการหรือผู้ที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหว มีข้อห้ามในการลงน้ำหนักที่ขาข้างใดข้างหนึ่งหรือมีอาการขาอ่อนแรง หรือมีการทรงตัวขณะเดินไม่ดี และที่มีน้ำหนักตัวมาก หรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เวลาฟื้นฟูสภาพนาน **อายุการใช้งาน:** ไม่น้อยกว่า ๑ ปี	คู่ละ	๖๕๐
๒	ไม้เท้าอลูมิเนียมแบบสามขา	**ลักษณะ:** ไม้เท้าทำจากอลูมิเนียม ปลายขาส่วนล่างที่สัมผัสพื้นมีจุดสัมผัสพื้นตั้งแต่ ๓ จุดขึ้นไป มีลูกยางกันลื่น **ข้อบ่งชี้:** สำหรับคนพิการหรือผู้ที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหวที่สามารถเดินได้ แต่มีข้อห้ามในการลงน้ำหนักที่ขาข้างใดข้างหนึ่งหรือมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงครึ่งซีก หรือมีการทรงตัวขณะเดินไม่ดี **อายุการใช้งาน:** ไม่น้อยกว่า ๑ ปี	อันละ	๖๐๐

ลำดับ...

ลำดับ	รายการ	รายละเอียด	หน่วย	ราคาไม่เกิน (บาท)
๓	ไม้เท้าสำหรับคนตาบอดพับได้	**ลักษณะ:** ไม้เท้าก้านยาวทำจากวัสดุโลหะ อลูมิเนียม หรือสแตนเลส สามารถพับเก็บได้ **ข้อบ่งชี้:** สำหรับคนพิการทางการมองเห็น **อายุการใช้งาน:** ไม่น้อยกว่า ๑ ปี	อันละ	๕๐๐
๔	ไม้ค้ำยันรักแร้แบบไม้	**ลักษณะ:** ไม้ค้ำยันความสูงจากระดับรักแร้ถึงพื้น ส่วนค้ำยันทำจากไม้ มีที่มือจับอยู่ระหว่างกลาง มีลูกยางกันลื่น **ข้อบ่งชี้:** สำหรับคนพิการหรือผู้ที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหว ที่มีข้อห้ามในการลงน้ำหนักที่ขาข้างใดข้างหนึ่งหรือมีอาการขาอ่อนแรง หรือมีการทรงตัวขณะเดินไม่ดี **อายุการใช้งาน:** ไม่น้อยกว่า ๑ ปี	คู่ละ	๓๕๐
๕	รถเข็นนั่งชนิดพับได้ทำด้วยโลหะแบบปรับให้เหมาะสม	**ลักษณะ:** เป็นอุปกรณ์สำหรับการเคลื่อนที่ด้วยล้อ มีโครงสร้างหลักผลิตจากโลหะสแตนเลส อลูมิเนียมอัลลอยด์หรือโลหะอื่นที่ผ่านกระบวนการชุบ หรือพ่นสี สามารถพับเก็บได้และสามารถปรับส่วนต่างๆ ให้เข้ากับขนาดร่างกายของผู้ใช้งานได้ **ข้อบ่งชี้**: สำหรับคนพิการหรือผู้ที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหว **อายุการใช้งาน:** ไม่น้อยกว่า ๓ ปี	คันละ	๖,๖๐๐ (ราคานี้รวมค่าบริการซ่อมบำรุงพื้นฐานและวัสดุตามอายุการใช้งาน)
๖	รถเข็นนั่งชนิดพับได้ทำด้วยโลหะแบบปรับไม่ได้	**ลักษณะ:** เป็นอุปกรณ์สำหรับการเคลื่อนที่ด้วยล้อมีโครงสร้างหลักผลิตจากโลหะสแตนเลส อลูมิเนียมอัลลอยด์หรือโลหะอื่น ที่ผ่านกระบวนการชุบหรือพ่นสี สามารถพับเก็บได้ **ข้อบ่งชี้:** สำหรับคนพิการหรือผู้ที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหว **อายุการใช้งาน:** ไม่น้อยกว่า ๓ ปี	คันละ	๔,๔๐๐ (ราคานี้รวมค่าบริการซ่อมบำรุงพื้นฐานและวัสดุตามอายุการใช้งาน)
๗	เบาะรองนั่งสำหรับผู้ป่วย	**ลักษณะ:** ทำจากวัสดุนิ่มที่มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่า poly urethane foam, gel cushion, water cushion หรือชนิด air cushion ที่มีลักษณะนิ่ม สามารถกระจายน้ำหนัก **ข้อบ่งชี้:** ใช้สำหรับคนพิการหรือผู้ที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหว ที่จำเป็นต้องนั่งนาน แต่ยังสามารถช่วยเหลือตนเองได้บ้าง **อายุการใช้งาน:** ๑ ปี	อันละ	๘๐๐

ลำดับ...

ลำดับ	รายการ	รายละเอียด	หน่วย	ราคาไม่เกิน (บาท)
๘	รถสามล้อโยกมาตรฐาน	**ลักษณะ:** เป็นอุปกรณ์สำหรับการเคลื่อนที่ในระยะไกล โครงสร้างหลักทำด้วยเหล็กชุบสี หรือโลหะอื่นที่มีความแข็งแรงมั่นคง ขับเคลื่อนโดยการควบคุมก้านโยก **ข้อบ่งชี้:** สำหรับคนพิการหรือผู้ที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหวที่ทรงตัวในท่านั่งได้ดี แขน ๒ ข้างปกติ และสามารถออกนอกบ้าน เพื่อการเข้าสู่สังคมหรือการประกอบอาชีพ **อายุการใช้งาน:** ๓ ปี	คันละ	๖,๐๐๐ (ราคานี้รวมค่าบริการซ่อมบำรุงพื้นฐานและวัสดุตามอายุการใช้งาน)
๙	แผ่นรองตัวสำหรับผู้ป่วย	**ลักษณะ:** เป็นแผ่นสำหรับรองบนที่นอน ทำจากวัสดุนิ่มที่มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่า poly urethane foam, gel, water, air สามารถกระจายแรงกดทับได้ดี และสามารถรองรับร่างกายผู้ใช้งานได้ **ข้อบ่งชี้:** สำหรับคนพิการระดับรุนแรง หรือผู้ป่วยที่นอนติดเตียงไม่สามารถพลิกตัวเพื่อเปลี่ยนท่านอนเองได้และมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ **อายุการใช้งาน:** ๑ ปี	อันละ	๑,๐๐๐
๑๐	เตียงฝึกยืนสำหรับเด็ก	**ลักษณะ:** สำหรับเด็กสมองพิการ (Cerebral Palsy: C.P.) กลุ่มอาการผู้ป่วยเด็กที่มีความพิการอย่างถาวรของสมอง ความพิการนี้จะคงที่และไม่ลุกลามต่อไป ซึ่งมีผลให้การประสานงานของการทำงานของกล้ามเนื้อบกพร่อง ส่งผลให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวและการทรงท่าที่ผิดปกติ **ข้อบ่งชี้:** สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถยืน เดินได้ด้วยตนเอง ผู้ที่นอนติดเตียงเป็นเวลานาน ผู้ที่มีภาวะกล้ามเนื้อขาหดสั้นยืดออกได้ไม่สุดช่วงการเคลื่อนไหว ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู **อายุการใช้งาน:** ๑๐ ปี	เตียงละ	๒๕,๐๐๐
๑๑	รถเข็นแบบชนิดเบา	**ลักษณะ:** เป็นรถเข็นนั่งสำหรับผู้พิการ บาดเจ็บไขสันหลัง ตั้งแต่หน้าอกลงไปที่มีช่วงขายาว ผู้ป่วยขาอ่อนแรง ๒ ขา **ข้อบ่งชี้:** ผู้พิการ บาดเจ็บไขสันหลัง ตั้งแต่หน้าอกลงไปที่มีช่วงขายาว ผู้ป่วยขาอ่อนแรง ๒ ขา ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ไม่สามารถยืนเดินได้ด้วยตนเอง จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู **อายุการใช้งาน:** ๘ ปี	อันละ	๒๐,๐๐๐

ลำดับ...

ลำดับ	รายการ	รายละเอียด	หน่วย	ราคาไม่เกิน (บาท)
๑๒	รถเข็นนั่ง ปรับเอนได้	**ลักษณะ:** รถเข็นผู้ป่วยปรับเอนได้ เหมาะสำหรับผู้ป่วยพิการตั้งแต่กำเนิด การเดินหรือเคลื่อนย้ายทำได้ลำบาก หรือผู้ป่วยที่ไม่สามรถนั่งตัวตั้งตรงได้ จะมีที่รองถ่ายให้ในตัว สะดวกสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วย **ข้อบงชี้:** ผู้ป่วยที่มีขาพิการทั้ง ๒ ข้าง พิการตั้งแต่กำเนิดเดินไม่ได้ เท้าทั้ง ๒ ผิดรูป หรือเป็นผู้ป่วยที่นอนนานจนหลังติดแข็ง เป็นผู้ป่วยที่ต้องกลับมารักษาและใช้ชีวิตอยู่ที่บ้าน จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เพื่อช่วยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รวมถึงการบำบัดสภาพจิตใจในขณะที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยสู่โลกภายนอก **อายุการใช้งาน:** ๘ ปี	อันละ	๒๐,๐๐๐
๑๓	ที่นอนลม แบบลอน (ใหญ่)	**ลักษณะ:** สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้ที่ต้องนอนนาน ๆ นอนตลอดเวลา นอนเป็นส่วนใหญ่ ลดอาการมีแผลกดทับ ทำให้สบายตัว ที่นอนลมจะช่วยกระจายน้ำหนักของร่างกายผู้ที่นอน มิให้น้ำหนักกดลงเฉพาะจุดจุดใดจุดหนึ่ง **ข้อบงชี้:** ให้สำหรับป้องกันแผลกดทับจากการนอนของผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยที่อยู่ในระยะฟื้นฟู **อายุการใช้งาน:** ๓ ปี	อันละ	๖,๙๐๐
๑๔	ที่นอนลม แบบรังผึ้ง	**ลักษณะ:** ช่วยสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการนอนนาน ๆ ลดแรงกดทับ และกระจายแรงกดทับไปทั่วร่างกาย ลดแรงเสียดสีระหว่างที่นอนและผิวของผู้ป่วย อันจะช่วยลดสาเหตุของการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ และผู้ป่วยที่เกิดแผลกดทับแล้ว **ข้อบ่งชี้:** ใช้ป้องกันแผลกดทับจากการนอนของคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยที่อยู่ในระยะฟื้นฟู **อายุการใช้งาน:** ๓ ปี	อันละ	๖,๙๐๐
๑๕	เบาะรองนั่ง ป้องกันแผลกดทับ	**ลักษณะ:** ช่วยกระจายแรงกดทับ ทำให้แรงกระทำบริเวณก้นผู้ป่วยในระหว่างนั่งเกิดการกระจายตัว ลดปัญหาแรงที่กดทับบริเวณจุดใดจุดหนึ่งมากเกินไปส่งผลให้เกิดแผลกดทับ **ข้อบ่งชี้:** สำหรับผู้พิการหรือผู้ที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหวที่ต้องนั่งรถเข็น นั่งเก้าอี้ เป็นเวลานานๆ ลดภาวะเสี่ยงของการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วย **อายุการใช้งาน:** ๕ ปี	อันละ	๑๕,๐๐๐

ลำดับ...

ลำดับ	รายการ	รายละเอียด	หน่วย	ราคาไม่เกิน (บาท)
๑๖	ที่นั่งสำหรับถ่ายและอาบน้ำได้	**ลักษณะ:** สำหรับคนพิการหรือผู้ที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหวนั่งสำหรับถ่ายและอาบน้ำ **ข้อบ่งชี้:** ผู้ป่วยพิการขาขาดทั้งสองข้าง ไม่มีขาเทียม ข้อเข่ายึดติดกัน อัมพาตท่อนล่าง หรือผู้ที่มีปัญหาในการทรงตัว การเคลื่อนไหวลำบาก **อายุการใช้งาน:** ๕ ปี	อันละ	๕,๐๐๐
๑๗	Push up box	**ลักษณะ:** เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแขนให้แข็งแรง **ข้อบ่งชี้:** ผู้พิการ และผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตที่ขาทั้งสองข้าง **อายุการใช้งาน:** - ปี	ชุดละ	๓,๐๐๐
๑๘	เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด ๕ ลิตร	**ลักษณะ:** เป็นเครื่องผลิตออกซิเจนที่แยกออกซิเจนออกจากอากาศในห้อง สำหรับใช้งานที่บ้าน สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการหายใจ ผู้ป่วยที่มีปัญหาพร่องออกซิเจนต่ำกว่า ร้อยละ ๙๕ เมื่อหายใจ room air **ข้อบ่งชี้:** ผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องออกซิเจนแบบไม่รุนแรง เช่น มีภาวะปอดแฟบ มะเร็งปอด มะเร็งที่คอ ถุงลมโป่งพอง หอบหืด มีปัญหาปอดในการหายใจไม่รุนแรงมากนัก **อายุการใช้งาน:** ๕ ปี	อันละ	๒๐,๐๐๐
๑๙	เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด ๑๐ ลิตร	**ลักษณะ:** เป็นเครื่องผลิตออกซิเจนที่แยกออกซิเจนออกจากอากาศในห้อง สำหรับใช้งานที่บ้าน สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการหายใจ ผู้ป่วยที่มีปัญหา **ข้อบ่งชี้:** ผู้ป่วยมีลักษณะอาการที่ปอด อาทิ เช่น มะเร็งหลอดอาหารแพร่กระจายไปที่ปอด มีภาวะปอดแฟบ มะเร็งปอด มะเร็งที่คอ หรือมีลักษณะที่แสดงอาการเหนื่อยตลอดเวลา ต้องใช้ยาพ่นช่วย ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่มีอาการภาวะพร่องออกซิเจนแบบรุนแรงหรือผู้ป่วยระยะสุดท้าย **อายุการใช้งาน:** ๕ ปี	อันละ	๓๕,๐๐๐

ลำดับ...

ลำดับ	รายการ	รายละเอียด	หน่วย	ราคาไม่เกิน (บาท)
๒๐	เครื่องดูดเสมหะ (SUCTION)	**ลักษณะ:** เป็นเครื่องดูดเสมหะชนิดหิ้วสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย ตัวเครื่องน้ำหนักรวมไม่เกิน ๑๘ ปอนด์หรือ ๙ กิโลกรัม Compressor เป็นชนิด Diaphragm Rotary หรือ Piston มีมาตรวัดความดันได้ตั้งแต่ ๐-๐.๘ บาร์หรือไม่น้อยกว่า ๐-๕๖๐ มิลิเมตรปรอท(mmHg) มีปุ่มปรับแรงดูด สามารถปรับสูงสุดได้ ๕๖๐ มิลิเมตรปรอท มีขวดบรรจุเสมหะและระบบป้องกันเสมหะในขวดล้นเข้าเครื่อง **ข้อบ่งชี้:** เพื่อกำจัดเสมหะในหลอดลมผู้ป่วยที่ไม่สามารถกำจัดออกไปเองได้ด้วยการไอ และมีเสมหะปริมาณมาก ลักษณะเสมหะเหนียว **อายุการใช้งาน:** - ปี	เครื่องละ	๑๑,๘๐๐
๒๑	ไม้เท้า ๑ ปุ่ม	**ลักษณะ:** เป็นไม้เท้าปุ่มเดียววัสดุทำจากอลูมิเนียม มีน้ำหนักเบา สามารถปรับระดับสูงต่ำได้ ๗๑-๙๔ เซนติเมตร ด้ามจับหุ้มด้วยยางเพื่อกันลื่น ส่วนปลายหุ้มด้วยจุกยางที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ **ข้อบ่งชี้:** เป็นอุปกรณ์เสริมช่วยเพิ่มความมั่นคงในขณะยืน เดิน ป้องกันการล้ม เหมาะสำหรับผู้ป่วยอ่อนแรงครึ่งซีกหรือครึ่งท่อน ผู้ที่มีกำลังขาอ่อนแรง **อายุการใช้งาน:** - ปี	อันละ	๑๙๐
๒๒	เตียงผู้ป่วยสามไกร์ ราวสไลด์ พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ	**ลักษณะ:** เป็นเตียงผู้ป่วยชนิดทำงานด้วยระบบมือหมุน สามารถควบคุมการปรับท่าต่าง ๆ ของเตียงด้วยระบบหมุนที่ปลายเตียง พนักหัวเตียงและท้ายเตียง สามารถถอดประกอบได้สะดวก มีที่กันชนทุกมุมทั้งเตียงและท้ายเตียง ช่วยป้องกันไม่ให้เตียงเสียหายจากการชนกระแทก รวมกั้นข้างเตียงเป็นอลูมิเนียม หรือวัสดุใกล้เคียง หรือดีกว่าแบบสไลด์ขึ้น - ลง มีปุ่มล็อค และมีเสาน้ำเกลือสามารถติดตั้งที่มุมเตียงได้ทั้ง ๔ ด้าน **ข้อบ่งชี้:** ให้เป็นเตียงนอนสำหรับผู้ป่วย หรืออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันแก่ผู้ที่มีข้อจำกัดทางร่างกาย **อายุการใช้งาน:** - ปี	เตียงละ	๒๗,๐๐๐

ลำดับ...

ลำดับ	รายการ	รายละเอียด	หน่วย	ราคาไม่เกิน (บาท)
๒๓	เครื่องช่วยเดิน ชนิด ๔ ขา (Walker)	**ลักษณะ:** ทำจากอลูมิเนียม มีขา ๔ ขา น้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน สามารถรับน้ำหนักได้ดี ปลอกมือจับทำด้วยพลาสติกหรือยาง ที่แน่นกระชับกับโครง ไม่เลื่อนหลุดง่าย มีลูกยางคุณภาพดีที่มีความเหนียวยืดหยุ่นไม่ฉีกขาดง่ายสามที่ปลายฐานสัมผัสพื้น **ข้อบ่งชี้:** ให้กับผู้ที่มีปัญหาการทรงตัวไม่ดี ผู้ที่ขาอ่อนแรงหรือทรงตัวขณะเดินไม่ได้ เพื่อค้ำยันพยุงขาและลำตัว เพิ่มความมั่นคงในขณะยืน เดิน ป้องกันการล้ม **อายุการใช้งาน:** - ปี	อันละ	๗๐๐
๒๔	เครื่องช่วยเดิน ชนิด ๔ ขา (Walker) แบบปรับระดับได้	**ลักษณะ:** ทำจากอลูมิเนียม หรือวัสดุใกล้เคียง หรือดีกว่า มีขา ๔ ขา สามารถพับได้ น้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน สามารถรับน้ำหนักได้ดี ปลอกมือจับทำด้วยพลาสติกหรือยาง ที่แน่นกระชับกับโครงไม่เลื่อนหลุดง่าย มีลูกยางคุณภาพดีที่มีความเหนียวยืดหยุ่นไม่ฉีกขาดง่ายสามที่ปลายฐานสัมผัสพื้น **ข้อบ่งชี้:** ให้กับผู้ที่มีปัญหาการทรงตัวไม่ดี ผู้ที่ขาอ่อนแรงหรือทรงตัวขณะเดินไม่ได้ เพื่อค้ำยันพยุงขาและลำตัว เพิ่มความมั่นคงในขณะยืน เดิน ป้องกันการล้ม **อายุการใช้งาน:** - ปี	อันละ	๒,๐๐๐
๒๕	รายการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการและอุปกรณ์ทางการแพทย์ อื่นๆ สามารถขอรับสนับสนุนงบประมาณได้ โดยให้คณะกรรมการกองทุน เป็นผู้พิจารณาอนุมัติตามความจำเป็นและเหมาะสม			

ตัวอย่าง

แบบฟอร์มโครงการขอรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง

(โครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน)

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๙ ข้อ ๒๑ (๒) ให้คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจหน้าที่ “ให้พิจารณาอนุมัติแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม รวมทั้งแผนดูแลรายบุคคลสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ” ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ตามประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติฯ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑

จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ชื่อ ☐ แผนงาน ☐ โครงการ ☐ กิจกรรม

.....

๒. ชื่อ ☐ หน่วยงาน ☐ องค์กร ☐ กลุ่มประชาชน

.....

๓. หลักการและเหตุผล (สาเหตุและความจำเป็นต้องมีโครงการ) เช่น

ปัจจุบันปัญหาสุขภาพของประชากรในประเทศไทยเปลี่ยนจากโรคติดต่อเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในสังคมไทยประกอบกับ การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และมักตามมาด้วยโรคหลอดเลือดสมอง อาการอัมพฤกษ์ หรืออัมพาต ทำให้มีความพิการตามมา

จากการศึกษาข้อมูลย้อนกลับและแนวทางการดูแลสุขภาพระยะยาว (Long Term Care) ของจังหวัดระยอง พบว่า จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ภายในปี ..... เพิ่มขึ้นร้อยละ ..... ของจำนวนประชากรทั้งหมดยังไม่รวมถึงผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงผู้อื่นในการดูแลสุขภาพ ได้แก่ ผู้มีภาวะพึ่งพิง คนพิการ ผู้ที่มีภาวะทุพพลภาพ อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ซึ่งกลุ่มผู้มีภาวะเหล่านี้มีความยากลำบากในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ขณะเดียวกันก็มีปัญหาในการดำรงชีวิต ทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบบริการการดูแลสุขภาพต่อเนื่องในระยะยาวโดยเฉพาะการเข้าถึงบริการด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ เนื่องจากมีต้นทุนสูงในการเข้าถึงบริการและความยุ่งยากที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมาโรงพยาบาลบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในเขตชนบทที่ไม่มียานพาหนะของตนเอง หรือแม้แต่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในเขตอำเภอ.....ก็ยังเข้าถึงบริการได้น้อย ปัญหาสำคัญจากการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง และดูแลต่อเนื่องที่บ้านที่เกี่ยวกับกายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการ มีสาเหตุ ปัจจัยดังนี้

๑. ความก้าวหน้าทางการแพทย์ทำให้ผู้ป่วยภาวะวิกฤตมีชีวิตรอดเพิ่มขึ้น แต่เปลี่ยนเป็นผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงมากขึ้น

๒. โรงพยาบาลเน้นการดูแลผู้ป่วยระยะเฉียบพลัน แต่ยังขาดการดูแลผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันหรือผู้ป่วย Subacute ในชุมชน

๓. ระบบบริการปฐมภูมิมีข้อจำกัดด้านบุคลากรทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพมีปัญหาด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ เมื่อกลับไปดูแลต่อเนื่องที่บ้าน รวมทั้งขาดการเชื่อมโยงข้อมูลในการดูแลต่อเนื่อง

ปัจจุบันอำเภอ/เทศบาล/อบต.....จังหวัดระยอง ทำงานเชื่อมโยงกับ..... มีประชากรในพื้นที่รวมทั้งสิ้น จำนวน.....คน ดังนี้

(๑) คนพิการ จำนวน.....คน

(๒) ผู้สูงอายุ จำนวน.....คน

(๓) ผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน (IMC) จำนวน.....คน

๔) ผู้ป่วยระยะท้าย (Palliative Care) จำนวน.....คน

(๕) ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน.....คน

ซึ่งกลุ่มคน...

ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้มักมีความจำเป็นต้องได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ แต่เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาแพงประกอบกับผู้ดูแลต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานที่ถูกต้อง

จากที่ผ่านมา .....(ชื่อหน่วยงาน) เคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์ฯ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง มาแล้ว จำนวน ..... ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ..... เดือน..... พ.ศ. ..... เป็นเงิน.....บาท (ว/ด/ป ตามที่ลงนามใน MOU)

ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ..... เดือน..... พ.ศ. ..... เป็นเงิน.....บาท (ว/ด/ป ตามที่ลงนามใน MOU)

ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ..... เดือน..... พ.ศ. ..... เป็นเงิน.....บาท (ว/ด/ป ตามที่ลงนามใน MOU)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ..... บาท โดย ..... (ชื่อหน่วยงาน) ได้จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายพร้อมข้อมูลผู้ที่ได้รับอุปกรณ์ฯ เรียบร้อย ตามเอกสารที่แนบท้ายโครงการนี้ แต่เนื่องจากอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการยังไม่เพียงพอกับความต้องการ ดังนั้น จึงจัดทำโครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ.....เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการเพิ่มเติม และให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพสามารถเข้าถึงบริการ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของหน่วยบริการให้สามารถจัดบริการและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อความจำเป็นของคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน ผู้ป่วยระยะท้าย และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม

๔.๒ เพื่อให้บริการสาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการกับกลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถใช้ฟื้นฟูสมถรรถภาพต่อเนื่องที่บ้านได้

๔.๓ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวผู้ป่วย

๕. กลุ่มเป้าหมาย

คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน ผู้ป่วยระยะท้าย ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่จังหวัด ที่มีฐานะยากจน ด้อยโอกาส และแพทย์วินิจฉัยว่าจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพต่อเนื่องที่บ้าน

๖. วิธีการดำเนินงาน

๖.๑ สำรวจจำนวนคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน ผู้ป่วยระยะท้าย ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตพื้นที่..... และประเมินภาวะความจำเป็นในการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ

๖.๒ จัดทำโครงการฯ เสนอกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง

๖.๓ ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ฯให้ถูกต้องตามระเบียบ

๖.๔ จัดทำทะเบียนคุมอุปกรณ์ฯ

๖.๕ ให้บริการยืมแก่กลุ่มเป้าหมาย

๖.๖ ติดตามเยี่ยมบ้าน ดูสภาพการใช้งานอุปกรณ์และอาการของผู้ป่วย ในกรณีผู้รับบริการเสียชีวิต หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ ให้ญาติหรือผู้ดูแลส่งคืนอุปกรณ์

๖.๗ รับคืนและฟื้นฟูสภาพของอุปกรณ์ โดยทำการตรวจสภาพเมื่อได้รับส่งคืน โดยต้องผ่านกระบวนการทำความสะอาดตามมาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ และนำเข้าสู่ระบบ ลงบันทึกรับคืน และเตรียมพร้อมให้บริการรายต่อไป

๖.๘ รายงานผลการดำเนินงานให้กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ทราบ

๖.๙ รายงานสถานการณ์หมุนเวียนอุปกรณ์ (จำนวนผู้ยืม, จำนวนอุปกรณ์คงเหลือ) ให้กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ทราบ

๗. ระยะเวลา...

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่เดือน..... ถึง เดือน.....

๘. สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน โรงพยาบาล / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

๙. งบประมาณ (ให้สอดคล้องกับวิธีการดำเนินการ)

ขอรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง จำนวนเงิน.....บาท (.....)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑ หน่วยบริการได้พัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยมีอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน ลดความแออัดในโรงพยาบาล

๑๐.๒ กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงบริการยืมกายอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพต่อเนื่องที่บ้าน

๑๐.๓ ผู้ใช้บริการมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อน สามารถฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ ส่งผลดีต่อสุขภาพหรือการบำบัดรักษา ลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวผู้ป่วย

๑๑. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ

ข้าพเจ้า.....(ชื่อ-สกุล).....ตำแหน่ง.....
หน่วยงาน.....หมายเลขโทรศัพท์.....ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.....
ขอรับรองว่าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม..... ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ในครั้งนี้

☐ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น และเพื่อให้การจ่ายเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม่ซ้ำซ้อนกับการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ ให้พิจารณาดำเนินงาน ดังนี้

☐ ดำเนินงานในโครงการขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

☐ ดำเนินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่เป็นภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดสามารถดำเนินการได้เอง

☐ ดำเนินงานตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมในลักษณะที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องหรือมีประชาชนที่ได้รับประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นมากกว่า ๑ แห่งขึ้นไป

☐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร้องขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานแทน

☐ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงาน ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๙ และตามระเบียบระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๙

๑๒. ผู้รับผิดชอบ...

๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล:.....ตำแหน่ง:.....

สถานที่ติดต่อ:.....

โทรศัพท์: .....E-mail: .....

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายกิตติ เกียรติ์มนตรี)

ประธานอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายปิยะ ปิตุเตชะ)

ประธานกรรมการกองทุนหลักประสุขภาพจังหวัดระยอง

<u>หมายเหตุ</u>: ผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง จะต้องเขียนโครงการให้ละเอียดเพื่อให้คณะกรรมการกองทุน พิจารณาว่าเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๙

(แบบประมาณการค่าใช้จ่าย)

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายแนบท้าย

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	จำนวนเงิน (บาท)
๑			
๒			
๓			
๔			
๕			
๖			
๗			
๘			
๙			
๑๐			
๑๑			
๑๒			
๑๓			
๑๔			
๑๕			
รวม			

(ตัวหนังสือ) (.....)

<u>หมายเหตุ</u> ผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง จะต้องแสดงรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อให้ให้คณะกรรมการกองทุน พิจารณาว่าเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๙ และความจำเป็นเหมาะสมในการใช้งบประมาณกองทุน

ข้อมูลคลังอุปกรณ์ศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน

โรงพยาบาล..... อำเภอ..... จังหวัด.....

ข้อมูล ณ วันที่ .....

ลำดับ	รายการ	จำนวนรายการอุปกรณ์ฯ		
		ปีงบประมาณ		
		๒๕๖๔ - ๒๕๖๙		๒๕๗๐
		รายการทั้งหมด	รายการคงเหลือในหน่วยบริการ	รายการที่ขอรับเพิ่ม
๑	ไม้ค้ำยันรักแร้แบบอลูมิเนียม			
๒	ไม้เท้าอลูมิเนียมแบบสามขา			
๓	ไม้เท้าสำหรับคนตาบอดพับได้			
๔	ไม้ค้ำยันรักแร้แบบไม้			
๕	รถเข็นนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะแบบ ปรับให้เหมาะสมกับความพิการได้			
๖	รถเข็นนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะแบบปรับไม่ได้			
๗	เบาะรองนั่งสำหรับคนพิการ			
๘	รถสามล้อโยกมาตรฐานสำหรับคนพิการ			
๙	แผ่นรองตัวสำหรับผู้ป่วยอัมพาตหรือที่นอนลม			
๑๐	เตียงฝึกยืนสำหรับเด็ก			
๑๑	รถเข็นแบบชนิดเบา			
๑๒	รถเข็นนั่งปรับเอนได้			
๑๓	ที่นอนลมแบบลอน (ใหญ่)			
๑๔	ที่นอนลมแบบรังผึ้ง			
๑๕	เบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ			
๑๖	ที่นั่งสำหรับถ่ายและอาบน้ำได้			
๑๗	Push up box			
๑๘	เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด ๕ ลิตร			
๑๙	เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด ๑๐ ลิตร			
๒๐	เครื่องดูดเสมหะ (SUCTION)			
๒๑	ไม้เท้า ๑ ปุ่ม			
๒๒	เตียงผู้ป่วยสามไกร์ราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ			
๒๓	เครื่องช่วยเดินชนิด ๔ ขา (WALKER)			
๒๔	เครื่องช่วยเดินชนิด ๔ ขา (WALKER) แบบพับได้			
X	เตียงผู้ป่วยเฟาว์เล่อร์แบบ ๓ ไก (แบบ ก)			
X	เตียงผู้ป่วยเฟาว์เล่อร์แบบ ๒ ไก (แบบ ข)			
X	เตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้า			
X	เตียงผู้ป่วยสามไกร์ราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ			
X	เตียงฝึกยืนสำหรับผู้ใหญ่			

รายชื่อผู้ป่วยที่ต้องการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการและอุปกรณ์ทางการแพทย์
โครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน
โปรดกาเครื่องหมาย √ ในช่อง ( ) ด้านล่างนี้

( ) การขอรับงบประมาณกองทุนฯ ครั้งนี้ ยังไม่มีรายชื่อผู้ป่วย

( ) การขอรับงบประมาณกองทุนฯ ครั้งนี้ มีรายชื่อผู้ป่วยที่ต้องการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามตารางข้างล่างนี้

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	อายุ	ที่อยู่ตามจริง	โรคประจำตัว/ความพิการ	เหตุผลความจำเป็น	อุปกรณ์ที่ต้องการ

ตัวอย่างแบบรายงานผลการดำเนินโครงการ

โครงการ.....

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....

รายงาน ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

๑. ชื่อหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณกองทุนฯ :.....

๒. งบประมาณ

๒.๑ งบประมาณโครงการที่ได้รับ.....บาท (.....)

๒.๒ งบประมาณที่ได้ใช้ไปในการดำเนินงานโครงการ.....บาท (.....)

๒.๓ งบประมาณคงเหลือ.....บาท (.....) (ถ้ามี)

๓. ผลการดำเนินการ

๓.๑ ผู้ได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ขอรายงานผลการดำเนินโครงการ ตามบันทึกข้อตกลงการรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง เลขที่...../วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....และเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่...เดือน.....พ.ศ.....

๓.๒ ผู้ได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ขอส่งสำเนาเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานอื่น จำนวน..... ฉบับ จำนวนเงิน.....บาท (.....) ของการดำเนินการตามโครงการที่ได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง มาพร้อมหนังสือฉบับนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อไป

๓.๓ ผู้ได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ขอส่งเงินงบประมาณคงเหลือ (ถ้ามี) จำนวน.....บาท มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

๓.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ (เขียนให้เห็นว่าเกิดประโยชน์กับประชาชนในเขตพื้นที่อย่างไร) .....

.....

๔. ผู้ได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ เนื่องจาก..... จึงขอส่งเงินคืน จำนวน.....บาท (.....) มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

๕. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

☐ ไม่มี

☐ มี

ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ).....

แนวทางการแก้ไข (ระบุ).....

๖. เอกสารประกอบการรายงานผลการดำเนินแผนงาน

☐ ภาพถ่าย

☐ อื่น ๆ ระบุ.....

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน (ผู้ได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง)

(.....)

ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ: กรณีองค์กรหรือกลุ่มประชาชน ลงนามไม่น้อยกว่า จำนวน ๓ คน

เอกสารแนบท้าย (๓)

ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๙

หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าใช้จ่าย ที่สนับสนุนและส่งเสริมแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม รวมทั้งแผนการดูแลรายบุคคลสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชนในจังหวัด เพื่อส่งเสริมประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่เข้าถึงการบริการสาธารณสุขและการแก้ปัญหาสุขภาพด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นได้มากขึ้น (ตามประกาศ ข้อ ๑๑(๑)) โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง มีแนวทาง ดังนี้

๑. ประเภทการสนับสนุน

การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

- โครงการซ่อมบำรุง ดัดแปลงและจัดทำเฉพาะ อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ

๒. หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง

- องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สามารถขอรับงบประมาณตามความจำเป็นเหมาะสม ในวงเงินไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อครั้ง

- องค์กรหรือกลุ่มประชาชน สามารถขอรับงบประมาณตามความจำเป็นเหมาะสม ในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อครั้ง

หมายเหตุ

(๑) กรณีหน่วยงานมีความจำเป็นต้องจัดโครงการ เกินวงเงินที่กำหนด ให้คณะกรรมการกองทุน เป็นผู้พิจารณาอนุมัติตามความจำเป็นและเหมาะสม

(๒) กรณีหน่วยงานมีความประสงค์จะขอรับสนับสนุนงบประมาณครั้งถัดไป หน่วยงานนั้นๆ จะต้องส่งรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว มายังกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ให้เรียบร้อยก่อนจะยื่นของบประมาณครั้งถัดไป

๓. กลุ่มเป้าหมาย

๓.๑ คนพิการ

๓.๒ ผู้สูงอายุ

๓.๓ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน (Intermediate Care: IMC)

๓.๔ ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู

๓.๕ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

<u>หมายเหตุ:</u> กลุ่มเป้าหมายต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรืออาศัยในจังหวัดระยอง ต้องได้รับการประเมินความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ตามวินิจฉัยของแพทย์ นักกายภาพบำบัด หรือพยาบาลวิชาชีพ (Care Manager)

๔. หลักเกณฑ์...

๔. หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่าย

กรณีซ่อมแซม ให้สนับสนุนงบประมาณโดยใช้อัตราความสำคัญ ดังนี้

๔.๑ ให้ใช้ราคาท้องตลาดโดยประหยัด (สืบราคาอย่างน้อย ๓ ราย)

๔.๒ ค่าซ่อมแซมรวมค่าแรงและค่าอะไหล่ ไม่ควรเกินร้อยละ ๖๐-๗๐ ของราคาจัดซื้อใหม่

๔.๓ กรณีดัดแปลง/ทำรายเฉพาะ ให้พิจารณาตามต้นทุนวัสดุและค่าแรงตามความเหมาะสม โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกองทุนฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ

๕. ขั้นตอนการดำเนินงาน

๕.๑ การประเมินและคัดกรอง

(๑) ผู้ดำเนินการ: แพทย์ นักกายภาพบำบัด หรือทีมสหวิชาชีพ

(๒) การปฏิบัติ ตรวจประเมินผู้ป่วย และระบุชนิดของอุปกรณ์ที่จำเป็น หรือระบุส่วนที่ต้องซ่อมแซม/ดัดแปลง ลงใน “แผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)” หรือใบสั่งการรักษา

๕.๒ การเสนอโครงการขอสนับสนุน

(๑) กรณีรายบุคคล รพ./รพ.สต. รวบรวมรายชื่อและความต้องการ (ซ่อม)

(๒) การแนบเอกสาร

- โครงการ (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)
- รายละเอียดคุณลักษณะ (Spec) และราคา (ปร.๔ หรือใบเสนอราคา)
- แผนการดูแลรายบุคคล (กรณีระบุตัวผู้รับชัดเจน)

๕.๓ การพิจารณาอนุมัติ

(๑) คณะอนุกรรมการกองทุนฯ ตรวจสอบและกลั่นกรองความถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด

(๒) คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง อนุมัติโครงการฯ

๕.๔ การดำเนินการซ่อมแซม

(๑) หน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติโครงการ ดำเนินการตามที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ

๕.๕ การส่งมอบผลการดำเนินงาน

(๑) รายงานฉบับสมบูรณ์ ส่งภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดโครงการ

- รายงานผลการดำเนินงาน
- รายงานรับ-จ่ายเงิน (พร้อมหลักฐานสำเนาใบเสร็จรับเงิน)
- ภาพประกอบการดำเนินโครงการ/ภาพอุปกรณ์
- การซ่อมแซมของเดิม ควรถ่ายรูปสภาพ “ก่อนซ่อม”, “ระหว่างซ่อม” และ “หลังซ่อม” ไว้ทุกครั้ง เพื่อใช้ประกอบหลักฐานการเบิกจ่ายว่าได้ดำเนินการจริง

๖. การรายงานผล...

๖. การรายงานผล

๖.๑ รายงานผลการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์มที่กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยองกำหนด

๖.๒ จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อม ดัดแปลง เปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ หรือการจัดทำอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการเป็นกรณีเฉพาะผู้พิการนั้นๆ

๖.๓ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง, ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ, ใบสำคัญรับเงิน, ใบเสร็จรับเงิน, ใบส่งของ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารของผู้รับเงิน (เอกสารร้านค้า) เป็นต้น

๖.๔ ภาพถ่ายกิจกรรม เช่น ป้ายโครงการ, การดำเนินโครงการ, อะไหล่/อุปกรณ์ในโครงการ, รูปภาพ “ก่อนซ่อม”, “ระหว่างซ่อม” และ “หลังซ่อม” จะต้องเป็นรูปปัจจุบันเท่านั้น ไม่น้อยกว่า ๑๐ ภาพ

๖.๕ กรอกข้อมูลรายการอะไหล่/อุปกรณ์ที่ได้จัดซื้อและคงเหลือ ในแบบฟอร์ม ที่กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยองกำหนด อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปีงบประมาณ ให้กองทุนฯ ทราบ

๖.๖ อื่นๆ เช่น แบบประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ

ตัวอย่าง

แบบฟอร์มโครงการขอรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง
(โครงการซ่อมบำรุง ดัดแปลงและจัดทำเฉพาะ อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ)

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๙ ข้อ ๒๑ (๒) ให้คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจหน้าที่ “ให้พิจารณาอนุมัติแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม รวมทั้งแผนดูแลรายบุคคลสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ” ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ตามประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติฯ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑

จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ชื่อ ☐ แผนงาน ☐ โครงการ ☐ กิจกรรม

.....

๒. ชื่อ ☐ หน่วยงาน ☐ องค์กร ☐ กลุ่มประชาชน

.....

๓. หลักการและเหตุผล (สาเหตุและความจำเป็นของโครงการ)

พื้นที่.....มีคนพิการ จำนวน.....คน ผู้สูงอายุ จำนวน.....คน ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน (Intermediate Care: IMC) จำนวน.....คน ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู จำนวน.....คน และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน.....คน ในจำนวนมีผู้ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ จำนวน.....คน หน่วยงาน.....ได้ศึกษาข้อมูลพบว่ากลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ ประสบปัญหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการชำรุด และไม่สามารถเข้าถึงบริการซ่อมแซมอุปกรณ์ได้ ทำให้การดำเนินกิจวัตรประจำวันมีความยากลำบาก เป็นผลให้คุณภาพชีวิตลดลง นอกจากนั้นเด็กพิการที่เป็นอัมพาตประสบปัญหาไม่สามารถนั่งเก้าอี้ล้อเข็นได้นาน เนื่องจากเก้าอี้ล้อเข็นไม่เหมาะกับสภาพร่างกายจำเป็นต้องปรับปรุงเก้าอี้ล้อเข็นให้เหมาะสม โดยการจัดปรับท่านั่ง ด้วยการเสริมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เบาะรองนั่ง เบาะพิงหลัง เบาะวางเท้า และถาดกิจกรรม ซึ่งทำให้เด็กพิการนั่งเก้าอี้ล้อเข็นได้ดีขึ้นและนานขึ้น อันส่งผลต่อสุขภาพและพัฒนาการของเด็กพิการโดยตรง และยังลดปัญหาแผลกดทับจากการนั่งนานโดยเฉพาะในเด็กนักเรียนที่พิการ

หน่วยงาน.....มีความสามารถในการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ รวมถึงการดัดแปลงและจัดทำใหม่โดยการสนับสนุนวิชาการจากช่างกายอุปกรณ์ นักกายภาพบำบัดและแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูจากหน่วยบริการ/โรงพยาบาล.....จึงได้จัดทำโครงการซ่อมบำรุง ดัดแปลงและจัดทำเฉพาะ อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ เพื่ออำนวยความสะดวกการเข้าถึงบริการซ่อมแซม ดัดแปลง และจัดทำเฉพาะ อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการขึ้น ซึ่งจะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนเหล่านี้ได้

จากข้อมูลที่ผ่านมา.....(ชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน)..... เคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการดังกล่าว จำนวน.....ครั้ง เมื่อวันที่.....เป็นจำนวนเงิน.....บาท ในการจัดตั้งศูนย์ซ่อมฯ ที่ผ่านมาปี .....มีการให้บริการในการซ่อมกลุ่มวีลแชร์ จำนวน.....คัน, กลุ่มเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน.....เครื่อง, กลุ่มที่นอนลม จำนวน.....อัน, กลุ่มเตียง จำนวน.....เตียง, กลุ่มเครื่องดูดเสมหะ จำนวน.....เครื่อง (ในกรณีมีการจัดตั้งศูนย์ซ่อมมากกว่า ๑ ปี ให้ใส่ข้อมูลให้ครบทุกปี) ทำให้มีแนวโน้มผู้มารับบริการซ่อมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ.....(ชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน)..... จึงจัดทำโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง ดัดแปลงและจัดทำเฉพาะอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ประจำปีงบประมาณ..... เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการซ่อมแซม การสร้าง หรือดัดแปลงอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้มีคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ได้มีอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพใช้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

๔. วัตถุประสงค์...

๔. วัตถุประสงค์ของโครงการ (แสดงความต้องการให้เกิดประโยชน์อะไรต่อกลุ่มเป้าหมาย)

๔.๑ เพื่อบริการซ่อมบำรุง เปลี่ยนชิ้นส่วน อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่ชำรุดของกลุ่มเป้าหมายได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

๔.๒ เพื่อบริการดัดแปลง หรือจัดทำใหม่อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการเป็นการเฉพาะ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความพิการแต่ละบุคคล

๔.๓ .....

๕. กลุ่มเป้าหมาย

คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่..... จำนวน.....คน โดยมีรายการซ่อมบำรุง ดัดแปลงและจัดทำเฉพาะ อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ดังนี้

๕.๑ ซ่อมบำรุง เปลี่ยนชิ้นส่วน อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ จำนวน.....รายการ/ชิ้น

๕.๒ ดัดแปลง อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ จำนวน.....รายการ

๕.๓ จัดทำใหม่เฉพาะ ตามคำสั่งของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๖. วิธีดำเนินการ (การให้รายละเอียดในการดำเนินการ ทำอย่างไรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงิน)

๖.๑ ประชาสัมพันธ์โครงการฯ

๖.๒ สำรวจอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพในพื้นที่ความรับผิดชอบ

๖.๓ จัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง

๖.๔ ดำเนินการซ่อมบำรุง เปลี่ยนชิ้นส่วน ดัดแปลง หรือจัดทำใหม่ อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ

๖.๕ จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อม ดัดแปลง เปลี่ยนชิ้นส่วน อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ หรือการจัดทำอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการเป็นกรณีเฉพาะผู้พิการนั้นๆ

๖.๖ รวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานสรุปผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง

๗. ระยะเวลาในการดำเนินการ

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ..... เป็นต้นไป

๘. สถานที่ดำเนินการ (ควรระบุสถานที่ให้ชัดเจน)

หน่วยงาน.....

๙. งบประมาณ

ขอรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง จำนวนเงิน.....บาท (.....)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

หมายเหตุ: แนบเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อให้ประกอบการพิจารณา เช่น รายละเอียดคุณลักษณะ (Spec) ราคา (ปร.๔ หรือใบเสนอราคาอย่างน้อย ๓ ราย) และแผนการดูแลรายบุคคล (กรณีระบุตัวผู้รับชัดเจน) เป็นต้น

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้ (ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในจังหวัดระยองที่ขอรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ อย่างไร)

๑๐.๑ กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการซ่อมบำรุง เปลี่ยนชิ้นส่วน อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่ชำรุด

๑๐.๒ กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการดัดแปลง หรือจัดทำอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ เป็นการเฉพาะเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความพิการของแต่ละบุคคล

๑๐.๓ .....

๑๑. คำรับรอง...

๑๑. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ

ข้าพเจ้า.....(ชื่อ-สกุล).....ตำแหน่ง.....
หน่วยงาน.....หมายเลขโทรศัพท์.....ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.....
ขอรับรองว่าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม..... ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ในครั้งนี้

☐ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น และเพื่อให้การจ่ายเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม่ซ้ำซ้อนกับการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ให้พิจารณาดำเนินงาน ดังนี้

☐ ดำเนินงานในโครงการขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

☐ ดำเนินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่เป็นภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดสามารถดำเนินการได้เอง

☐ ดำเนินงานตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมในลักษณะที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องหรือมีประชาชนที่ได้รับประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นมากกว่า ๑ แห่งขึ้นไป

☐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร้องขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานแทน

☐ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงาน ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานและบริการจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๙ และตามระเบียบระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๙

๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล:.....ตำแหน่ง:.....
สถานที่ติดต่อ:..... โทรศัพท์: .....E-mail: .....

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(.....)
ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
(.....)
ประธานอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
(.....)
ประธานกรรมการกองทุนหลักประสุขภาพจังหวัดระยอง

<u>หมายเหตุ</u>: ผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง จะต้องเขียนโครงการให้ละเอียดเพื่อให้คณะกรรมการกองทุน พิจารณาว่าเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง ดัดแปลงและจัดทำเฉพาะ
อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....

ชื่อผู้ขอรับงบประมาณ .....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท (.....)

ระยะเวลาดำเนินงาน.....วัน (โดยคำนวณจากปริมาณงาน)

ลงชื่อ.....ผู้ประเมินราคา

(.....)

นายช่างผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(.....)

ผู้ช่วย/นายช่างโยธากองทุนฯ หรือผู้ช่วยหรือนายช่างโยธาของเทศบาล/อบต.

หรือบุคลากรที่มีองค์ความรู้ด้านงานโยธาของสถาบันการศึกษา

ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ



ภาพถ่ายระหว่างดำเนินการ



ภาพถ่ายหลังดำเนินการ



หมายเหตุ ๑. ผู้ขอรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยองจะต้องเขียนโครงการให้ละเอียดเพื่อให้คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และการใช้จ่ายเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒. ให้แนบเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะ (Spec) และราคา (ปร.๔ หรือใบเสนอราคาอย่างน้อย ๓ ราย) เพื่อให้คณะอนุกรรมการกองทุน และคณะกรรมการกองทุนฯ ใช้ประกอบการพิจารณา

๓. ให้แนบเอกสารแผนการดูแลรายบุคคล (กรณีระบุตัวผู้รับชัดเจน) เพื่อให้คณะอนุกรรมการกองทุนและคณะกรรมการกองทุนฯ ใช้ประกอบการพิจารณา

๔. หากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้รีบดำเนินการทำเล่มรายงานให้กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยองทราบโดยทันที พร้อมภาพถ่าย “ก่อนซ่อม”, “ระหว่างซ่อม” และ “หลังซ่อม” ไว้ทุกครั้ง เพื่อใช้ประกอบหลักฐานการเบิกจ่ายว่าได้ดำเนินการจริง และแนบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่ออุปกรณ์ที่ได้รับ

ตัวอย่างแบบรายงานผลการดำเนินโครงการ

โครงการ.....

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....

รายงาน ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

๑. ชื่อหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณกองทุนฯ :.....

๒. งบประมาณ

๒.๑ งบประมาณโครงการที่ได้รับ.....บาท (..... .....)

๒.๒ งบประมาณที่ได้ใช้ไปในการดำเนินงานโครงการ.....บาท (.....)

๒.๓ งบประมาณคงเหลือ.....บาท (..... .....) (ถ้ามี)

๓. ผลการดำเนินการ

๓.๑ ผู้ได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ขอรายงานผลการดำเนินโครงการ ตามบันทึกข้อตกลงการรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง เลขที่...../วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....และเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่...เดือน.....พ.ศ.....

๓.๒ ผู้ได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ขอส่งสำเนาเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานอื่น จำนวน..... ฉบับ จำนวนเงิน.....บาท (.....) ของการดำเนินการตามโครงการที่ได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง มาพร้อมหนังสือฉบับนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อไป

๓.๓ ผู้ได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ขอส่งเงินงบประมาณคงเหลือ (ถ้ามี) จำนวน.....บาท มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

๓.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ (เขียนให้เห็นว่าเกิดประโยชน์กับประชาชนในเขตพื้นที่อย่างไร)

.....

.....

๔. ผู้ได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ เนื่องจาก..... จึงขอส่งเงินคืน จำนวน.....บาท (.....) มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

๕. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

☐ ไม่มี

☐ มี

ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ).....

แนวทางการแก้ไข (ระบุ).....

๖. เอกสารประกอบการรายงานผลการดำเนินแผนงาน

☐ ภาพถ่าย

☐ อื่น ๆ ระบุ.....

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน (ผู้ได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง)

(.....)

ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ: กรณีองค์กรหรือกลุ่มประชาชน ลงนามไม่น้อยกว่า จำนวน ๓ คน

เอกสารแนบท้าย (๔)

ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๙

หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าใช้จ่าย ที่สนับสนุนและส่งเสริมแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม รวมทั้งแผนการดูแลรายบุคคลสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชนในจังหวัด เพื่อส่งเสริมประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่เข้าถึงการบริการสาธารณสุขและการแก้ปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆ ที่จำเป็นได้มากขึ้น (ตามประกาศ ข้อ ๑๑ (๑)) โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง มีแนวทางดังนี้

๑. ประเภทการสนับสนุน

๑.๑ การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

- โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ป่วยระยะท้าย มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ

๒. หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สามารถขอรับงบประมาณตามความจำเป็นเหมาะสม ในวงเงินไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาทต่อหลัง

หมายเหตุ

๑. กรณีหน่วยงานมีความจำเป็นต้องปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ เกินวงเงินที่กำหนด ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาเป็นรายบุคคล ตามความจำเป็นและเหมาะสมอย่างคุ้มค่า

๒. เน้นใช้วัสดุที่คงทน หาได้ง่ายในท้องถิ่น และค่าแรงที่เหมาะสม

๓. กลุ่มเป้าหมาย

๓.๑ คนพิการ
๓.๒ ผู้สูงอายุ
๓.๓ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน (Intermediate Care: IMC)
๓.๔ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
๓.๕ ผู้ป่วยระยะท้าย (Palliative Care)

๔. หลักเกณฑ์

๔.๑ <u>หลักเกณฑ์การสนับสนุน</u>

(๑) สภาพบ้าน ไม่เหมาะสม ไม่ปลอดภัยต่อการอยู่อาศัย หรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตประจำวันการฟื้นฟูสภาพ เช่น ไม่มีทางลาด ห้องน้ำนั่งยอง และประตูแคบ เป็นต้น

(๒) กรรมสิทธิ์ เป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง หรือหากเป็นของผู้อื่นต้องได้รับ หนังสือยินยอม จากเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือเจ้าของที่ดินให้ดำเนินการปรับปรุงได้

(๓) ความเห็นทางวิชาการ ต้องผ่านการประเมินจากทีมสหวิชาชีพ เช่น แพทย์ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ว่ามีความจำเป็นต้องปรับปรุง

๔.๒ <u>รายการ</u>...

๔.๒ <u>รายการที่ให้การสนับสนุน</u>

(๑) ห้องน้ำ เปลี่ยนส้วมซึมเป็นชักโครก/นั่งราด ติดตั้งราวจับ (Handrail) ปรับพื้นกันลื่น ขยายประตูห้องน้ำ

(๒) ทางเข้า/ภายในบ้าน สร้างทางลาด (Ramp) อัตราส่วน ๑ : ๑๒ ติดตั้งราวจับทางเดิน ปรับระดับพื้นบ้านให้เรียบเสมอกัน

(๓) ห้องนอน/ที่พัก ปรับความสูงเตียง ติดตั้งราวจับหัวเตียง ปรับแสงสว่างให้เพียงพอ

๕. ขั้นตอนการดำเนินงาน

๕.๑ <u>การค้นหาและยื่นคำขอ</u>

(๑) ผู้ดำเนินการ: อสม./Care Manager (CM), ผู้นำชุมชน, ผู้ป่วยหรือญาติแจ้งความประสงค์

(๒) วิธีการ: สำรวจผู้ที่มีความยากลำบากในการอยู่อาศัย และยื่น “แบบคำขอรับการปรับสภาพแวดล้อม” ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ พร้อมแนบเอกสาร เช่น สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ภาพถ่ายสภาพบ้านปัจจุบัน เป็นต้น

๕.๒ <u>การประเมินและประมาณการ</u>

(๑) ประเมินทางกายภาพ (โดยสหวิชาชีพ) เพื่อประเมินกิจวัตรประจำวัน (ADL) จุดเสี่ยงที่ต้องแก้ และสเปกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับร่างกายผู้ป่วย

(๒) ประเมินทางช่าง (โดยกองช่าง) เพื่อวัดพื้นที่ คำนวณวัสดุ จัดทำ ปร.๔ และเขียนแบบแปลนโดยสังเขป

๕.๓ <u>การพิจารณาอนุมัติ</u>

(๑) คณะทำงานกองทุนฯ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ และกลั่นกรองความถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด

(๒) คณะอนุกรรมการกองทุนฯ ตรวจสอบและกลั่นกรองความถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด

(๓) คณะกรรมการกองทุนฯ อนุมัติโครงการฯ

๕.๔ <u>การดำเนินการ</u>

(๑) หน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติโครงการ ดำเนินการตามที่คณะกรรมการกองทุนฯ อนุมัติ

๕.๕ <u>การส่งมอบและประเมินผล</u>

(๑) รายงานฉบับสมบูรณ์ ส่งภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดโครงการ

- รายงานผลการดำเนินงาน
- รายงานรับ - จ่ายเงิน (พร้อมหลักฐานสำเนาใบเสร็จรับเงิน)
- ภาพประกอบการดำเนินโครงการ/รูปภาพอุปกรณ์
- ภาพถ่ายเปรียบเทียบ “ก่อนดำเนินการ” “ระหว่างดำเนินการ” และ “หลังดำเนินการ”
- ติดตามดูว่าหลังปรับปรุงแล้ว ผู้ป่วยใช้ชีวิตดีขึ้นหรือไม่

๖. การรายงานผล

๖.๑ รายงานผลการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์มที่กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยองกำหนด

๖.๒ รายละเอียดค่าใช้จ่าย (รายรับ-รายจ่าย)

๖.๓ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เช่น แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, การจัดซื้อจัดจ้าง,ใบสำคัญรับเงิน, ใบเสร็จรับเงิน, ใบส่งของ, สำเนาบัตรประจำตัวหรือเอกสารของผู้รับเงิน (เอกสารร้านค้า) เป็นต้น

๖.๔ เอกสารแบบคำขอรับการปรับสภาพแวดล้อม

๖.๕ ภาพถ่ายกิจกรรม เช่น รูปป้ายโครงการ, รูปถ่าย “ก่อนดำเนินการ” “ระหว่างดำเนินการ” และ “หลังดำเนินการ” ปรับสภาพแวดล้อม, รูปในโครงการ/กิจกรรมจะต้องเป็นรูปปัจจุบันเท่านั้น ไม่น้อยกว่า ๑๐ ภาพ

๖.๖ กรอกข้อมูลรายละเอียดผู้ได้รับงบประมาณ ในแบบฟอร์ม ที่กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยองกำหนด

ตัวอย่าง

แบบฟอร์มโครงการขอรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง
(โครงการสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ป่วยระยะท้าย มีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ)

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๙ ข้อ ๒๑ (๒) ให้คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจหน้าที่ “ให้พิจารณาอนุมัติแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม รวมทั้งแผนดูแลรายบุคคลสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ” ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ตามประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติฯ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑

จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ชื่อ ☐ แผนงาน ☐ โครงการ ☐ กิจกรรม

.....

๒. ชื่อ ☐ หน่วยงาน ☐ องค์กร ☐ กลุ่มประชาชน

.....

๓. หลักการและเหตุผล

ตามที่ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๙ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๙ ประกอบกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๒๐ คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ (๑๐) การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย การมีผู้ช่วยคนพิการ หรือการจัดให้มีสวัสดิการอื่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดในระเบียบ และระเบียบคณะกรรมการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ การมีผู้ช่วยคนพิการ การช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล และสิทธิของผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทางการคุ้มครองสิทธิคนพิการ เกี่ยวกับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการไว้ว่า การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงที่อยู่อาศัยบางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อขจัดอุปสรรคหรือจัดให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตในที่อยู่อาศัยนั้นได้โดยสะดวกและเหมาะสมกับสภาพความพิการรวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย

เพื่อให้การช่วยเหลือ ผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่มีความเหมาะสม สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างอิสระ เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล.....จึงได้จัดทำโครงการสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ป่วยระยะท้าย มีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อดำเนินการปรับสภาพบ้านและที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์

๔.๒ เพื่อลดความเสี่ยงของอันตรายที่จะเกิดขึ้น และป้องกันความพิการซ้ำซ้อน

๔.๓ เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้รับการฟื้นฟูอย่างถูกต้อง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างอิสระ ไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่นหรือเป็นภาระน้อยที่สุด

๕. กลุ่มเป้าหมาย

คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ป่วยระยะท้าย มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู

๖. วิธีการ...

๖. วิธีการดำเนินการ

๖.๑ ขั้นตอนดำเนินการ

(๑) ประชาสัมพันธ์การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ เพื่อเสนอโครงการสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ป่วยระยะท้าย มีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง

(๒) เสนอโครงการฯ มายังกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง

(๓) กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง รวบรวมโครงการเสนอคณะทำงานกองทุนฯ เพื่อลงพื้นที่ลงตรวจสอบข้อเท็จจริง และกลั่นกรองความถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด เสนอคณะอนุกรรมการกองทุนฯ พิจารณากลั่นกรองโครงการฯ และเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ อนุมัติต่อไป

(๔) กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันและเบิกจ่ายงบประมาณให้ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพต่อไป

(๕) ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพตามระเบียบฯ

(๖) รายงานผลการดำเนินงานปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ ให้กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยองทราบ ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อตกลง

๖.๒ รายละเอียดกิจกรรม

(๑) ห้องน้ำ เปลี่ยนส้วมซึมเป็นชักโครก/นั่งราด ติดตั้งราวจับ (Handrail) ปรับพื้นกันลื่น ขยายประตูห้องน้ำ

(๒) ทางเข้า/ภายในบ้าน สร้างทางลาด (Ramp) อัตราส่วน ๑:๑๒ ติดตั้งราวจับทางเดิน ปรับระดับพื้นบ้านให้เรียบเสมอกัน

(๓) ห้องนอน/ที่พัก ปรับความสูงเตียงนอน ติดตั้งราวจับหัวเตียง ปรับแสงสว่างให้เพียงพอ

๖.๓ แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรม	เป้าหมายการดำเนินงาน	แผนการดำเนินงาน
(ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส ๑	
(ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส ๒	
(เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส ๓	
(ก.ค.-ก.ย.)	ไตรมาส ๔	

โครงการสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ป่วยระยะท้าย มีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวนบ้าน.....หลัง จำนวนเงิน.....บาท

๗. ระยะเวลาดำเนินการ (กำหนดระยะเวลาดำเนินการให้ครอบคลุมที่คาดว่า จะดำเนินการแล้วเสร็จ)

เช่น วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

๘. งบประมาณ

ขอรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง จำนวนเงิน.....บาท (.....)

รายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ลดความเสี่ยงของอันตรายที่จะเกิดขึ้น และป้องกันความพิการซ้ำซ้อน

๙.๒ กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความสามารถที่เหลืออยู่ และรู้คุณค่าของตนเอง

๙.๓ กลุ่มเป้าหมายสามารถกลับไปดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างอิสระไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่น หรือเป็นภาระน้อยที่สุด

๑๐. คำรับรอง...

๑๐. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ

ข้าพเจ้า.....(ชื่อ-สกุล).....ตำแหน่ง.....
หน่วยงาน.....หมายเลขโทรศัพท์.....ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.....
ขอรับรองว่าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม..... ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ในครั้งนี้

☐ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น และเพื่อให้การจ่ายเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม่ซ้ำซ้อนกับการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ ให้พิจารณาดำเนินงาน ดังนี้

☐ ดำเนินงานในโครงการขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

☐ ดำเนินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่เป็นภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดสามารถดำเนินการได้เอง

☐ ดำเนินงานตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมในลักษณะที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องหรือมีประชาชนที่ได้รับประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นมากกว่า ๑ แห่งขึ้นไป

☐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร้องขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานแทน

☐ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงาน ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๙ และตามระเบียบระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๙

๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล: ..... ตำแหน่ง: .....
สถานที่ติดต่อ: .....โทรศัพท์: .....E-mail: .....

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(.....)
ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
(.....)
ประธานอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
(.....)
ประธานกรรมการกองทุนหลักประสุขภาพจังหวัดระยอง

<u>หมายเหตุ</u>: ผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง จะต้องเขียนโครงการให้ละเอียดเพื่อให้คณะกรรมการกองทุน พิจารณาว่าเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายแนบท้าย

ผู้ประมาณการ.....ตำแหน่ง..... .....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ..... .....

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ		หมายเหตุ
					หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	
รวมทั้งหมด จำนวน.....หลัง							

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท (.....)

ระยะเวลาดำเนินงาน.....วัน (โดยคำนวณจากปริมาณงาน)

แบบคำขอให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ป่วยระยะท้าย มีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ

ประวัติบุคคล

๑. คำนำหน้าชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ.....นามสกุล.....

เชื้อชาติ..... สัญชาติ..... ศาสนา.....

๒. เลขที่บัตรประชาชน ☐-☐☐☐☐-☐☐☐☐☐-☐☐-☐ กรณีไม่มีเนื่องจาก.....

๓. วัน/เดือน/ปีเกิด..... **อายุ**.....ปี **เพศ** ☐ ชาย ☐ หญิง

๔. สถานภาพ ☐ โสด ☐ สมรสอยู่ด้วยกัน ☐ สมรสแยกกันอยู่

☐ หย่าร้าง ☐ ไม่ได้สมรสแต่อยู่ด้วยกัน ☐ หม้าย (คู่สมรสเสียชีวิต)

๕. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

ชื่อสถานที่.....รหัสประจำบ้าน ☐☐☐☐-☐☐☐☐☐☐-☐

บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ตรอก.....ซอย.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

เบอร์โทรศัพท์..... เบอร์ต่อ..... โทรสาร.....

๖. ที่อยู่ปัจจุบัน

☐ **ที่อยู่ปัจจุบันเป็นที่อยู่เดียวกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน** จำนวนผู้อยู่อาศัย.....คน

(กรณีเป็นที่อยู่เดียวกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน ☐ และข้ามไปกรอกข้อ ๗)

ชื่อสถานที่.....รหัสประจำบ้าน ☐☐☐☐-☐☐☐☐☐☐-☐

บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ตรอก.....ซอย.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....อบต./เทศบาล.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....เบอร์โทรศัพท์.....โทรสาร.....

๗. สมาชิกในครอบครัวประกอบด้วย

ที่	ชื่อ – สกุล	อายุ	เกี่ยวข้องเป็น	อาชีพ	รายได้ (บ/ด)	หมายเหตุ

๘. ลักษณะ...

๘. ลักษณะที่อยู่อาศัย

☐ บ้านตนเอง ☐ อาศัยผู้อื่นอยู่ ☐ บ้านเช่า ☐ อยู่กับผู้จ้าง ☐ ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

สภาพที่อยู่อาศัยปัจจุบัน.....

๙. ประเภทผู้ประสบปัญหา

☐ ผู้พิการ ประเภทของความพิการ.....

เลขบัตรประจำตัวคนพิการ.....ระดับความพิการ.....

☐ ผู้สูงอายุ

☐ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน

☐ ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

๑๐. ระดับการศึกษา

☐ ไม่ได้รับการศึกษา/ไม่จบชั้นประถมศึกษา ☐ ประถมศึกษา

☐ มัธยมศึกษาตอนต้น ☐ มัธยมศึกษาตอนปลาย

☐ ปวช./เทียบเท่า ☐ ปวส. / อนุปริญญา / เทียบเท่า

☐ ปริญญาตรี ☐ สูงกว่าปริญญาตรี

☐ อื่น (ระบุ).....

๑๑. อาชีพ

☐ ไม่มีอาชีพ/ว่างงาน ☐ นักเรียน/นักศึกษา

☐ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ☐ ภิกษุ/สามเณร/แม่ชี

☐ พนักงานบริษัท ☐ รับจ้าง

☐ ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ ☐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

☐ เกษตรกร (ทำไร่/นา/สวน/เลี้ยงสัตว์/ประมง) ☐ อื่นๆ ระบุ.....

๑๒. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน.....บาท

ที่มาของรายได้ ☐ ด้วยตนเอง ☐ ผู้อื่นให้

๑๓. ชื่อที่สามารถติดต่อได้.....ความเกี่ยวข้อง.....เบอร์โทรศัพท์.....

๑๔. การได้รับความช่วยเหลือ / สวัสดิการ อุปกรณ์ / เครื่องช่วย ที่เคยได้รับ

๑.....จาก.....จำนวน.....ชิ้น

๒.....จาก.....จำนวน.....ชิ้น

๓.....จาก.....จำนวน.....ชิ้น

๑๕. สภาพปัญหาความเดือดร้อนที่พบ

สำหรับประเภทผู้ขอรับบริการ เลือกตอบได้ (ตอบได้มากกว่า ๑ รายการ)

☐ ไม่มีที่อยู่อาศัย ☐ ไม่มีรายได้

☐ รู้สึกด้อยกว่าผู้อื่น ☐ ถูกรังเกียจเหยียดหยาม

☐ ไม่มีเครื่องช่วยความพิการ ☐ ครอบครัวหรือผู้อุปการะมีฐานะยากจน

☐ ไม่มีโอกาสเรียนหนังสือ ☐ ไม่ได้รับการฝึกอาชีพ

☐ ไม่มีเงินทุนประกอบอาชีพ ☐ เงินไม่พอใช้จ่าย

☐ ไม่มีคนอุปการะ/ไร้ที่พึ่ง ☐ ไม่ได้รับการรักษาพยาบาลหรือการฟื้นฟูสมรรถภาพ

☐ ไม่มีที่อยู่อาศัย/ที่ทำกิน ☐ ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง

☐ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ในชีวิตประจำวัน ☐ มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ

☐ มีความลำบากเมื่อออกนอกบ้าน ☐ ไม่ทราบวิธีการปฏิบัติตนหรือการปรับตัวที่เหมาะสม

☐ ถูกทอดทิ้ง ไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดู ☐ ไม่มีผู้ดูแลในตอนกลางวัน ผู้ดูแลต้องออกไปทำงานนอกบ้าน

☐ ไม่มีงานทำ

๑๖. ความต้องการ...

๑๖. ความต้องการซ่อมแซม/ปรับปรุง

☐ พื้นบ้าน / ทางลาด

☐ ผนังบ้าน / ระบบไฟฟ้า (สวิตซ์ไฟฟ้า / ปลั๊กไฟ / สายไฟ)

☐ ห้องน้ำ / ห้องสุขา / ประตู / ราวจับ

☐ **อื่นๆ** (ระบุ) .....

การตรวจประเมินการปรับสภาพ

ตรวจประเมินวันที่.....

ชื่อ-นามสกุลเจ้าหน้าที่..... ตำแหน่ง.....

หน่วยงาน.....

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกข้อมูล (เจ้าหน้าที่อบต./เทศบาล)

(.....)

ความเห็นของผู้ประเมิน (สิ่งที่ควรปรับสภาพที่อยู่อาศัยตามสภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง)

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน (นักกายภาพบำบัดหรือเจ้าหน้าที่ รพ./สต)

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน (นักกายภาพบำบัดหรือเจ้าหน้าที่ รพ./สต)

(.....)

หนังสือให้ความยินยอมในการจัดสภาพแวดล้อม/ปรับปรุง/ซ่อมแซม

ทำที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี เป็น ( ) เจ้าของบ้าน หรือ ( ) สมาชิกในครอบครัวที่ได้มอบหมายจากเจ้าของบ้านพักอาศัยเลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....เกี่ยวพันเป็น ( ) บิดา ( ) มารดา ( ) สามี ( ) ภรรยา ( ) บุตร ( ) หลาน ( ) อื่นๆ (ระบุ).....ของคนพิการชื่อ.....นั้น ขอทำหนังสือฉบับนี้ไว้เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า

๑. ข้าพเจ้าและครอบครัวได้ทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของการซ่อมแซม/ ปรับปรุงบ้านพักอาศัย ให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ตามโครงการฯ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง

๒. ข้าพเจ้าและครอบครัวที่มีความประสงค์และยินยอมให้มีการซ่อมแซม/ ปรับปรุงบ้านพักอาศัย หลังนี้ตามรายการและระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่กำหนดทุกประการ

๓. เพื่อให้การดำเนินซ่อมแซม/ ปรับปรุงบ้านพักอาศัยหลังนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ข้าพเจ้าและบริวารหรือตัวแทนของข้าพเจ้า ชื่อ.....จะอยู่ร่วมมือร่วมแรงและช่วยอำนวยความสะดวกทุกด้านอย่างเต็มกำลังความสามารถแก่คณะทำงานฯ ตลอดระยะเวลาของการซ่อมแซม/ ปรับปรุงบ้านพักอาศัยหลังนี้ โดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น

๔. ในกรณีที่มีสาเหตุสุดวิสัยหรือความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นในระหว่างการซ่อมแซม/ ปรับปรุงบ่นพักอาศัยหลังนี้ โดยข้าพเจ้าหรือตัวแทนของข้าพเจ้าได้รับรู้ด้วยแล้ว ข้าพเจ้าและครอบครัวจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย และสิทธิใดๆ ทั้งสิ้นจากกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่อย่างใด

เพื่อเป็นหลักฐานในการนี้ ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ.....ผู้ให้ความยินยอม

(.....)

ลงชื่อ.....พยาน

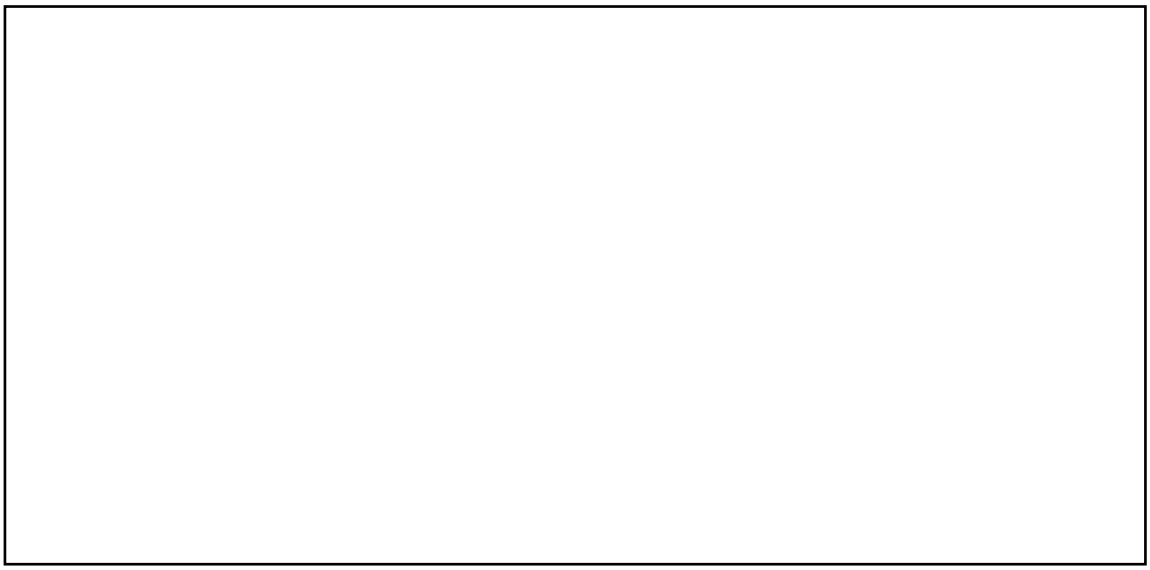
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน

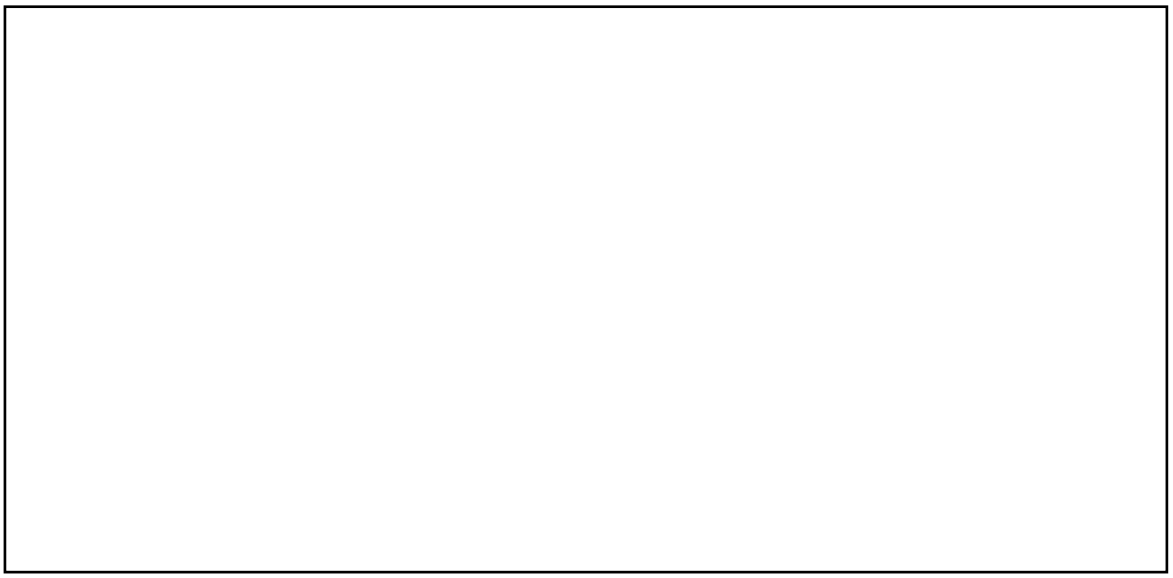
(.....)

<u>หมายเหตุ</u> แนบเอกสารประกอบ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของบ้านพักอาศัย และคนพิการในครอบครัว

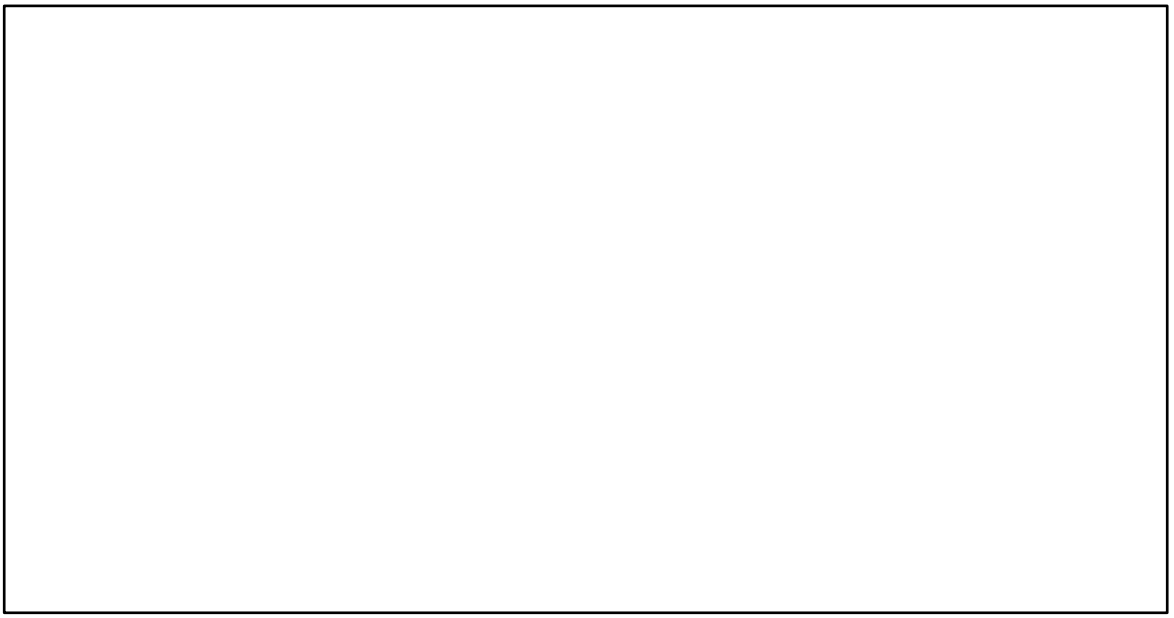
ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ



ภาพถ่ายระหว่างดำเนินการ



ภาพถ่ายหลังดำเนินการ



แบบรายงานการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ป่วยระยะท้าย มีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....

กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง

ที่	ชื่อ – สกุล เลขประจำตัวคนพิการ	อายุ (ปี)	ที่อยู่	ประเภทความพิการ	รายละเอียดการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย	งบประมาณ	
						ที่ได้รับ	เบิกจ่าย

***** หมายเหตุ** หากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้รีบดำเนินการรายงานให้กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ทราบโดยทันที พร้อมถ่าย “ก่อนดำเนินการ” “ระหว่างดำเนินการ” และ “หลังดำเนินการ” การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

๑. แบบคำขอให้มีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง) จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย

๑.๑ แบบคำขอปรับสภาพแวดล้อม

๑.๒ แบบสรุปรายงานการปรับสภาพแวดล้อม/ ปรับปรุง/ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยฯ

๑.๓ แบบประเมินค่าใช้จ่าย (โดยช่างเทศบาล/อบต. เป็นผู้ประมาณการ) ประกอบด้วย ใบ ปร.๔, ปร.๕, ปร.๖ และแบบแปลน

๑.๔ หนังสือให้ความยินยอมในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย จากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน **<u>พร้อมแนบ</u> สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนา อย่างละ ๑ ชุด**
(** กรณีเจ้าของที่ดินเสียชีวิตและยังไม่มีการโอน แบ่งที่ดินหรือแต่งตั้งผู้จัดการมรดก ให้บุตรทุกคน ภรรยา/สามี เจ้าของที่ดินเซ็นในหนังสือยินยอม พร้อมแนบเอกสารทุกคน หากบุตร/ ภรรยา/ สามี คนใดเสียชีวิตแล้ว ก็ให้แนบใบมรณะบัตรด้วย)

๒. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี)

๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

๔. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับงบ

๕. สำเนาโฉนดที่ดิน/ เอกสารสิทธิ์ในการครอบครองที่ดิน (ถ้ามี)

๖. ภาพถ่ายสภาพบ้านหรือบริเวณที่จะดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

****

ตัวอย่างแบบรายงานผลการดำเนินโครงการ

โครงการ.....

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....

รายงาน ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

๑. ชื่อหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณกองทุนฯ :.....

๒. งบประมาณ

๒.๑ งบประมาณโครงการที่ได้รับ.....บาท (.....)

๒.๒ งบประมาณที่ได้ใช้ไปในการดำเนินงานโครงการ.....บาท (.....)

๒.๓ งบประมาณคงเหลือ.....บาท (.....) (ถ้ามี)

๓. ผลการดำเนินการ

๓.๑ ผู้ได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ขอรายงานผลการดำเนินโครงการ ตามบันทึกข้อตกลงการรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง เลขที่...../วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....และเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่...เดือน.....พ.ศ.....

๓.๒ ผู้ได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ขอส่งสำเนาเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานอื่น จำนวน..... ฉบับ จำนวนเงิน.....บาท (.....) ของการดำเนินการตามโครงการที่ได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง มาพร้อมหนังสือฉบับนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อไป

๓.๓ ผู้ได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ขอส่งเงินงบประมาณคงเหลือ (ถ้ามี) จำนวน.....บาท มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

๓.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ (เขียนให้เห็นว่าเกิดประโยชน์กับประชาชนในเขตพื้นที่อย่างไร)

.....

.....

๔. ผู้ได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ เนื่องจาก..... จึงขอส่งเงินคืน จำนวน.....บาท (.....) มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

๕. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

☐ ไม่มี

☐ มี

ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ).....

แนวทางการแก้ไข (ระบุ).....

๖. เอกสารประกอบการรายงานผลการดำเนินแผนงาน

☐ ภาพถ่าย

☐ อื่น ๆ ระบุ.....

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน (ผู้ได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง)

(.....)

ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ: กรณีองค์กรหรือกลุ่มประชาชน ลงนามไม่น้อยกว่า จำนวน ๓ คน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง **แบบเลขที่**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ผู้ประมาณราคา..... **เมื่อวันที่** **เดือน** **พ.ศ.**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	

ผู้คำนวณ

(.....)

นายช่างโยธา.....

(.....) (.....)

หัวหน้าส่วนโยธา..... นายกเทศบาล / อบต.....

ผู้ตรวจสอบ ผู้อนุมัติ

แบบ ปร.๕ (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

แบบ
เลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งาน/กลุ่มงาน.....				
๒	งาน/กลุ่มงาน.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
			รวมค่าก่อสร้าง		

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....ตร.ม. เฉลี่ย.....บาท/ตร.ม.

ผู้คำนวณ

(.....)

นายช่างโยธา

(.....) (.....)

หัวหน้าส่วนโยธา นายก อบต / ทต

ผู้ตรวจสอบ ผู้อนุมัติ

แบบ ปร.๕ (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งาน.....				
๒	งาน.....				
๓	งาน.....				
๔	งาน.....				
	.....ฯลฯ.....				
			รวมค่าก่อสร้าง		

.....

(.....)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.๖ แผ่นที่ ...../.....

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ผู้ประมาณราคา

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ จำนวนชุด

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งาน/กลุ่มงาน.....		
๒	งาน/กลุ่มงาน.....		
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง**		
	ราคากลาง		
	ราคา (.....ตัวอักษร.....)		

ผู้คำนวณ

(.....)

นายช่างโยธา

(.....)

หัวหน้าส่วนโยธา

ผู้ตรวจสอบ

(.....)

นายก อบต. / ทต.

ผู้อนุมัติ

เอกสารแนบท้าย (๕)

ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๙

หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าใช้จ่าย ที่สนับสนุนและส่งเสริมแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม รวมทั้งแผนการดูแลรายบุคคลสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชนในจังหวัด เพื่อส่งเสริมประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่เข้าถึงการบริการสาธารณสุขและการแก้ปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆ ที่จำเป็นได้มากขึ้น (ตามประกาศ ข้อ ๑๑ (๑)) โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง มีแนวทางดังนี้

๑. ประเภทการสนับสนุนการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

- โครงการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน

๒. หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หน่วยบริการระดับปฐมภูมิ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สามารถขอรับงบประมาณตามความจำเป็นเหมาะสม โดยลักษณะการดำเนินงานมีการบริหารจัดการ หรือมีการให้บริการในลักษณะภาพรวมของหลายตำบลที่มีพื้นที่คาบเกี่ยวกัน

๓. หลักเกณฑ์การจัดตั้ง

๓.๑ มีการบูรณาการของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดตั้ง “ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน” มีการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพในชุมชน ตามแบบเสนอโครงการฯ ที่กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยองกำหนด โดยมีประชาชนจิตอาสาที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน

๓.๒ การกำหนดวัตถุประสงค์โครงการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน

(๑) เพื่อสนับสนุนการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของหน่วยบริการในระบบปกติ

(๒) เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพในระดับชุมชน

(๓) เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการสนับสนุนการจัดบริการฟื้นฟูของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓.๓ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายการจัดบริการโครงการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน

(๑) คนพิการ

(๒) ผู้สูงอายุ

(๓) ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน

(๔) ผู้ป่วยระยะท้าย

(๕) ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่จังหวัด

๓.๔ มาตรฐาน...

๓.๔ มาตรฐานของโครงการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน

(๑) มีสถานที่เหมาะสม

(๒) มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง และผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด

(๓) มีระบบฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายทั้ง ๕ กลุ่ม

(๔) มีเครื่องมือเบื้องต้นในการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

(๕) มีองค์กรที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการศูนย์

(๖) มีระบบการสนับสนุนและกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

๓.๕ องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน

(๑) ประธาน: ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้นำชุมชน

(๒) เลขานุการ: เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือนักกายภาพบำบัดชุมชน

(๓) กรรมการ: อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้ดูแลคนพิการ ตัวแทนคนพิการ

๔. งบประมาณ

กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน ดังนี้

๔.๑ ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ สำหรับฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน สามารถขอรับงบประมาณตามความจำเป็นเหมาะสม ในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี

๔.๒ ค่าตอบแทนนักกายภาพบำบัด และนักจัดกิจกรรมบำบัด หลักเกณฑ์ตามระเบียบราชการกำหนด

๔.๓ ค่าตอบแทนอาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น/หน่วยงานสาธารณสุข/หน่วยบริการ/สถานบริการ เป็นผู้คัดเลือก Case ทั้งนี้ สามารถขอรับงบประมาณในวงเงินไม่เกิน ๗,๐๐๐ บาท/เดือน/ศูนย์ เป็นเงิน ๘๔,๐๐๐ บาทต่อปี ดังนี้

- ให้บริการไม่น้อยกว่า ๔๕ นาที/Case
- อัตราค่าตอบแทน ๑๐๐ บาท/ครั้ง/Case
- เบิกจ่ายไม่เกิน ๑๕ ครั้ง/Case/เดือน
- เบิกจ่ายไม่เกิน ๗,๐๐๐ บาท/เดือน/ศูนย์

<u>หมายเหตุ ดังนี้</u>

(๑) การจัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน ตามความจำเป็นและเหมาะสม ให้ถือราคากลางตามระเบียบของทางราชการ หรือราคาตลาดโดยทั่วไปของหน่วยงานที่ของบประมาณในขณะที่จัดซื้อจัดจ้าง แล้วส่งรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการควบคุมวัสดุครุภัณฑ์ เสนอต่อประธานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน

(๒) งบประมาณต้องไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๙

๕. คุณสมบัติ...

๕. คุณสมบัติของอาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน

"อาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน" หมายความว่า บุคคลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน ๗๐ ชั่วโมง หรือหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver: CG) ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดให้มีการอบรม โดยได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หรือหลักสูตรการอบรมมาตรฐาน ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หน่วยบริการ สถานบริการ เป็นผู้จัดอบรมให้ความรู้ และผ่านการคัดเลือกในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน

๖. ขอบเขตการทำหน้าที่ของอาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน

(๑) ช่วยดูแลฟื้นฟูสุขภาพสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

(๒) ช่วยเหลือดูแลการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เช่น การอาบน้ำ การทำความสะอาดร่างกาย การแต่งตัว การรับประทานอาหาร การเคลื่อนย้าย การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ การขับถ่าย การไปพบแพทย์ การรับประทานยา เป็นต้น

(๓) การให้บริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน (Basic health care service) เป็นการดูแลสุขภาพภายใต้การกำกับของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นที่ ได้แก่ การพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพเบื้องต้น การประเมินสุขภาพเบื้องต้น เช่น การประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐาน และการประเมินกิจวัตรประจำวันที่ไม่ซับซ้อนมากเกินไป การประเมินภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ การทำแผลเบื้องต้น การประเมินสัญญาณชีพ การดูแลเรื่องยาเบื้องต้น กิจกรรมกระตุ้นสมองในกลุ่มที่มีภาวะสมองบกพร่องระยะแรก การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมหรือมีอาการทางสมอง เป็นต้น

(๔) การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้นกับครอบครัวและการประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานต่างๆ

(๕) ประเมินปัญหาในการดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง และประสานงานในการส่งต่อได้อย่างถูกต้อง

(๖) การบริการให้การดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)

(๗) ช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด้านสุขภาพพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบำบัดอื่นๆ ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

(๘) การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทางการแพทย์จะต้องอยู่ในการกำกับดูแลของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือนักกายภาพบำบัดหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

๗. การกำกับและการควบคุมการปฏิบัติงาน

(๑) ให้เลขานุการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน จัดให้มีการลงเวลาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน

(๒) ให้แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู หรือนักกายภาพบำบัด ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินสมรรถนะของอาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน

(๓) ให้คณะกรรมการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน ประเมินผลการดำเนินงานของอาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน

๘. การดำเนิน...

๘. การดำเนินการของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน ที่จัดตั้งเรียบร้อยแล้ว จะต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด หากมีปัญหา อุปสรรค หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง ให้แจ้งกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ต่อไป

๙. ประเภทรายการวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ที่สามารถขอรับการสนับสนุนเพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน มีดังนี้

ลำดับ	รายการ	รายละเอียด	หน่วย
๑	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล 	**ลักษณะ** : เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจร ชนิดรัดต้นแขน แบบอัตโนมัติ ใช้ได้กับไฟ AC และ DC มีจอแสดงผลการวัดค่าเป็นLED หรือ LCD สามารถทำการตรวจวัดโดยอัตโนมัติ โดยเครื่องจะปรับปริมาณลมที่เป่าโดยอัตโนมัติ สามารถวัดค่าอัตราการเต้นของชีพจรได้ในช่วง ๔๐ ถึง ๑๖๐ ครั้งต่อวินาที มีค่าความคาดเคลื่อน ในการวัดได้ไม่เกิน ร้อยละ ±๕ สามารถวัดและแสดงค่าความดันโลหิตค่า Systolic และค่า Diastolic ในช่วง ๔๐ ถึง ๒๕๐ mmHg มีค่าความคาดเคลื่อนในการวัดได้ไม่เกิน ร้อยละ ±๕ แบตเตอรี่ที่อยู่ภายในและไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ volts ๕๐ Hz โดยผ่านตัว Adapter **ข้อบ่งชี้** : เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจร ใช้สำหรับตรวจวัดความดันโลหิตในการปฏิบัติงานเบื้องต้น **อายุการใช้งาน** : - ปี	เครื่อง
๒	เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว 	**ลักษณะ** : หน้าจอ OLED หรือ LCD แสดงค่าเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนในเลือด (%SpO๒), ชีพจร (bpm), และกราฟแท่งแสดงชีพจร (Pulse Bar) ช่วงการวัด SpO๒ วัดได้ตั้งแต่ ๗๐% ถึง ๑๐๐% โดยมีความแม่นยำประมาณ ±๒% ช่วงการวัดชีพจร วัดได้ตั้งแต่ ๓๐ ถึง ๒๕๐ ครั้งต่อนาที โดยมีความแม่นยำประมาณ ±๑% หรือ ±๒ bpm ขนาดและน้ำหนักเครื่องมีขนาดกะทัดรัดราว ๕.๖ x ๓.๒ x ๓.๔ เซนติเมตรและน้ำหนักเบาประมาณ ๕๐–๖๐ กรัมรวมแบตเตอรี่ ใช้แบตเตอรี่ขนาด AAA จำนวน ๒ ก้อน พร้อมระบบตัดไฟอัตโนมัติภายใน ๘ วินาทีเมื่อไม่ได้ใช้งานเพื่อประหยัดพลังงาน **ข้อบ่งชี้** : เพื่อวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO๒) และอัตราการเต้นของชีพจร (PR) เพื่อประเมินภาวะพร่องออกซิเจนในผู้ป่วย **อายุการใช้งาน** : - ปี	เครื่อง

ลำดับ...

ลำดับ	รายการ	รายละเอียด	หน่วย
๓	เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟราเรด 	**ลักษณะ** : การวัดแบบไม่สัมผัส ใช้รังสีอินฟราเรดยิงไปที่หน้าผากในระยะประมาณ ๑–๕ เซนติเมตร ปลอดภัย และลดการแพร่เชื้อความเร็วและแม่นยำแสดงผลรวดเร็วภายใน ๐.๕ วินาที มีค่าความคลาดเคลื่อนต่ำประมาณ ±๐.๒ องศาเซลเซียส วัดอุณหภูมิร่างกายได้ในช่วง ๓๒.๐–๔๓.๐ องศาเซลเซียส และสามารถปรับโหมดเพื่อวัดอุณหภูมิพื้นผิววัตถุหรือสิ่งของได้ หน้าจอแสดงผลใช้จอ LCD พร้อมระบบ ๓ สี (เช่น สีฟ้าปกติ, สีเหลืองไข้ต่ำ, สีแดงไข้สูง) และมีเสียงเตือนเมื่อพบอุณหภูมิเกินกำหนด ใช้แบตเตอรี่ขนาด AA หรือ AAA มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน **ข้อบ่งชี้** : ใช้การคัดกรองไข้เบื้องต้น ลดการแพร่กระจายเชื้อ และวัดอุณหภูมิในกลุ่มคนจำนวนมากอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสัมผัสร่างกาย **อายุการใช้งาน** : - ปี	เครื่อง
๔	เครื่องชั่งน้ำหนักบบหน้าปัดกลม 	**ลักษณะ** : แบบเข็มหน้าปัดกลม เครื่องชั่งน้ำหนักเป็นแท่นเหยียบแบบตั้งพื้น แท่นเป็นเหล็กหรือชนิดอื่นที่แข็งแรง ขนาดแท่นไม่น้อยกว่า ๒๘ x ๓๘.๕ เซนติเมตร สามารถชั่งน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ **ข้อบ่งชี้** : ใช้การคัดกรองไข้เบื้องต้น ลดการแพร่กระจายเชื้อ และวัดอุณหภูมิในกลุ่มคนจำนวนมากอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสัมผัสร่างกาย **อายุการใช้งาน** : ๓ – ๕ ปี	อัน
๕	ราวหัดเดินคู่ขนาน 	**ลักษณะ** : พื้นบาร์ทำด้วยไม้เนื้อแข็ง ความยาวขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เซนติเมตร ความกว้างขนาดไม่น้อยกว่า๗๕ เซนติเมตร ความหนาขนาดไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ปลายทั้งสองข้างลาดลง เคลือบด้วยน้ำมันยูรีเทนแลคเกอร์ เสาบาร์จำนวน ๔ เสา (เป็นเสาสองท่อนสวมกัน) ราวจับ จำนวน ๒ ราว ซ้าย – ขวา ชุดหัวปรับความสูงผลิตจากพลาสติก มีความทนทานสูงพร้อมแกนสเตนเลสล็อก **ข้อบ่งชี้** : ช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาการทรงตัวหรือสูญเสียความสามารถในการเดิน โดยมักใช้กับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ที่มีกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง ผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกหรือข้อ รวมถึงผู้ที่ต้องฝึกยืนและลงน้ำหนักอย่างปลอดภัยเพื่อ ลดความเสี่ยงการหกล้ม **อายุการใช้งาน :** ไม่น้อยกว่า ๓ ปี	ชุด

ลำดับ...

ลำดับ	รายการ	รายละเอียด	หน่วย
๖	บันไดเข้ามุมสำหรับฝึกเดิน 	**ลักษณะ :** โครงและราวบันไดทำจากไม้เนื้อเข็ง มีขั้นบันไดแบบเข้ามุม ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๖ นิ้ว ความสูงของลูกบันไดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว มีที่พักบันได กว่าง,ยาว ไม่น้อยกว่า ๓๕x๓๕ นิ้ว มีราวบันไดทั้ง๒ด้าน **ข้อบ่งชี้ :** การฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาการขึ้นลงที่สูง การทรงตัวไม่ดี และกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง เพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย **อายุการใช้งาน :** ไม่น้อยกว่า ๓ ปี	ชุด
๗	เตียงไม้ชนิดเตียงเตี้ย 	**ลักษณะ :** เป็นเตียงโครงสร้างไม้แข็งแรง พื้นเตียงเรียบมั่นคง ความสูง ๓๐ – ๔๕ ซม. ความกว้าง ๙๐ – ๑๒๐ ซม. ความยาว ๑๘๐ – ๒๐๐ ซม. **ข้อบ่งชี้ :** ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ฝึกการเคลื่อนไหว ฝึกทรงตัว ยืดกล้ามเนื้อ และทำกิจกรรมกายภาพบำบัดต่าง ๆ เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือผู้ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว เพื่อช่วยให้การฟื้นฟูมีความปลอดภัยและสะดวกมากขึ้น **อายุการใช้งาน :** ไม่น้อยกว่า ๕ ปี	ชุด
๘	เตียงไม้ ชนิดเตียงสูง 	**ลักษณะ :** เป็นเตียงโครงสร้างไม้แข็งแรง พื้นเตียงเรียบมั่นคง ความสูง ๗๐ – ๙๐ ซม. ความกว้าง ๙๐ – ๑๒๐ ซม. ความยาว ๑๘๐ – ๒๐๐ ซม. **ข้อบ่งชี้ :** ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ฝึกการเคลื่อนไหว ฝึกทรงตัว ยืดกล้ามเนื้อ และทำกิจกรรมกายภาพบำบัดต่าง ๆ เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือผู้ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว เพื่อช่วยให้การฟื้นฟูมีความปลอดภัยและสะดวกมากขึ้น **อายุการใช้งาน :** ไม่น้อยกว่า ๕ ปี	ชุด

ลำดับ...

ลำดับ	รายการ	รายละเอียด	หน่วย
๙	เตียงซัสเพนชั่น 	**<u>ลักษณะ</u> :** โครงเหล็กหรือไม้ ทำด้วยเหล็กอบสีกันสนิมหรือไม้เนื้อแข็งเคลือบสีกันเงา มีความแข็งแรงทนทาน โครงตาข่าย มีตาข่ายสำหรับเกี่ยวอุปกรณ์แขวนอยู่ด้านบน (เพดาน) ด้านหลัง และด้านข้าง ขนาดโดยประมาณ ความกว้างฐานประมาณ ๑๐๐-๑๐๕ ซม. ความยาวประมาณ ๒๒๐ ซม. และความสูงประมาณ ๑๙๐ ซม เบาะนอน บุด้วยฟองน้ำอัดหรือฟองน้ำหนาประมาณ ๒ นิ้ว หุ้มด้วยหนังเทียม PVC ทำความสะอาดง่าย ขนาดเตียง กว้างประมาณ ๑๐๐ ซม. และยาวประมาณ๒๐๐ ซม อุปกรณ์การใช้งานดังนี้ ๑. สายสลิง แบบซิงเกิลโรพ ยาว ๒ เมตรจำนวน ๑๒ เส้น ๒.ผ้าพยุงลำตัว ขนาด ๑๑ x ๒๗ นิ้ว จำนวน ๒ ชิ้น ๓. ผืนผ้าพยุงแขนขา ขนาด ๖ x ๒๖ นิ้ว จำนวน ๖ ผืน ๔. ผ้าพยุงศีรษะ ขนาด ๘ x ๐ นิ้ว จำนวน ๒ ผืน ๕. ผ้าสามห่วง ขนาด ๑.๕ x ๓๘นิ้ว นิ้ว จำนว๔ เส้น ๖. สปริงก์อย่างละ ๒ ชุด ขนาด ๑๐/๒๐/๒๑-๓๐/๓๑-๔๐ และ ๔๑/๕๐ ปอนต์ รวม ๘ ชิ้น ๗. ตะขอตัวเอส จำนวน ๑๒ ตัว **<u>อายุการใช้งาน</u> :** ไม่น้อยกว่า ๕ ปี	ชุด
๑๐	จักรยานแบบนั่งปั่นอยู่กับที่มีพนักพิงแบบปรับระดับได้ 	**ลักษณะ :** ทำจากเหล็กกล้าพ่นสีกันสนิม รองรับน้ำหนักผู้ใช้ได้ดี (๑๐๐–๑๓๐ กิโลกรัม) เบาะและพนักพิงหลังโปร่งระบายอากาศ รองรับเอวและหลัง การปรับระดับเบาะนั่งปรับเลื่อนระยะหน้า-หลังด้วยแกนรางเลื่อน ระบบแม่เหล็ก (Magnetic) หรือระบบไฟฟ้า ปรับความฝืดได้หลายระดับ (เช่น ๘ ถึง ๓๒ ระดับ)จานน้ำหนัก น้ำหนักเหมาะสมเพื่อให้การปั่นลื่นไหล ไม่สะดุด และนุ่มนวลต่อข้อต่อบันไดปั่นมีสายรัดข้อเท้าปรับขนาดได้ ป้องกันเท้าลื่นหลุดขณะปั่น **ข้อบ่งชี้ :** ใช้เพื่อฟื้นฟูร่างกาย ที่มีความปลอดภัยสูง เหมาะสำหรับผู้มีอาการปวดหลัง, ผู้มีปัญหาข้อเข่า, และผู้สูงอายุ **อายุการใช้งาน :** ไม่น้อยกว่า ๕ ปี	เครื่อง

ลำดับ...

ลำดับ	รายการ	รายละเอียด	หน่วย
๑๑	ชุดอุปกรณ์ออกกำลังกาย ถุงทราย 	**ลักษณะ** : ตัวถุงทรายผลิตจากวัสดุผ้าหนา ไนลอน ที่มีความแข็งแรง ทนต่อการฉีกขาด น้ำหนักของถุงทรายในชุดอย่างน้อยประกอบด้วย ๐.๕ กิโลกรัม ๑ กิโลกรัม ๒ กิโลกรัม ๓ กิโลกรัม หรือเทียบเท่า **ข้อบ่งชี้** : สำหรับใช้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยหลังผ่าตัด หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อ **อายุการใช้งาน** : ไม่น้อยกว่า ๑ ปี	ชุด
๑๒	กระดานบริหารต้นขา 	**ลักษณะ** : โครงสร้างผลิตจากไม้เนื้อแข็ง เหล็ก หรือวัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทาน รองรับการใช้งานต่อเนื่องได้ดี พื้นผิวกระดานเรียบ แข็งแรง ขนาดของกระดานไม่น้อยกว่า ๓๐ × ๑๐๐ × ๑๐ เซนติเมตร (กว้างxยาวx สูง) **ข้อบ่งชี้** : สำหรับใช้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือผู้ที่มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง **อายุการใช้งาน** : ไม่น้อยกว่า ๕ ปี	ชุด
๑๓	รอกเหนือศีรษะบริหารข้อไหล่ (Overhead pulley) 	**ลักษณะ** : ผลิตจากเหล็ก สเตนเลส หรือวัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทาน และป้องกันการเกิดสนิมประกอบด้วยชุดรอก ลูกล้อ เชือก และมือจับ สำหรับใช้ดึงบริหารข้อไหล่ ระบบรอกสามารถหมุนได้ลื่นไหล ไม่สะดุด และรองรับการใช้งานต่อเนื่องได้ดี เชือกสำหรับดึงบริหารผลิตจากวัสดุไนลอนหรือวัสดุสังเคราะห์ที่มีความเหนียว แข็งแรง และทนต่อแรงดึง มือจับออกแบบให้จับถนัดมือ ไม่ลื่น **ข้อบ่งชี้** : สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ที่มีภาวะข้อไหล่ติด หรือผู้ที่ต้องการฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ **อายุการใช้งาน** : ไม่น้อยกว่า ๕ ปี	ชุด

ลำดับ...

ลำดับ	รายการ	รายละเอียด	หน่วย
๑๔	วงล้อบริหารข้อไหล่ (Shoulder wheel) 	**ลักษณะ :** ผลิตจากเหล็ก สเตนเลส หรือวัสดุ ที่มีความแข็งแรง ทนทาน และป้องกันการเกิดสนิม ตัววงล้อสามารถหมุนได้รอบทิศทางอย่างต่อเนื่อง วงล้อมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร สามารถปรับระดับความสูงของวงล้อได้ **ข้อบ่งชี้ :** สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ที่มีภาวะข้อไหล่ติด หรือผู้ที่ต้องการฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ **อายุการใช้งาน :** ไม่น้อยกว่า ๕ ปี	ชุด
๑๕	แผ่นประคบร้อนไฟฟ้าปรับระดับความร้อนได้ 	**ลักษณะ :** ปรับอุณหภูมิได้หลายระดับตั้งแต่ ๓๐ ถึง ๗๐ องศาเซลเซียส หรือเลือกได้ ๖ ถึง ๑๐ ระดับความร้อนตามความต้องกา มีขนาด เช่น ๓๐x๔๕ ซม. หรือขนาดใหญ่พิเศษ ๔๐x๖๐ ซม. มีระบบตัดไฟอัตโนมัติหรือฟังก์ชันตั้งเวลาปิด (เช่น ๓๐ นาทีถึง ๒ ชั่วโมง) เพื่อป้องกันความร้อนที่สูงเกินไป **ข้อบ่งชี้ :** เพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ คลายกล้ามเนื้อที่ตึงเกร็ง **อายุการใช้งาน :** ไม่น้อยกว่า ๒ ปี	แผ่น
๑๖	รายการวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ อื่นๆ สามารถขอรับสนับสนุนงบประมาณได้ โดยให้คณะกรรมการกองทุน เป็นผู้พิจารณาอนุมัติตามความจำเป็นและเหมาะสม		

๑๐. การรายงานผล

๑๐.๑ รายงานผลการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์มที่กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยองกำหนด

๑๐.๒ รายละเอียดค่าใช้จ่าย (รายรับ-รายจ่าย)

๑๐.๓ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง, ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ, ใบสำคัญรับเงิน, ใบเสร็จรับเงิน, ใบส่งของ, สำเนาบัตรประจำตัวหรือเอกสารของผู้รับเงิน (เอกสารร้านค้า) เป็นต้น

๑๐.๔ ภาพถ่ายกิจกรรม เช่น รูปป้ายโครงการ, รูปการดำเนินกิจกรรมจะต้องเป็นรูปปัจจุบันเท่านั้น ไม่น้อยกว่า ๑๐ ภาพ

๑๐.๕ อื่นๆ เช่น แบบประเมินความพึงพอใจ (ถ้ามี)

ตัวอย่าง

แบบฟอร์มโครงการขอรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง
(โครงการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน)

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๙ ข้อ ๒๑ (๒) ให้คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจหน้าที่ “ให้พิจารณาอนุมัติแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม รวมทั้งแผนดูแลรายบุคคลสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ” ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ตามประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติฯ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑

จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ชื่อ ☐ แผนงาน ☐ โครงการ ☐ กิจกรรม

.....

๒. ชื่อ ☐ หน่วยงาน ☐ องค์กร ☐ กลุ่มประชาชน

.....

๓. หลักการและเหตุผล (สาเหตุและความจำเป็นต้องมีโครงการ)

กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยองมีแนวคิดจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ป่วยระยะท้าย มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดการบูรณาการงานบริการด้านสาธารณสุขร่วมกัน โดยร่วมกันคิดและออกแบบการบริหารจัดการภายในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพสร้างสุขใกล้บ้าน ให้เป็นไปตามระเบียบ

ปัจจุบันปัญหาสุขภาพของประชากรในประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญของโครงสร้างประชากรจากปรากฏการณ์ “เกิดน้อย อายุยืน และแรงงานหดตัว” อย่างรวดเร็ว จนกำลังจะเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super Aged Society) คือจะมีผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๒๘ ภายในเวลาไม่ถึง ๑๐ ปีข้างหน้า (ที่มา: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล) ประกอบกับผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ (NCDs) เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และอาการอัมพฤกษ์หรืออัมพาต ส่งผลให้เกิดความพิการได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบบริการ การดูแลสุขภาพต่อเนื่องในระยะยาว โดยเฉพาะการเข้าถึงบริการด้านการฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและอาการอัมพฤกษ์หรืออัมพาต มีความยุ่งยากที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมาโรงพยาบาล โดยเฉพาะในเขตชนบทที่ไม่มียานพาหนะของตนเอง เข้าถึงบริการได้น้อย ปัญหาสำคัญจากการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้มีสาเหตุดังนี้

(๑) ความเจริญทางด้านการแพทย์ทำให้ผู้ป่วยภาวะวิกฤตมีชีวิตรอดเพิ่มขึ้น แต่ก็กลายเป็นผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงมากขึ้น

(๒) โรงพยาบาลเน้นการดูแลผู้ป่วยระยะเฉียบพลัน แต่อาจจะดูแลผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันในชุมชนไม่ทั่วถึง

(๓) ระบบบริการปฐมภูมิมีข้อจำกัดด้านบุคลากรทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีปัญหาด้านการฟื้นฟูสุขภาพ เมื่อกลับไปดูแลต่อเนื่องที่บ้าน รวมทั้งขาดการเชื่อมโยงในการดูแลต่อเนื่อง จึงเกิดช่องทางการให้บริการเพิ่มขึ้น

ปัจจุบัน...

ปัจจุบันหน่วยงาน.....ทำงานเชื่อมโยงกับ..... มีประชากรในพื้นที่รวมทั้งสิ้น จำนวน.....คน ดังนี้

(๑) คนพิการ จำนวน.....คน

(๒) ผู้สูงอายุ จำนวน.....คน

(๓) ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน จำนวน.....คน

(๔) ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน.....คน

ทั้งนี้ อาจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ แต่เนื่องจากผู้ดูแลที่บ้านไม่มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้นหน่วยงาน..... จึงได้จัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้านขึ้น เพื่อให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพต่อเนื่อง ทำให้คุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายดีขึ้น

๔. วัตถุประสงค์ (แสดงความต้องการให้เกิดอะไร เพื่อประโยชน์ของประชาชนในจังหวัดที่ขอรับเงินกองทุนฯ)

๔.๑ เพื่อจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน

๔.๒ เพื่อพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพให้ต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน

๔.๓ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

๕. กลุ่มเป้าหมาย

ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ป่วยระยะท้าย มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของตำบล .....มีประชากรในพื้นที่รวมทั้งสิ้น จำนวน.....คน ดังนี้

๕.๑ คนพิการ จำนวน.....คน

๕.๒ ผู้สูงอายุ จำนวน.....คน

๕.๓ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน จำนวน.....คน

๕.๔ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน.....คน

๖. วิธีดำเนินการ (การให้รายละเอียดในการดำเนินการ ทำอย่างไรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงระเบียบ ข้อบังคับหลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงิน)

๖.๑ เตรียมความพร้อมด้านการจัดตั้งศูนย์ (ก่อนขออนุมัติโครงการ ต้องมีความพร้อมของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน ตามแนวทางที่กำหนด)

๖.๒ สำรวจข้อมูลคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ป่วยระยะท้ายมีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ และจัดให้มีหน่วยงานภาครัฐรองรับการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพสร้างสุขใกล้บ้าน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยลักษณะการดำเนินงานมีการบริหารจัดการ หรือมีการให้บริการในลักษณะภาพรวมของหลายตำบลที่มีพื้นที่คาบเกี่ยวกัน

๖.๓ กำหนดสถานที่ดำเนินงาน และจัดหาบุคลากรรับผิดชอบงานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน เป็นการติดต่อ ประสานงาน และดำเนินการเอกสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๖.๔ จัดประชุมแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน

๖.๕ เสนอโครงการฯ ตามขั้นตอนของหน่วยงานผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และส่งเข้ามายังกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยองอนุมัติ และทำสัญญาบันทึกข้อตกลง และดำเนินการโครงการฯ ตามแนวทางที่กำหนด

๖.๖ รายงาน...

๖.๖ รายงานผลการดำเนินการ ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพสร้างสุขใกล้บ้าน ส่งแบบประเมินความพึงพอใจ จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการประจำปี ให้กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยองทราบ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

๗. ระยะเวลาดำเนินการ (ควรมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการ)

วันที่..... (นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ และได้ทำบันทึกข้อตกลง)

๘. สถานที่ดำเนินการ (ควรระบุสถานที่ให้ชัดเจน)

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน.....

ที่ตั้ง:.....

๙. งบประมาณ (ให้สอดคล้องกับวิธีการดำเนินการ)

ขอรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง จำนวนเงิน.....บาท (.....) ดังนี้ รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนด)

๑๐.๑ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน

๑๐.๒ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพให้ต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน

๑๐.๓ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพมากขึ้น

๑๑. องค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

๑๑.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น .....

๑๑.๒ หน่วยงานสาธารณสุข .....

๑๑.๓ หน่วยบริการ .....

๑๑.๔ สถานบริการ .....

๑๑.๕ อื่นๆ .....

๑๒. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ

ข้าพเจ้า.....(ชื่อ-สกุล).....ตำแหน่ง.....

หน่วยงาน.....หมายเลขโทรศัพท์.....

ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.....

ขอรับรองว่าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม..... ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ในครั้งนี้

☐ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น และเพื่อให้การจ่ายเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม่ซ้ำซ้อนกับการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ ให้พิจารณาดำเนินงาน ดังนี้

☐ ดำเนินงานในโครงการขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

☐ ดำเนินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่เป็นภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดสามารถดำเนินการได้เอง

ดำเนินงาน...

☐ ดำเนินงานตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมในลักษณะที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องหรือมีประชาชนที่ได้รับประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นมากกว่า ๑ แห่งขึ้นไป

☐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร้องขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานแทน

☐ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงาน ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๙ และตามระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๙

๑๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล:.....ตำแหน่ง:.....

สถานที่ติดต่อ:.....โทรศัพท์:.....E-mail:.....

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ

(.....)

ประธานอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(.....)

ประธานกรรมการกองทุนหลักประสุขภาพจังหวัดระยอง

<u>หมายเหตุ</u>: ผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง จะต้องเขียนโครงการให้ละเอียดเพื่อให้คณะกรรมการกองทุน พิจารณาว่าเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๙

รายละเอียดแนบท้ายโครงการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน.....

ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ประยุกต์ ดัดแปลงเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท (.....บาทถ้วน)				

.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

ตารางรายชื่ออาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน .....

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	วัน/เดือน/ปี (เกิด)	ที่อยู่	ผ่านการอบรม	หมายเหตุ
				เช่น หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร ๗๐ ชม. (กรมอนามัย) วันที่	
				เช่น หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร ๗๐ ชม. (กรมอนามัย) วันที่	
				เช่น หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร ๗๐ ชม. (กรมอนามัย) วันที่	
				เช่น หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร ๗๐ ชม. (กรมอนามัย) วันที่	
				เช่น หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร ๗๐ ชม. (กรมอนามัย) วันที่	
				เช่น หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร ๗๐ ชม. (กรมอนามัย) วันที่	

หมายเหตุ: หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย (๖) ของระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๙

ตารางข้อมูลผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน.....

บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	จำนวนประชากร (คน)			ผู้สูงอายุ (คน)		จำนวนคนพิการ (คน)		ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน		ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง		หมายเหตุ
			ชาย	หญิง	รวม	ทั้งหมด	ต้องได้รับการฟื้นฟูฯ	ทั้งหมด	ต้องได้รับการฟื้นฟูฯ	ทั้งหมด	ต้องได้รับการฟื้นฟูฯ	ทั้งหมด	ต้องได้รับการฟื้นฟูฯ	

ตารางปฏิบัติงานของอาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน .....

ตำบล..... อำเภอ ..... จังหวัดระยอง / ที่ตั้ง .....

ประจำเดือน ..... พ.ศ.....

วัน เดือน ปี	ช่วงเช้า (๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.)	ช่วงเช้า (๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.)	หมายเหตุ
วันจันทร์	**ตัวอย่าง กิจกรรมฟื้นฟูให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง และกิจกรรมฟื้นฟู NCD ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน โดย อาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพสร้างสุขใกล้บ้าน**	**ออกเยี่ยมบ้าน Home visit ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง โดย อาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน**	
วันอังคาร			
วันพุธ			
วันพฤหัสบดี			
วันศุกร์			



คำสั่งเทศบาล/อบต.....

ที่ /๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน .....

ด้วยหน่วยงาน.....ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ในการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน เพื่อจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นในชุมชน สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ป่วยระยะท้าย มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการ การพัฒนารูปแบบดูแลช่วยเหลือ และฟื้นฟูสมรรถภาพของกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในระดับชุมชน และที่บ้าน โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชน

เพื่อให้การดำเนินงานการจัดบริการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน เป็นไปตามระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๙ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน ประกอบด้วย

๑. นายอำเภอ.....	เป็นที่ปรึกษา
๒. สาธารณสุขอำเภอ.....	เป็นที่ปรึกษา
๓. ผู้อำนวยการโรงพยาบาล.....	เป็นที่ปรึกษา
๔. นายกเทศมนตรีตำบล/นายก อบต.....	ประธานกรรมการ
๕. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.....	รองประธานกรรมการ
๖. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....	กรรมการ
๗. ประธาน อสม. ตำบล.....	กรรมการ
๘. ผู้แทนอสม. หมู่ที่..... ตำบล.....	กรรมการ
๙. กำนันตำบล/ประธานชุมชน.....	กรรมการ
๑๐. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่.... ตำบล.....	กรรมการ
๑๑. ประธานชมรมผู้สูงอายุ	กรรมการ
๑๒. ประธานคนพิการ	กรรมการ
๑๓. ผู้แทนด้านการศึกษา (โรงเรียน)	กรรมการ
๑๔. ผู้แทนภาคเอกชน	กรรมการ
๑๕. แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู หรือนักกายภาพบำบัด	กรรมการ
๑๖. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม หรือกองสาธารณสุข	กรรมการและเลขานุการ
๑๗. เจ้าหน้าที่ ที่ผู้บริหารมอบหมาย	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล /ศูนย์บริการสาธารณสุข	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่...

อำนาจหน้าที่

(๑) บริหารจัดการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน และดำเนินงานตามโครงการฯ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง

(๒) ประสาน พร้อมจัดทำข้อมูลและแผนการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่และใกล้เคียง เช่น ที่ว่าการอำเภอ โรงพยาบาลอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่และใกล้เคียง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ หน่วยบริการปฐมภูมิ องค์กรคนพิการ องค์กรผู้สูงอายุ เพื่อให้ได้ข้อมูลคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน พร้อมรวบรวมเอกสาร ข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นฐานข้อมูลของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน เป็นต้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั้งในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน และที่บ้าน

(๓) มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน ตามหลักเกณฑ์ และแนวทางที่กำหนด พร้อมจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ รวมถึงรายงานการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย

(๔) วางแผนการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน ที่จำเป็นต้องใช้ตามรายการที่กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยองประกาศใช้

(๕) จัดทำกรอบงบประมาณ/แผนการใช้จ่ายเงิน/แผนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน/โครงการ/พิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน/ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน

(๖) สนับสนุนงานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน

(๗) ออกข้อกำหนด ข้อบังคับ แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน มีประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐานยิ่งขึ้น ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบของกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง

(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ เดือน..... พ.ศ.....

(.....)

นายกอบต/เทศมนตรี.....

ข้อมูลทะเบียนประวัติอาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน

ข้อมูลทะเบียนอาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน

ภาพถ่าย หน้าตรง ๑ นิ้ว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล.....

ส่วนที่ ๑. ข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน

ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว) .....

อายุ .....ปี วัน/เดือน/ปีเกิด .....

เลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก .....

อยู่บ้านเลขที่ ..... ซอย/ตรอก..... ถนน ..... หมู่ที่ .....

ตำบล ..... อำเภอ ..... จังหวัด .....

รหัสไปรษณีย์ ..... หมายเลขโทรศัพท์ .....

E-mail ..... ID – Line .....

สถานภาพสมรส ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หม้าย ( ) หย่า

วุฒิการศึกษา ( ) ประถม..... ( ) มัธยมต้น ( ) มัธยมปลาย ( ) อนุปริญญา/ต่ำกว่าปริญญาตรี

( ) ปริญญาตรี ( ) ปริญญาโท ( ) อื่นๆ ระบุ .....

เอกสารแนบประกอบการขึ้นทะเบียนอาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน

( ) สำเนาบัตรประชาชน ( ) สำเนาทะเบียนบ้าน ( ) อื่นๆ ระบุ .....

( ) สำเนาใบประกาศ หรือใบรับรองที่เคยผ่านการอบรม ( ) ภาพถ่ายการอบรม

การเคยดำรงตำแหน่ง CG / อสม. / อพม. หรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่

( ) เคยเป็น ..... เมื่อ พ.ศ. ..... ถึงปี พ.ศ. ..... ระยะเวลารวม .....

( ) ไม่เคยดำรงตำแหน่งใด .....

ประวัติการอบรมด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ คนพิการ

วัน เดือน ปี / ปีที่อบรม	ชื่อโครงการ / หลักสูตร	หน่วยงานผู้จัด

(ลงชื่อ) .....

(.....)

อาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน

(ลงชื่อ) .....

(.....)

..... ผู้รับรอง

แนบเอกสารดังนี้

๑. สำเนาบัตรประชาชน / ถ่ายสำเนา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนาทะเบียนบ้าน / ถ่ายสำเนา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

๓. สำเนาใบประกาศ / สำเนาวุฒิบัตร / ใบรับรองที่ผ่านการอบรม / สำเนากำหนดการอบรมหลักสูตรเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน (ผู้สูงอายุ / คนพิการ / คนป่วย) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

๔. ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบการอบรมที่ผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓ – ๔ ภาพ

<u>หมายเหตุ:</u>

ตามประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน ข้อ ๓ คุณสมบัติของอาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน กล่าวว่า “ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน” หมายความว่า บุคคลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน ๗๐ ชั่วโมง ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้มีการอบรม โดยได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หรือหลักสูตรการอบรมมาตรฐาน ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด , อำเภอ , หน่วยบริการ , สถานบริการด้านสาธารณสุข , โรงพยาบาลในเขตจังหวัด , อำเภอเป็นผู้จัดการอบรมให้ความรู้ และผ่านการคัดเลือกในรูปแบบของคณะกรรมการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน ส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน มายังกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง เพื่อประกาศรายชื่อขึ้นทะเบียนเป็นอาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน

ตัวอย่างแบบรายงานผลการดำเนินโครงการ

โครงการ.....

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....

รายงาน ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

๑. ชื่อหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณกองทุนฯ :.....

๒. งบประมาณ

๒.๑ งบประมาณโครงการที่ได้รับ.....บาท (..... .....)

๒.๒ งบประมาณที่ได้ใช้ไปในการดำเนินงานโครงการ.....บาท (.....)

๒.๓ งบประมาณคงเหลือ.....บาท (..... .....) (ถ้ามี)

๓. ผลการดำเนินการ

๓.๑ ผู้ได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ขอรายงานผลการดำเนินโครงการ ตามบันทึกข้อตกลงการรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง เลขที่...../วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....และเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่...เดือน.....พ.ศ.....

๓.๒ ผู้ได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ขอส่งสำเนาเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานอื่น จำนวน..... ฉบับ จำนวนเงิน.....บาท (.....) ของการดำเนินการตามโครงการที่ได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง มาพร้อมหนังสือฉบับนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อไป

๓.๓ ผู้ได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ขอส่งเงินงบประมาณคงเหลือ (ถ้ามี) จำนวน.....บาท มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

๓.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ (เขียนให้เห็นว่าเกิดประโยชน์กับประชาชนในเขตพื้นที่อย่างไร)

.....

.....

๔. ผู้ได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ เนื่องจาก.....
จึงขอส่งเงินคืน จำนวน.....บาท (.....) มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

๕. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

☐ ไม่มี

☐ มี

ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ)..... .....

แนวทางการแก้ไข (ระบุ)..... .....

๖. เอกสารประกอบการรายงานผลการดำเนินแผนงาน

☐ ภาพถ่าย

☐ อื่น ๆ ระบุ.....

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน (ผู้ได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง)

(.....)

ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ: กรณีองค์กรหรือกลุ่มประชาชน ลงนามไม่น้อยกว่า จำนวน ๓ คน

เอกสารแนบท้าย (๖)

ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๙

หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าใช้จ่าย ที่สนับสนุนและส่งเสริมโครงการด้านพัฒนาศักยภาพ การมีส่วนร่วม และงานวิชาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยบริการสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชนในจังหวัด เพื่อให้การบริการสาธารณสุขและการแก้ปัญหาสุขภาพด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นในพื้นที่ให้มีศักยภาพและเข้มแข็งมากขึ้น (ตามประกาศ ข้อ ๑๑ (๒)) โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง มีแนวทาง ดังนี้

๑. ประเภทการสนับสนุน

- การสนับสนุนและส่งเสริมด้านการพัฒนาศักยภาพ การมีส่วนร่วม และงานวิชาการ

๒. การขอรับงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หน่วยบริการระดับปฐมภูมิ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สามารถขอรับงบประมาณตามความจำเป็นเหมาะสม และจัดในหน่วยงานราชการ และอัตราค่าใช้จ่ายตามที่ระเบียบราชการกำหนด

๓. ขอบเขตกิจกรรมที่ให้การสนับสนุน

๓.๑ <u>โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อาสาสมัคร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพ</u> เช่น

(๑) การอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (CG) ๗๐ ชั่วโมง/๔๒๐ ชั่วโมง

(๒) การอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง ๗๐ ชั่วโมง

(๓) การอบรมฟื้นฟูความรู้ (Refresher Course) ประจำปี สำหรับ CM/CG/อสม.

(๔) การอบรมช่างชุมชน เพื่อซ่อมแซมกายอุปกรณ์หรือปรับสภาพบ้าน

(๕) การอบรมทักษะเฉพาะทาง เช่น การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม การทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น

หมายเหตุ: <u>การพัฒนาศักยภาพด้านอื่น ๆ สามารถขอรับสนับสนุนงบประมาณได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณา</u> และต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง โดยไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๙

๔. หลักเกณฑ์การพิจารณา

๔.๑ ความจำเป็น หัวข้อการอบรมหรือวิจัยต้องตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพเร่งด่วน หรือเป็นการปิดช่องว่างทางทักษะของบุคลากรในพื้นที่

๔.๒ มาตรฐานหลักสูตร กรณีจัดอบรม ต้องมีหลักสูตรที่ชัดเจน หรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานวิชาชีพ เช่น กรมอนามัย สภาพวิชาชีพ เป็นต้น

๔.๓ ความคุ้มค่า...

๔.๓ ความคุ้มค่า งบประมาณต้องเป็นไปตามระเบียบราชการ เช่น ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ และเน้นผลลัทธ์ที่นำไปใช้ได้จริง

๔.๔ ไม่ซ้ำซ้อนกับภารกิจปกติหรืองบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัด

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

๕.๑ ให้ดำเนินการภายในปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม – ๓๐ กันยายน)

๕.๒ กรณีงานวิจัยหรือโครงการต้องระบุแผนงานระยะเวลาดำเนินการให้เสร็จภายในปีงบประมาณ หากเกินระยะเวลาต้องดำเนินการจัดทำหนังสือขอขยายเวลาโครงการ อย่างน้อย ๑ เดือน ก่อนจะสิ้นสุดโครงการ และต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง

๖. อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการ/กิจกรรม

ลำดับ	ประเภท/รายการ	หน่วย	ราคากลางต่อหน่วย (บาท)	หมายเหตุ
๑	อัตราการเบิกจ่ายค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม			
	๑.๑ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม (รัฐบาล)	คน	ไม่เกิน ๓๕ บาท	
	๑.๒ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม (เอกชน)	คน	ไม่เกิน ๕๐ บาท	
๒	อัตราการเบิกจ่ายค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม			
	๒.๑ ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม (รัฐบาล)	คน	ไม่เกิน ๘๐ บาท	
	๒.๒ ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม (เอกชน)	คน	ไม่เกิน ๒๕๐ บาท	
๓	อัตราการเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร			
	๓.๑ วิทยากร (รัฐบาล)	ชั่วโมง	ไม่เกิน ๖๐๐ บาท	
	๓.๒ วิทยากร (เอกชน)	ชั่วโมง	ไม่เกิน ๑,๒๐๐ บาท	
๔	อัตราค่าวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		ตามความจำเป็นเหมาะสม	
๕	อื่น ๆ เช่น สื่อประชาสัมพันธ์		ตามความจำเป็นเหมาะสม	

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

๗. การรายงานผล

๗.๑ รายงานผลการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์มที่กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยองกำหนด

๗.๒ รายละเอียดค่าใช้จ่าย (รายรับ-รายจ่าย)

๗.๓ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เช่น หนังสือเชิญวิทยากร, หนังสือตอบรับจากวิทยากร/หน่วยงานที่สังกัด, ใบสำคัญรับเงินค่าวิทยากร, แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, การจัดซื้อจัดจ้าง, ใบสำคัญรับเงิน, ใบเสร็จรับเงิน, ใบส่งของ, สำเนาบัตรประจำตัวหรือเอกสารของผู้รับเงิน (เอกสารร้านค้า) เป็นต้น

๗.๔ เอกสารใบลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม

๗.๕ ภาพถ่ายกิจกรรม เช่น รูปพิธีเปิด, วิทยากรบรรยาย, รูปป้ายโครงการ, รูปผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด, รูปกิจกรรมออกเยี่ยม, รูปกิจกรรมรณรงค์, รูปอาหาว่างเช้าบ่ายและรูปอาหารกลางวัน, รูปในโครงการ/กิจกรรม จะต้องเป็นรูปปัจจุบันเท่านั้น ไม่น้อยกว่า ๑๐ ภาพ

๗.๖ อื่น ๆ เช่น แบบทดสอบก่อน-หลังการอบรม แบบประเมินคะแนน (ถ้ามี)

ตัวอย่าง

แบบฟอร์มโครงการขอรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง

(โครงการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการพัฒนาศักยภาพ การมีส่วนร่วม และงานวิชาการ)

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๙ ข้อ ๒๑ (๒) ให้คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจหน้าที่ “ให้พิจารณาอนุมัติแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม รวมทั้งแผนดูแลรายบุคคลสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ” ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ตามประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติฯ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑

จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ชื่อ ☐ **แผนงาน** ☐ **โครงการ** ☐ **กิจกรรม**

.....

๒. ชื่อ ☐ **หน่วยงาน** ☐ **องค์กร** ☐ **กลุ่มประชาชน**

.....

๓. หลักการและเหตุผล (สาเหตุและความจำเป็นต้องมีโครงการ)

สถานการณ์ของปัญหาสุขภาพในพื้นที่ ขนาดของปัญหาสุขภาพในพื้นที่ .....

.....

จึงมีความจำเป็นต้องจัดแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม.....ให้แก่ (กลุ่มเป้าหมาย) จำนวน.....คน เพื่อ.....

.....

.....

.....

๔. วัตถุประสงค์ (สนับสนุนและส่งเสริมด้านการพัฒนาศักยภาพ การมีส่วนร่วม และงานวิชาการ ส่งผลให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่อย่างไร)

๑.....

๒.....

๕. กลุ่มเป้าหมาย

.....

๖. วิธีดำเนินการ (การให้รายละเอียดในการดำเนินการ ทำอย่างไรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งรวมถึงระเบียบ ข้อบังคับหลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงิน)

๑.....

๒.....

๓.....

๔.....

๗. ระยะเวลาดำเนินการ (ควรมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการ)

.....

.....

๘. สถานที่...

๘. สถานที่ดำเนินการ (ควรระบุสถานที่ให้ชัดเจน)

.....

.....

๙. งบประมาณ (ให้สอดคล้องกับวิธีการดำเนินการ)

ขอรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง จำนวนเงิน.....บาท (.....)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนด)

๑.....

๒.....

๓.....

๔.....

๑๑. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ

ข้าพเจ้า.....(ชื่อ-สกุล).....ตำแหน่ง.....
หน่วยงาน.....หมายเลขโทรศัพท์.....ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.....
ขอรับรองว่าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม..... ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ในครั้งนี้

☐ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น และเพื่อให้การจ่ายเงินกองทุนตามตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม่ซ้ำซ้อนกับการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ ให้พิจารณาดำเนินงาน ดังนี้

- ☐ ดำเนินงานในโครงการขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
- ☐ ดำเนินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่เป็นภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดสามารถดำเนินการได้เอง
- ☐ ดำเนินงานตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมในลักษณะที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องหรือมีประชาชนที่ได้รับประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นมากกว่า ๑ แห่งขึ้นไป
- ☐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร้องขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานแทน

☐ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงาน ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๙ และตามระเบียบระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๙

๑๒. ผู้รับผิดชอบ...

๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล:.....ตำแหน่ง:.....

สถานที่ติดต่อ:.....

โทรศัพท์: .....E-mail: .....

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ

(.....)

ประธานอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(.....)

ประธานกรรมการกองทุนหลักประสุขภาพจังหวัดระยอง

<u>หมายเหตุ</u> ผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง จะต้องเขียนโครงการให้ละเอียดเพื่อให้คณะกรรมการกองทุน พิจารณาว่าเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๙

(แบบประมาณการค่าใช้จ่าย)

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายแนบท้าย

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.....

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
๑		
๒		
๓		
๔		
๕		
๖		
๗		
๘		
๙		
๑๐		
๑๑		
๑๒		
๑๓		
๑๔		
๑๕		
รวม		

(ตัวหนังสือ) (.....)

<u>หมายเหตุ</u> ผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง จะต้องแสดงรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อให้ให้คณะกรรมการกองทุน พิจารณาว่าเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๙ และความจำเป็นเหมาะสมในการใช้งบประมาณกองทุน

ตัวอย่างแบบรายงานผลการดำเนินโครงการ

โครงการ.....

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....

รายงาน ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

๑. ชื่อหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณกองทุนฯ :.....

๒. งบประมาณ

๒.๑ งบประมาณโครงการที่ได้รับ.....บาท (.....)

๒.๒ งบประมาณที่ได้ใช้ไปในการดำเนินงานโครงการ.....บาท (.....)

๒.๓ งบประมาณคงเหลือ.....บาท (.....) (ถ้ามี)

๓. ผลการดำเนินการ

๓.๑ ผู้ได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ขอรายงานผลการดำเนินโครงการ ตามบันทึกข้อตกลงการรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง เลขที่...../วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....และเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่...เดือน.....พ.ศ.....

๓.๒ ผู้ได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ขอส่งสำเนาเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานอื่น จำนวน..... ฉบับ จำนวนเงิน.....บาท (.....) ของการดำเนินการตามโครงการที่ได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง มาพร้อมหนังสือฉบับนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อไป

๓.๓ ผู้ได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ขอส่งเงินงบประมาณคงเหลือ (ถ้ามี) จำนวน.....บาท มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

๓.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ (เขียนให้เห็นว่าเกิดประโยชน์กับประชาชนในเขตพื้นที่อย่างไร)

.....

.....

๔. ผู้ได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ เนื่องจาก.....จึงขอส่งเงินคืน จำนวน.....บาท (.....) มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

๕. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

☐ ไม่มี

☐ มี

ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ).....

แนวทางการแก้ไข (ระบุ).....

๖. เอกสารประกอบการรายงานผลการดำเนินแผนงาน

☐ ภาพถ่าย

☐ อื่น ๆ ระบุ.....

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน (ผู้ได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง)

(.....)

ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ: กรณีองค์กรหรือกลุ่มประชาชน ลงนามไม่น้อยกว่า จำนวน ๓ คน

เอกสารแนบท้าย (๗)

ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๙

หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าใช้จ่าย ที่สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชนในจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือกับโรคติดต่อ หรือภัยธรรมชาติ หรือภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและสังคมที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ (ตามประกาศ ข้อ ๑๑ (๓)) โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง มีแนวทาง ดังนี้

๑. ประเภทการสนับสนุน

- โครงการเตรียมความพร้อมและรับมือโรคติดต่อ หรือภัยธรรมชาติ หรือภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและสังคม

๒. การขอรับงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หน่วยบริการระดับปฐม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สามารถขอรับงบประมาณตามความจำเป็นเหมาะสม และจัดในหน่วยงานราชการ และอัตราค่าใช้จ่ายตามที่ระเบียบราชการกำหนด

๓. นิยาม

๓.๑ ภาวะฉุกเฉิน: สถานการณ์ที่มีแนวโน้มหรือเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ชีวิต ทรัพย์สิน หรือความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง

๓.๒ โรคติดต่อ: โรคที่เกิดจากเชื้อโรคหรือพิษของเชื้อโรคซึ่งสามารถแพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมมาสู่คน

๓.๓ ภัยธรรมชาติ: ภัยที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

๓.๔ ภาวะฉุกเฉินทางสังคม: เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางสังคมหรือจิตใจของประชาชน

๔. หลักเกณฑ์การพิจารณา

๔.๑ ความจำเป็นเร่งด่วน เป็นปัญหาที่หากไม่ดำเนินการจะเกิดความเสียหายต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชนในวงกว้าง

๔.๒ สถานการณ์จริง มีข้อมูลทางระบาดวิทยา มีการประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรองรับ

๔.๓ หน่วยงานที่เสนอโครงการต้องมีศักยภาพและมีความพร้อมในการดำเนินงานทันที

๔.๔ ไม่ซ้ำซ้อน ต้องตรวจสอบว่าไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณปกติ หรืองบช่วยเหลือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัด

๕. ขอบเขตการสนับสนุนงบประมาณ

๕.๑ ค่าวัสดุ เวชภัณฑ์ สารเคมีกำจัดเชื้อ/แมลง อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) วัสดุวิทยาศาสตร์

๕.๒ ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมารถ/เรือ ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่/อาสาสมัคร ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

๕.๓ ค่าตอบแทนวิทยากร หรือค่าป่วยการตามระเบียบ

หมายเหตุ : ไม่สนับสนุนค่าครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ (ยกเว้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ)

๖. การกำกับ...

๖. การกำกับ ติดตาม และประเมินผล

๖.๑ รายงานสถานการณ์ กรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ ให้รายงานความคืบหน้าเป็นระยะๆ เช่น รายสัปดาห์ ผ่านช่องทางสื่อสารที่รวดเร็ว เช่น ไลน์ โทรศัพท์ เป็นต้น

๖.๒ รายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ

- รายงานผลการดำเนินงาน สรุปจำนวนผู้ได้รับความช่วยเหลือ ผลการควบคุมโรค
- รายงานการเงิน หลักฐานการจ่ายเงิน ใบเสร็จรับเงิน
- เงินเหลือจ่าย ส่งคืนกองทุน ภายใน ๓๐ วันหลังสิ้นสุดโครงการ

๗. อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการ/กิจกรรม

ลำดับ	ประเภท/รายการ	หน่วย	ราคากลางต่อหน่วย (บาท)	หมายเหตุ
๑	อัตราการเบิกจ่ายค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม			
	๑.๑ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม (รัฐบาล)	คน	ไม่เกิน ๓๕ บาท	
	๑.๒ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม (เอกชน)	คน	ไม่เกิน ๕๐ บาท	
๒	อัตราการเบิกจ่ายค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม			
	๒.๑ ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม (รัฐบาล)	คน	ไม่เกิน ๘๐ บาท	
	๒.๒ ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม (เอกชน)	คน	ไม่เกิน ๒๕๐ บาท	
๓	อัตราการเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร			
	๓.๑ วิทยากร (รัฐบาล)	ชั่วโมง	ไม่เกิน ๖๐๐ บาท	
	๓.๒ วิทยากร (เอกชน)	ชั่วโมง	ไม่เกิน ๑,๒๐๐ บาท	
๔	อัตราค่าวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		ตามความจำเป็นเหมาะสม	
๕	อื่น ๆ เช่น สื่อประชาสัมพันธ์		ตามความจำเป็นเหมาะสม	

๘. การรายงานผล

๘.๑ รายงานผลการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์มที่กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยองกำหนด

๘.๒ รายละเอียดค่าใช้จ่าย (รายรับ-รายจ่าย)

๘.๓ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เช่น หนังสือเชิญวิทยากร, หนังสือตอบรับจากวิทยากร/หน่วยงานที่สังกัด, ใบสำคัญรับเงินค่าวิทยากร, แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, การจัดซื้อจัดจ้าง, ใบสำคัญรับเงิน, ใบเสร็จรับเงิน, ใบส่งของ, สำเนาบัตรประจำตัวหรือเอกสารของผู้รับเงิน (เอกสารร้านค้า) เป็นต้น

๘.๔ เอกสารใบลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม

๘.๕ ภาพถ่ายกิจกรรม เช่น รูปพิธีเปิด, วิทยากรบรรยาย, รูปป้ายโครงการ, รูปผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด, รูปกิจกรรมออกเยี่ยม, รูปกิจกรรมรณรงค์, รูปอาหารว่างเช้าบ่ายและรูปอาหารกลางวัน, รูปในโครงการ/กิจกรรม จะต้องเป็นรูปปัจจุบันเท่านั้น ไม่น้อยกว่า ๑๐ ภาพ

๘.๖ อื่น ๆ เช่น แบบทดสอบก่อน-หลังการอบรม แบบประเมินคะแนน (ถ้ามี)

ตัวอย่าง

แบบฟอร์มโครงการขอรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง

(โครงการเตรียมความพร้อมและรับมือโรคติดต่อ ภัยธรรมชาติ และภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและสังคม)

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๙ ข้อ ๒๑ (๒) ให้คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจหน้าที่ “ให้พิจารณาอนุมัติแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม รวมทั้งแผนดูแลรายบุคคลสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ” ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ตามประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติฯ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑

จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ชื่อ ☐ **แผนงาน** ☐ **โครงการ** ☐ **กิจกรรม**

.....

๒. ชื่อ ☐ **หน่วยงาน** ☐ **องค์กร** ☐ **กลุ่มประชาชน**

.....

๓. หลักการและเหตุผล (สาเหตุและความจำเป็นต้องมีโครงการ)

สถานการณ์ของปัญหาสุขภาพในพื้นที่ ขนาดของปัญหาสุขภาพในพื้นที่ .....

.....

จึงมีความจำเป็นต้องจัดแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม.....ให้แก่ (กลุ่มเป้าหมาย) จำนวน.....คน เพื่อ .....

๔. วัตถุประสงค์ (เตรียมความพร้อมและรับมือกับโรคติดต่อ หรือภัยธรรมชาติ หรือภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและสังคมที่เกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่อย่างไร)

๑.....

๒.....

๕. กลุ่มเป้าหมาย

.....

๖. วิธีดำเนินการ (การให้รายละเอียดในการดำเนินการ ทำอย่างไรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งรวมถึงระเบียบ ข้อบังคับหลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงิน)

๑.....

๒.....

๗. ระยะเวลาดำเนินการ (ควรมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการ)

.....

๘. สถานที่ดำเนินการ (ควรระบุสถานที่ให้ชัดเจน)

.....

๙. งบประมาณ (ให้สอดคล้องกับวิธีการดำเนินการ)

ขอรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง จำนวนเงิน.....บาท (.....)

รายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนด)

๑.....

๒.....

๑๑. คำรับรอง...

๑๑. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ

ข้าพเจ้า.....(ชื่อ-สกุล).....ตำแหน่ง.....
หน่วยงาน.....หมายเลขโทรศัพท์.....ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.....
ขอรับรองว่าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม..... ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ในครั้งนี้

☐ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น และเพื่อให้การจ่ายเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม่ซ้ำซ้อนกับการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ ให้พิจารณาดำเนินงาน ดังนี้

- ☐ ดำเนินงานในโครงการขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
- ☐ ดำเนินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่เป็นภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดสามารถดำเนินการได้เอง
- ☐ ดำเนินงานตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมในลักษณะที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องหรือมีประชาชนที่ได้รับประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นมากกว่า ๑ แห่งขึ้นไป
- ☐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร้องขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานแทน

☐ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงาน ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๙ และตามระเบียบระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๙

๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล:.....ตำแหน่ง:.....
สถานที่ติดต่อ:.....โทรศัพท์:.....E-mail:.....

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(.....)
ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
(.....)
ประธานอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
(.....)
ประธานกรรมการกองทุนหลักประสุขภาพจังหวัดระยอง

<u>หมายเหตุ</u>: ผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง จะต้องเขียนโครงการให้ละเอียดเพื่อให้คณะกรรมการกองทุน พิจารณาว่าเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๙

(แบบประมาณการค่าใช้จ่าย)

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายแนบท้าย

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.....

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
๑		
๒		
๓		
๔		
๕		
๖		
๗		
๘		
๙		
๑๐		
๑๑		
๑๒		
๑๓		
๑๔		
๑๕		
รวม		

(ตัวหนังสือ) (.....)

<u>หมายเหตุ</u> ผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง จะต้องแสดงรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อให้ให้คณะกรรมการกองทุน พิจารณาว่าเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๙ และความจำเป็นเหมาะสมในการใช้งบประมาณกองทุน

ตัวอย่างแบบรายงานผลการดำเนินโครงการ

โครงการ.....

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....

รายงาน ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

๑. ชื่อหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณกองทุนฯ :.....

๒. งบประมาณ

๒.๑ งบประมาณโครงการที่ได้รับ.....บาท (.....)

๒.๒ งบประมาณที่ได้ใช้ไปในการดำเนินงานโครงการ.....บาท (.....)

๒.๓ งบประมาณคงเหลือ.....บาท (.....) (ถ้ามี)

๓. ผลการดำเนินการ

๓.๑ ผู้ได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ขอรายงานผลการดำเนินโครงการ ตามบันทึกข้อตกลงการรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง เลขที่...../วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....และเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่...เดือน.....พ.ศ.....

๓.๒ ผู้ได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ขอส่งสำเนาเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานอื่น จำนวน..... ฉบับ จำนวนเงิน.....บาท (.....) ของการดำเนินการตามโครงการที่ได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง มาพร้อมหนังสือฉบับนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อไป

๓.๓ ผู้ได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ขอส่งเงินงบประมาณคงเหลือ (ถ้ามี) จำนวน.....บาท มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

๓.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ (เขียนให้เห็นว่าเกิดประโยชน์กับประชาชนในเขตพื้นที่อย่างไร)

.....

.....

๔. ผู้ได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ เนื่องจาก.....จึงขอส่งเงินคืน จำนวน.....บาท (.....) มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

๕. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

☐ ไม่มี

☐ มี

ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ).....

แนวทางการแก้ไข (ระบุ).....

๖. เอกสารประกอบการรายงานผลการดำเนินแผนงาน

☐ ภาพถ่าย

☐ อื่น ๆ ระบุ.....

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน (ผู้ได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง)

(.....)

ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ: กรณีองค์กรหรือกลุ่มประชาชน ลงนามไม่น้อยกว่า จำนวน ๓ คน

ประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
พ.ศ. ๒๕๖๙

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงให้มีความสอดคล้องกับบริบทการกระจายอำนาจด้านสุขภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) และ (๙) และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบมติการประชุมของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๙”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๒

(๒) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๔ ในประกาศนี้

“องค์การบริหารส่วนจังหวัด” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล เมืองพัทยาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งแต่ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานคร

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด และให้หมายความรวมถึงกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด

“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด

“การจัดบริการสาธารณสุข” หมายความว่า การบริการสาธารณสุขในชุมชน เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต นอกเหนือจากการจัดบริการปกติของหน่วยบริการ

“การสร้างเสริมสุขภาพ” หมายความว่า บริการที่มุ่งกระทำเพื่อให้บุคคลมีสุขภาพทางกายและจิตใจที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

“การป้องกันโรค” หมายความว่า บริการที่มุ่งกระทำเพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยหรือเป็นโรค และการป้องกันไม่ให้กลับเป็นซ้ำในกรณีที่หายจากการเจ็บป่วยหรือเป็นโรคแล้ว รวมถึงการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อการป้องกันโรค

“การฟื้นฟูสมรรถภาพ” หมายความว่า บริการที่มุ่งกระทำเพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพหรือความสามารถทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจให้ดีขึ้น โดยอาศัยกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ ร่วมกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การจัดหาและสนับสนุนกายอุปกรณ์ที่เหมาะสม สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมของบุคคล เพื่อให้บุคคลสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ

“การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก” หมายความว่า การจัดบริการหรือการจัดกิจกรรมสาธารณสุข ซึ่งเป็นการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเบื้องต้นในชุมชน และนอกเหนือจากการจัดบริการปกติของหน่วยบริการ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการมากขึ้น

“สถานบริการ” หมายความว่า สถานบริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

“หน่วยบริการ” หมายความว่า สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

“หน่วยงานสาธารณสุข” หมายความว่า หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรง แต่มิได้เป็นสถานบริการหรือหน่วยบริการ

“หน่วยงานอื่น” หมายความว่า หน่วยงานที่มิได้มีภารกิจด้านการสาธารณสุข

“องค์กรหรือกลุ่มประชาชน” หมายความว่า องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน ภาคเอกชน หรือบุคคลที่มีการรวมตัวกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลกำไร ทั้งนี้จะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ข้อ ๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) มีความประสงค์เข้าร่วมดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

(๒) มีงบประมาณในการสบทบเงินกองทุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน

ข้อ ๖ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยให้มีกองทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข รวมถึงการแก้ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากปัจจัยทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากพฤติกรรมส่วนบุคคล (Determinants of Health) เพื่อให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้และมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ข้อ ๗ เงินหรือทรัพย์สินในกองทุน ประกอบด้วย

(๑) เงินที่ได้รับจัดสรรแต่ละปีงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนของค่าบริการสาธารณสุขร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือค่าบริการสาธารณสุขอื่นตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเกี่ยวกับการดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่กำหนดในแต่ละปีงบประมาณ เช่น ค่าบริการแว่นตาสำหรับเด็ก ค่าบริการผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย แผ่นเสริมซึมซับ และผ้าอ้อมทางเลือกในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น

(๒) เงินสมทบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดในจำนวนไม่น้อยกว่าที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนของค่าบริการสาธารณสุขร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเงินสมทบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรณีที่ได้รับเงินจัดสรรค่าบริการสาธารณสุขอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ทั้งนี้ การสมทบเงินจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำเนินการโดยเร็วเมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณ กรณีมีความจำเป็นให้สมทบได้ไม่เกินปีงบประมาณที่สำนักงานจ่ายเงินสนับสนุน

(๓) เงินสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่นที่มีวัตถุประสงค์หรือภารกิจที่สอดคล้องกับกองทุน โดยความเห็นชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและสำนักงาน

(๔) รายได้อื่น ๆ หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองทุน

ข้อ ๘ ให้เงินกองทุนตามข้อ ๗ เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และบริหารจัดการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข้อ ๙ กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับเงินจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามข้อ ๗ (๑) แล้ว มีเงินคงเหลือไม่เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์กองทุน และมีความประสงค์ขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อาจได้รับการจัดสรรเงินเพิ่มเติม โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องสมทบเงินตามข้อ ๗ (๒)

ข้อ ๑๐ เพื่อให้การจ่ายเงินกองทุนตามประกาศนี้ไม่เป็นการซ้ำซ้อนกับการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้พิจารณาดำเนินงานในเขตจังหวัด ดังนี้

(๑) ดำเนินงานในโครงการขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือ

(๒) ดำเนินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่เป็นภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่มุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่นหรือประชาชนเป็นส่วนรวม และไม่เข้าไปดำเนินงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดสามารถดำเนินการได้เอง หรือ

(๓) ดำเนินงานตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมในลักษณะที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องหรือมีประชาชนที่ได้รับประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นมากกว่าหนึ่งแห่งขึ้นไป หรือ

(๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร้องขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานแทน

ข้อ ๑๑ เงินกองทุนตามข้อ ๗ (๑) (๒) และ (๔) ให้ใช้จ่ายตามที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติดังต่อไปนี้

(๑) สนับสนุนและส่งเสริมแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม รวมทั้งแผนการดูแลรายบุคคลสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชนในจังหวัด เพื่อส่งเสริมประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่เข้าถึงการบริการสาธารณสุขและการแก้ปัญหาสุขภาพด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นได้มากขึ้น

(๒) สนับสนุนและส่งเสริมโครงการด้านพัฒนาศักยภาพ การมีส่วนร่วม หรือวิชาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชนในจังหวัด เพื่อให้การบริการสาธารณสุขและการแก้ปัญหาสุขภาพด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นในพื้นที่ให้มีศักยภาพและเข้มแข็งมากขึ้น

(๓) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชนในจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือกับโรคติดต่อ หรือภัยธรรมชาติ หรือภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและสังคมที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่

(๔) สนับสนุนและส่งเสริมแผนงาน หรือโครงการ ในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหรือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินกองทุนตามข้อ ๗ (๑) และ ๗ (๒) ในแต่ละปีงบประมาณนั้น และกรณีมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อจัดหาครุภัณฑ์หรือจัดจ้างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ให้สนับสนุนได้ในวงเงินตามความจำเป็น และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น

(๕) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขอื่นตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมอบหมาย

เงินกองทุนที่ได้รับอนุมัติตามวรรคหนึ่ง หากต้องจัดหาครุภัณฑ์เพื่อจัดบริการสาธารณสุขให้กับบุคคล คณะกรรมการกองทุนอาจพิจารณาสนับสนุนได้ในวงเงินตามความจำเป็น เว้นแต่กรณีองค์กรหรือกลุ่มประชาชนอาจสนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกินสองหมื่นบาทต่อโครงการตามความจำเป็นและเหมาะสม และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้เป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน ที่ได้รับการสนับสนุน

การพิจารณาอนุมัติเงินกองทุนตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการกองทุนสามารถเชิญผู้แทนหน่วยงานหรือบุคคลต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐบาลหรือภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคม มาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนได้

ข้อ ๑๒ เงินกองทุนตามข้อ ๗ (๓) ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ของแหล่งทุนอื่นที่กำหนดในข้อตกลงระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงาน และหน่วยงานเจ้าของแหล่งทุนนั้น โดยการอนุมัติของคณะกรรมการกองทุน

ข้อ ๑๓ กรณีกองทุนได้รับค่าบริการสาธารณสุขอื่นเพิ่มเติมจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมแผนงาน โครงการ กิจกรรม หรือแผนการดูแลรายบุคคลตามที่สำนักงานกำหนด โดยการอนุมัติของคณะกรรมการกองทุน

ข้อ ๑๔ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบริการสาธารณสุขในพื้นที่กรณีที่มีสถานการณ์ฉุกเฉิน สถานการณ์การเกิดโรคระบาด สถานการณ์ภัยพิบัติ หรือสถานการณ์ความไม่สงบซึ่งมีความจำเป็นต้องให้การสนับสนุนหรือจัดบริการด้านสาธารณสุขอย่างเร่งด่วน และการเสนอให้คณะกรรมการกองทุนอนุมัติค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑๑ อาจไม่ทันต่อสถานการณ์หรืออยู่ในภาวะที่ไม่อาจเสนอคณะกรรมการกองทุนได้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้เป็นประธานกรรมการตามข้อ ๑๖ มีอำนาจอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขกรณีดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยให้ถือว่าโครงการหรือกิจกรรมที่ประธานกรรมการอนุมัตินั้นเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติตามประกาศนี้ และให้ประธานกรรมการรายงานให้คณะกรรมการกองทุนทราบโดยเร็ว

ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตามวรรคหนึ่ง เป็นบุคคลภายนอกเขตจังหวัดที่มีการอนุมัติโครงการหรือกิจกรรม ให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับบริการภายใต้โครงการหรือกิจกรรมตามวรรคหนึ่งเช่นเดียวกับบุคคลภายในเขตจังหวัด

ข้อ ๑๕ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทำบัญชี การรายงานของกองทุน และการกำกับติดตามเงินกองทุน ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และให้เงินในกองทุนสามารถใช้ในปีงบประมาณถัด ๆ ไปได้

ข้อ ๑๖ ให้มีคณะกรรมการกองทุน ประกอบด้วย

(๑)	ผู้ว่าราชการจังหวัด	เป็นที่ปรึกษา
(๒)	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	เป็นที่ปรึกษา
(๓)	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	เป็นประธานกรรมการ
(๔)	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด	เป็นกรรมการ
(๕)	ท้องถิ่นจังหวัด	เป็นกรรมการ
(๖)	พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด	เป็นกรรมการ
(๗)	ผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัดที่กรรมการกองทุนคัดเลือก จำนวนสองคน	เป็นกรรมการ
(๘)	ผู้แทนสถาบันการศึกษาในจังหวัด ที่กรรมการกองทุนคัดเลือก จำนวนหนึ่งคน	เป็นกรรมการ
(๙)	ผู้แทนองค์กรหรือกลุ่มประชาชนในจังหวัด ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต คัดเลือกโดยกระบวนการมีส่วนร่วม จำนวนสามคน	เป็นกรรมการ
(๑๐)	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไป ที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมอบหมาย จำนวนหนึ่งคน	เป็นกรรมการ
(๑๑)	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมอบหมาย จำนวนหนึ่งคน	เป็นกรรมการ
(๑๒)	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มอบหมาย จำนวนสองคน	เป็นกรรมการ
(๑๓)	นักกายภาพบำบัดในหน่วยบริการ ที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมอบหมาย จำนวนหนึ่งคน	เป็นกรรมการ
(๑๔)	นายกเทศมนตรีที่เป็นผู้แทนระดับจังหวัดของสมาคม สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวนหนึ่งคน	เป็นกรรมการ
(๑๕)	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นผู้แทนระดับจังหวัด ของสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย จำนวนหนึ่งคน	เป็นกรรมการ
(๑๖)	ผู้แทนศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองในจังหวัด จำนวนหนึ่งคน	เป็นกรรมการ
(๑๗)	ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขระดับจังหวัด	เป็นกรรมการ

(๑๘)	เจ้าหน้าที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ที่ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต มอบหมาย	เป็นกรรมการ
(๑๙)	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๒๐)	หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคลัง ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มอบหมาย	เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(๒๑)	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขหรือหัวหน้าส่วนราชการ ที่รับผิดชอบงานกองทุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มอบหมาย	เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(๒๒)	เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มอบหมาย	เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๑๗ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ ๑๖ (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗) (๑๘) และ (๑๙)

เมื่อได้กรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการดังกล่าวและกรรมการตามข้อ ๑๖ (๓) (๔) (๕) และ (๖) เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นกรรมการตามข้อ ๑๖ (๗) และผู้แทนสถาบันการศึกษาให้เป็นกรรมการตามข้อ ๑๖ (๘)

เมื่อได้กรรมการครบองค์ประกอบแล้ว ให้ออกคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนและแจ้งให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ทราบ

ข้อ ๑๘ ให้กรรมการตามข้อ ๑๖ (๗) ถึง (๑๘) มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ออกคำสั่งแต่งตั้ง

เมื่อครบกำหนดวาระตามวรรคหนึ่งแล้ว หากยังมิได้มีการคัดเลือกกรรมการขึ้นใหม่ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการคัดเลือกขึ้นใหม่เข้ารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่กรรมการพ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดำเนินการคัดเลือกกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตำแหน่งกรรมการนั้นว่างลง และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการซึ่งตนแทน เว้นแต่กรณีที่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ดำเนินการคัดเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างนั้นก็ได้ และในการนี้ให้คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ซึ่งยังมิได้มีการคัดเลือกกรรมการขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่

ข้อ ๑๙ กรรมการตามข้อ ๑๖ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว ให้พ้นจากตำแหน่งในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ย้ายไปดำรงตำแหน่งหรือไปประกอบอาชีพในจังหวัดอื่น

(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย

(๖) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๗) พ้นจากการดำรงตำแหน่งหรือการเป็นผู้แทนอันเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุนตามข้อ ๑๖

(๘) ขาดประชุมสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร

ข้อ ๒๐ การประชุมคณะกรรมการกองทุน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการกองทุนประจำปีที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กองทุนแล้วเสนอต่อสำนักงานเพื่อทราบ

(๒) พิจารณาอนุมัติแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม รวมทั้งแผนการดูแลรายบุคคลสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม รวมทั้งแผนการดูแลรายบุคคลสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้เทียบเคียงตามระเบียบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด

(๓) ออกระเบียบที่จำเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้

(๔) สนับสนุนให้บุคคลในท้องถิ่นหรือพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชน หรือหน่วยบริการ ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

(๕) ให้คำแนะนำในการจัดทำข้อมูลและการดำเนินงานที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุขของกลุ่มเป้าหมายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กร หรือกลุ่มประชาชน

(๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุน

ข้อ ๒๒ คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศนี้ หรือตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย และให้นำข้อ ๒๐ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน โดยอนุโลม

ข้อ ๒๓ ให้กรรมการ ที่ปรึกษาและผู้ช่วยเลขานุการ อนุกรรมการ คณะทำงาน บุคคลภายนอกที่ได้รับเชิญมาประชุม และเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจำหรือพนักงานจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน ที่ได้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการประชุม หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการประชุมแล้วแต่กรณี

ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๒๔ กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดใดมีเงินกองทุนคงเหลือมากกว่าหนึ่งเท่าของรายรับของกองทุนตามข้อ ๗ ของปีงบประมาณที่ผ่านมา สำนักงานอาจงดการจัดสรรเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามข้อ ๗ (๑) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจงดการสมทบเงินตามข้อ ๗ (๒) ของปีงบประมาณนั้น ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินกองทุนในการบริหารหรือพัฒนากองทุนตามข้อ ๑๑ (๔) ในปีงบประมาณนั้น ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินวงเงินของปีงบประมาณที่ผ่านมา

ข้อ ๒๕ เพื่อให้กองทุนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จัดให้มีกลไกสำหรับส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และดำเนินการกำกับติดตามประเมินผล โดยรายงานให้สำนักงานทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ

กรณีพบความไม่ถูกต้องในการใช้จ่ายเงินกองทุน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) ใช้สิทธิตามกฎหมายในการเรียกคืนค่าใช้จ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชนได้รับ

(๒) ระงับ หรือชะลอการจ่ายค่าใช้จ่ายที่พึงได้รับในงวดถัดไป

(๓) ดำเนินการตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการตามวรรคสองแล้ว ให้รายงานให้สำนักงานทราบโดยเร็ว

ข้อ ๒๖ กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดใดไม่สมทบเงิน หรือไม่มีการดำเนินกิจกรรมใดต่อเนื่องตั้งแต่สองปีงบประมาณขึ้นไป สำนักงานอาจเรียกเงินคืนหรือประกาศยุบเลิกกองทุนได้ และให้การโอนเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด

ข้อ ๒๗ ให้เงินกองทุน คณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และการดำเนินงานต่าง ๆ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นเงินในกองทุน เป็นคณะกรรมการกองทุน เป็นคณะอนุกรรมการ เป็นคณะทำงาน เป็นระเบียบ เป็นประกาศ เป็นหลักเกณฑ์ เป็นแนวทางปฏิบัติ และเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องตามประกาศนี้

ให้กรรมการกองทุน อนุกรรมการ และคณะทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในตำแหน่งต่อไปได้ไม่เกินเก้าสิบวันนับจากวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ ๑๖ ต่อไป

ข้อ ๒๘ การดำเนินงานใดที่สำนักงานยังไม่ได้กำหนดขึ้นตามประกาศนี้ ให้ใช้กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ของสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือส่วนราชการอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๒๙ ให้เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙
พัฒนา พร้อมพัฒน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

หมวด ๑

การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทำบัญชี และรายงานของกองทุน

---

๑. การรับเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน

๑.๑ บรรดาเงินรายรับของกองทุนให้นำส่งเข้าบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัด... ที่เปิดบัญชีกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัด.....” ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเห็นชอบ

เว้นแต่กรณีที่ได้รับเงินค่าบริการสาธารณสุขอื่น ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเปิดบัญชีกับธนาคารที่สำนักงานกำหนด โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัด... เพื่อบริการ...” แยกออกจากบัญชีกองทุนตามวรรคหนึ่ง

กรณีเงินที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับจากแหล่งทุนอื่น ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเปิดบัญชีแยกออกจากบัญชีกองทุนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ทั้งนี้ การเปิดบัญชีและชื่อบัญชีให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานเจ้าของแหล่งทุน

ทั้งนี้ บัญชีกองทุนที่ได้เปิดบัญชีไว้แล้วก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นบัญชีเงินฝากตามประกาศนี้

๑.๒ การรับเงินเข้ากองทุนให้รับเป็นเงินสด เช็ค หรือโอนเข้าบัญชีทางธนาคาร หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) หรือวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด และให้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชำระเงินทุกครั้ง เว้นแต่การรับเงินที่ได้รับการจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือการรับเงินสมทบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ใช้หลักฐานการโอนเงินทางธนาคาร หรือหลักฐานอื่นที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร เป็นหลักฐานอ้างอิงในการบันทึกบัญชีรายรับ

๑.๓ เงินสดที่กองทุนได้รับไว้ ให้นำฝากเข้าบัญชีตามข้อ ๑.๑ ภายในวันที่ได้รับเงิน หากไม่สามารถนำเงินดังกล่าวฝากเข้าบัญชีได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย นำเงินสดจำนวนดังกล่าวเก็บรวมไว้ในซองหรือหีบห่อ ระบุเงินกองทุน จำนวนเงิน ปิดผนึกลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบ และนำฝากไว้ที่ตู้นิรภัยหรือสถานที่เก็บรักษาเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วให้นำฝากเข้าบัญชีในวันทำการถัดไป

๒. การจ่ายเงินกองทุน

๒.๑ การจ่ายเงินกองทุนให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้สั่งจ่ายตามเงื่อนไขข้อ ๑๑ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ แล้วแต่กรณี เว้นแต่กรณีการจ่ายเงินกองทุนตามข้อ ๑๒ ให้เป็นตามที่กำหนดในข้อตกลงระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงาน และหน่วยงานเจ้าของแหล่งทุนนั้น

๒.๒ วิธีการจ่ายเงินกองทุนให้จ่ายได้ ดังต่อไปนี้

๒.๒.๑ จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม

๒.๒.๒ จ่ายเป็นการโอนเข้าบัญชีทางธนาคารหรือทางอิเล็กทรอนิกส์

๒.๒.๓ จ่ายวิธีอื่นตามที่ตกลงกับสำนักงาน

๒.๓ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนใดคนหนึ่งลงนามร่วมกับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด คนใดคนหนึ่ง ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายไว้จำนวนสองคน รวมเป็นผู้ลงนามหรืออนุมัติจำนวนสองคน เป็นผู้เบิกเงินจากบัญชีกองทุนตามเงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุน

๒.๔ การจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น ให้ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าของหน่วยงานนั้น ๆ เป็นผู้รับเงิน หากไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทนก็ให้กระทำได้ ทั้งนี้ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่ชัดเจน

๒.๕ การจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นองค์กรหรือกลุ่มประชาชน ให้ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรหรือกลุ่มประชาชน ไม่น้อยกว่าสองคนขึ้นไปเป็นผู้รับเงิน

๒.๖ การจ่ายเงินกองทุนต้องมีหลักฐานการจ่ายเป็นใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญรับเงิน หรือหลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน หรือหลักฐานการรับเงินอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด เก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ

๓. การจัดทำบัญชีและรายงานกองทุน

๓.๑ การบันทึกบัญชี ให้บันทึกตามรูปแบบที่สำนักงานกำหนด

๓.๒ รอบระยะเวลาบัญชีให้ถือตามปีงบประมาณ กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เข้าร่วมดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน ระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีให้เริ่มระบบบัญชี ณ วันที่ได้รับเงินเป็นครั้งแรกจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๓.๓ จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศ หรือระบบอื่น และจัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนแล้ว ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ทุกไตรมาส โดยให้จัดส่งภายในสามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาส ตามรูปแบบที่สำนักงานกำหนด

ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุน ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนแล้ว เก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ

๓.๔ การจัดทำบัญชีและรายงานการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแหล่งทุนอื่น ให้เป็นตามที่กำหนดในข้อตกลงระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงาน และหน่วยงานเจ้าของแหล่งทุนนั้น

หมวด ๒
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ
กิจกรรม หรือแผนการดูแลรายบุคคล

---

๔. กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น

๔.๑ เมื่อได้รับเงินจากกองทุนให้นำไปใช้จ่ายตามที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน และการจัดทำบัญชี ให้เป็นไปตามระเบียบที่หน่วยงานนั้น ๆ ถือปฏิบัติ

๔.๒ เก็บหลักฐานการจ่ายเงินจากบัญชีไว้เพื่อการตรวจสอบ

๔.๓ เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงานตามที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้รายงานผลการดำเนินงาน และรายงานการจ่ายเงิน ตามที่สำนักงานกำหนด เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนทราบและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ

๔.๔ กรณีที่มีเงินเหลือจากการดำเนินงานให้นำเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินงานตามที่ได้รับอนุมัติ

๕. กรณีองค์กรหรือกลุ่มประชาชน

๕.๑ เมื่อได้รับเงินจากกองทุนให้นำไปใช้จ่ายตามที่ได้รับอนุมัติ

๕.๒ การจัดซื้อจัดจ้างให้ถือราคากลางตามระเบียบของทางราชการ หรือราคาตลาดโดยทั่วไป ในขณะที่จัดซื้อจัดจ้าง และให้แนบเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญรับเงิน ไว้กับรายงานการจ่ายเงินดังกล่าวด้วย

๕.๓ เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงานตามที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้รายงานผลการดำเนินงานและรายงานการจ่ายเงิน ตามที่สำนักงานกำหนด เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนทราบ และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ

๕.๔ กรณีที่มีเงินเหลือจากการดำเนินงานให้นำเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินงานตามที่ได้รับอนุมัติ

๖. กรณีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแหล่งทุนอื่น ให้เป็นตามที่กำหนดในข้อตกลงระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงาน และหน่วยงานเจ้าของแหล่งทุนนั้น

หมวด ๓

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
ในการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน

---

๗. ค่าตอบแทนสำหรับผู้เข้าประชุมตามข้อ ๒๓ ให้จ่ายในอัตรา ดังต่อไปนี้

๗.๑ ค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการกองทุน ไม่เกินครั้งละ ๕๐๐ บาทต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

๗.๒ ค่าตอบแทนในการประชุมคณะอนุกรรมการ ไม่เกินครั้งละ ๔๐๐ บาทต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกิน ๘๐๐ บาท

๗.๓ ค่าตอบแทนในการประชุมคณะทำงาน ไม่เกินครั้งละ ๓๐๐ บาทต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกิน ๖๐๐ บาท

๘. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้เข้าประชุมตามข้อ ๒๓ ให้จ่ายในอัตราเทียบเคียงตามระเบียบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

๙. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการประชุม ให้จ่ายในอัตราเทียบเคียงตามระเบียบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดและหลักการ
ของระบบหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด

สารบัญ

บทที่ ๑ แนวคิดและหลักการของระบบหลักประกันสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด

แนวคิดและหลักการ การปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด

บทที่ ๒ บทบาท และหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

- การสมัครเข้าร่วมดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพฯ
- การตั้งงบประมาณและสมทบเข้ากองทุนฯ
- การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน

บทที่ ๓ บทบาท และหน้าที่ของกรรมการ อนุกรรมการฯ และคณะทำงาน

- องค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุน
- อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน
- การดำรงตำแหน่งและการพ้นตำแหน่งกรรมการกองทุน
- การประชุมคณะกรรมการกองทุน/ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย

บทที่ ๔ วิธีปฏิบัติในการสนับสนุนแผนงาน โครงการ กิจกรรม

หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินกองทุนฯ

ประเภทที่ ๑ การสนับสนุนและส่งเสริมค่าบริการสาธารณสุขในชุมชน

๑.๑ การสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

๑.๒ การสนับสนุนการป้องกันโรค

๑.๓ การสนับสนุนการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก

๑.๔ การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

- การสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
- การสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดหา การซ่อมแซม ดัดแปลง เปลี่ยนชิ้นส่วน หรือการจัดทำเป็นกรณีเฉพาะของอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการตามความจำเป็น
- การสนับสนุนเพื่อเป็นการจัดตั้งและการจัดบริการให้ยืม-คืนกายอุปกรณ์และอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ
- การสนับสนุนเพื่อเป็นการดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมหรือบริการขั้นพื้นฐานเพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ประเภทที่ ๒ การสนับสนุนและส่งเสริมด้านพัฒนาศักยภาพ การมีส่วนร่วม และงานวิชาการ

- การสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการด้านพัฒนาศักยภาพ การมีส่วนร่วม และงานวิชาการ

ประเภทที่ ๓ การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเตรียมความพร้อมและรับมือโรคติดต่อ ภัย ธรรมชาติ และภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและสังคม

- การสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเตรียมความพร้อมและรับมือโรคติดต่อ ภัยธรรมชาติ และภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและสังคม

ประเภทที่ ๔ การสนับสนุนการบริหารจัดการหรือพัฒนากองทุนฯ

- การสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุน

บทที่ ๕ วิธีปฏิบัติในการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน และการรายงานทางการเงิน

- วิธีการรับเงิน และการเก็บรักษาเงิน
- วิธีการการจ่ายเงิน
- ข้อแนะนำสำหรับเป็นแนวทางประกอบการดำเนินงาน
- วิธีปฏิบัติในการบันทึกบัญชีและการรายงานผ่านโปรแกรมฯ http://prf.go.th
- รอบระยะเวลาบัญชี และการรายงาน
- ข้อแนะนำสำหรับวิธีการรายงานด้วยระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมฯ

บทที่ ๖ การติดตาม และประเมินการบริหารจัดการกองทุนฯ

- แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ภาคผนวก ๑ ประกาศ ระเบียบ ที่สำคัญ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๑
- ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๘

ภาคผนวก ๒ ข้อตกลง บันทึก ประกอบการดำเนินงาน

- ข้อตกลงการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด
- บันทึกความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพและสวัสดิการชุมชนในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ภาคผนวก ๓ หนังสือแสดงความจำนง ข้อตกลง แบบฟอร์ม ตัวอย่าง เอกสารในการดำเนินงาน

- หนังสือแสดงความจำนงเข้าร่วมดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ
- ข้อตกลงการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ
- ตัวอย่างแบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนฯ
- ใบสำคัญรับเงิน
- ใบเสร็จรับเงิน

บทที่ ๑

บทนำ

๑. แนวคิด และหลักการของระบบหลักประกันสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้วางรากฐานสำคัญในการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อให้ประชาชนไทยทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรา ๔๗ ที่กำหนดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ เพื่อลดช่องว่างและอุปสรรคในการเข้าถึงบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดให้มีกระบวนการรับฟังความเห็นประเด็นการขยายบทบาทกองทุนฟื้นฟูจังหวัด ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้บริหาร เพื่อพิจารณาปรับปรุงประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ทั้งนี้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอให้ปรับประกาศการใช้เงินกองทุนฟื้นฟูระดับจังหวัดโดยให้เปลี่ยนจาก ข้อ ๙ (๑)-(๓) เป็นหมวดการใช้เงิน เหมือนกองทุนตำบล ให้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ในอำเภอเดียวกัน หรือมีพื้นที่ติดกัน สามารถจัดทำข้อตกลงการใช้งบประมาณร่วมกัน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชน เพื่อให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้นำเสนอร่างประกาศปรับปรุงต่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘ และมีมติเห็นชอบในหลักการดังกล่าว จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) (๘) (๙) และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ ออกประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ คือการขยายขอบเขตจากการฟื้นฟูสมรรถภาพเพียงอย่างเดียว ไปสู่การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมใน ๔ มิติ ได้แก่ การสร้างเสริมสุขภาพ, การป้องกันโรค, การฟื้นฟูสมรรถภาพ, และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก อีกทั้งยังเปิดกว้างให้สามารถแก้ไขปัญหาที่มาจาก "ปัจจัยทางสังคมกำหนดสุขภาพ" (Determinants of Health) เช่น ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาวะของประชาชน

อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานของ สปสช. อาจยังมีช่องว่างหรือไม่ทั่วถึง รวมถึงอาจมีปัญหาอุปสรรคอื่น ๆ อีกมากในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ที่ทำให้ประชาชนเข้าไม่ถึงบริการ การประสานกำหนดให้ อบจ. เป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับจังหวัด จะช่วยปิดช่องว่างและเพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้น ประกาศคณะกรรมการหลักฯ จึงออกแบบให้ อบจ. ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ โดยมีทุนหรืองบประมาณที่เป็นการสมทบร่วมกันระหว่าง สปสช. กับ อบจ. ที่เรียกว่า “กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด” เป็นเครื่องมือให้ อบจ. เป็นผู้

ดำเนินงานและบริหารจัดการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชน เพื่อให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

เงินกองทุนฯ สามารถจ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ดังต่อไปนี้

(๑) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในชุมชนหรือที่บ้าน

(๒) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่น

(๓) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการให้ยืม-คืนอุปกรณ์ การซ่อม ดัดแปลง เปลี่ยนชิ้นส่วน หรือการจัดทำเป็นกรณีเฉพาะของอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ และการจัดสภาพแวดล้อม

(๔) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาด โรคติดต่อ หรือภัยธรรมชาติ หรือภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและสังคมที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจำเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้

(๔) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนาศักยภาพกองทุนฯ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ

(๕) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขอื่นตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมอบหมาย

การดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด โดยมีกองทุนฯ นั้น อบจ. มีบทบาทและหน้าที่ โดยสังเขปดังนี้

๑) การจัดทำและบริหารแผนการเงินกองทุนฯ ประจำปี
๒) สนับสนุนหรือประสานให้สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชนในจังหวัด จัดกิจกรรม หรือกระบวนการ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
๓) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
๔) การทำนิติกรรมและบริหารสัญญาหรือข้อตกลง
๕) การจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน
๖) การติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานกองทุนฯ
๗) งานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนและการพัฒนาศักยภาพกองทุนฯ

บทที่ ๒
บทบาท และหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๘ ยังคงยึดหลักความสมัครใจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการเข้าร่วมดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยต้องแสดงความประสงค์เข้าร่วมดำเนินงานฯ และมีความพร้อมในการอุดหนุนเงินหรืองบประมาณ และดำเนินการสมทบเงินเข้ากองทุนฯ ตามอัตราที่กำหนดตามนัย ๕ ข้อ ๗ แห่งประกาศฯ

บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยมีกองทุนฯ ที่สมทบร่วมกัน มีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้

๑. การสมัครเข้าร่วมดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด (ข้อ ๕)

๑) อบจ. มีความพร้อมในการสนับสนุนงบประมาณสมทบตามประกาศฯ สปสช. กำหนด และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑

๒) ยื่นหนังสือแสดงความจำนงเข้าร่วมดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด ต่อ สปสช.เขต

๓) สปสช. เขต พิจารณาแล้วแจ้งผลให้ อบจ. ทราบ

๔) อบจ. และ สปสช.เขต ทำข้อตกลงร่วมกัน

๕) อบจ. เปิดบัญชีกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัด.....”

๒. ข้อ ๖ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยให้มีกองทุนที่มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข รวมถึงการ 2. แก้ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากปัจจัยทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากพฤติกรรมส่วนบุคคล (Determinants of Health) เพื่อให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย 3. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้และมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ความจำเป็นในระดับพื้นที่ บริการอะไรบ้าง กลุ่มเป้าหมาย ขอบเขต วัตถุประสงค์ ความจำเป็นและแผนปฏิบัติการแบ่งหมวดประเภทบริการให้ชัดเจน (เน้นขอบเขตการจัดบริการของประชาชน บริการที่เป็นปัญหาของประชาชนในพื้นที่)

๓. การตั้งงบประมาณและสมทบเข้ากองทุนฯ (ข้อ ๗)

อบจ. ดำเนินการตั้งงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ อปท. เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด หรือหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด เพื่อสมทบงบประมาณเข้ากองทุนฯ โดยอัตราการสมทบเป็นไปตามข้อ ๗ แห่งประกาศฯ พ.ศ.๒๕๖๘ กล่าวคือ อบจ. สมทบเงินจำนวนที่เท่ากับหรือมากกว่าที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในแต่ละปีงบประมาณ

การจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่สนับสนุนให้ อบจ. เป็นไปตามอัตราต่อหัวประชากรที่คณะกรรมการหลักฯ จะประกาศกำหนดในแต่ละปี ปัจจุบัน สปสช.สนับสนุนในอัตรา 8 บาทต่อหัวประชากร (คำนวณจากจำนวนประชากร ณ 1 เมษายน ของทุกปี ตามวิธีของ สปสช.)

ข้อควรคำนึงเรื่องการสมทบงบประมาณของ สปสช.

๑) การตั้งงบประมาณสมทบให้ดำเนินการทุกปี ตามระเบียบ วิธีการตั้งงบประมาณที่ อบจ. ถือปฏิบัติ

๒) กรณีไม่อาจตั้งงบประมาณสมทบไว้ในปีนั้น หรือปีที่ค้างสมทบ ให้ดำเนินการสมทบงบประมาณเพิ่มเติมในปีถัดไป

๓) กรณี อบจ.ที่มีเงินกองทุนฯ คงเหลือมากกว่าหนึ่งเท่าของรายรับของกองทุน ตามข้อ ๒๔ แห่งประกาศฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักงานอาจงดการจัดสรรเงินจากกองทุน สปสช. และ อบจ. งดการสมทบเงินในปีงบประมาณนั้นได้ (อบจ.จะไม่ตั้งงบประมาณสมทบในปีที่ สปสช. งดการจัดสรรเงินนั้นได้ ตามเงื่อนไขข้อ ๒๔ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินกองทุนในการบริหารหรือพัฒนากองทุนตามข้อ ๑๑ (๔) ในปีงบประมาณนั้น ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินวงเงินของปีงบประมาณที่ผ่านมา

๔. ที่มาของรายรับและการสมทบเงินงบประมาณ

๑) เงินที่ได้รับจัดสรรจาก สปสช. เป็นเงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวตามจำนวนประชากรในพื้นที่ หรือตามหลักเกณฑ์อื่นที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด ตามข้อ ๗ (๑)

๒) เงินสมทบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตามข้อ ๗ (๒)

๓) เงินสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่นที่มีวัตถุประสงค์หรือภารกิจที่สอดคล้องกับกองทุน โดยความเห็นชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและสำนักงาน ตามข้อ ๗ (๓)

๔) รายได้อื่นๆ ได้แก่ เงินบริจาค จากภาคเอกชน หรือประชาชน ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร และรายได้จากการจัดกิจกรรมหารายได้เพื่อสมทบกองทุน (ถ้ามี) ตามข้อ ๗ (๔)

ข้อควรระวัง เงินกองทุนถือเป็น "เงินนอกงบประมาณ" ของ อบจ. ต้องแยกบัญชีบริหารจัดการ ไม่นำไปปะปนกับเงินงบประมาณปกติของ อบจ.

๕. กรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและบริหารจัดการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ข้อ ๘)

๑) สถานะของเงินกองทุน เงินที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), เงินสมทบจากงบประมาณของ อบจ., รวมไปถึงรายได้อื่นๆ (เช่น ดอกเบี้ย, เงินบริจาค) เมื่อนำเข้าบัญชีกองทุนแล้ว ให้ถือเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

๒) การรับ-จ่ายเงิน การเก็บรักษา และการบริหารพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการที่ใช้บังคับกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนกำหนดโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

๓) เงินกองทุนที่เหลือจ่ายในแต่ละปีงบประมาณ ให้สะสมไว้ในบัญชีกองทุนเพื่อใช้จ่ายในปีถัดไปได้โดย ไม่ต้องนำส่งคืนคลัง หรือส่งคืน สปสช. (ยกเว้นกรณีเลิกกองทุน) เนื่องจากเป็นกรรมสิทธิ์ของ อบจ. ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ

๔) กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เกิดจากการใช้จ่ายเงินกองทุน ให้แบ่งแยกกรรมสิทธิ์ตามประเภทของการใช้จ่าย ดังนี้

๑.ครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดบริหารจัดการ) ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อเพื่อใช้ในการบริหารจัดการกองทุน เช่น คอมพิวเตอร์ หรือวัสดุอุปกรณ์ ให้ตกเป็น กรรมสิทธิ์และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยต้องลงทะเบียนคุมทรัพย์สินตามระเบียบพัสดุของ อบจ.

๒.ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างในโครงการ (หมวดบริการสาธารณสุข)

๓.กรณีสนับสนุนให้หน่วยงานอื่น (เช่น รพ., รพ.สต.) ให้ระบุในข้อตกลง (MOU) ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษา

๔.กรณีสนับสนุนให้กลุ่มประชาชน/องค์กรชุมชน ให้ทรัพย์สินอยู่ในความดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม โดยมี อบจ. หรือหน่วยงานรัฐในพื้นที่กำกับดูแล

๕.อุปกรณ์ช่วยความพิการ (กายอุปกรณ์) ให้ถือเป็นสิทธิประโยชน์ส่วนบุคคลของผู้ป่วยหรือคนพิการที่ได้รับ หรือเป็นการยืมใช้ตามระเบียบที่กองทุนกำหนด

๖. การรับเงินจัดสรรกรณีมีเงินคงเหลือไม่เพียงพอ (ข้อ ๙)

๑) ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ได้รับเงินจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ตามข้อ ๗ (๑)) และได้สมทบเงินเข้ากองทุนครบถ้วนแล้ว แต่ปรากฏว่า **เงินในบัญชีกองทุนคงเหลือไม่เพียงพอ** ต่อการใช้จ่ายตามแผนงานโครงการ หรือมีภารกิจจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม อบจ. สามารถทำเรื่อง "ขอรับการจัดสรรเงินเพิ่มเติม" จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ หาก สปสช. มีงบประมาณเหลือจ่ายหรือมีนโยบายจัดสรรเพิ่ม ทั้งนี้ การขอรับเงินจัดสรรเพิ่มเติม จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ อบจ. **ต้องสมทบเงินเพิ่ม** ในสัดส่วนตามที่กำหนดในข้อ ๗ (๒) ด้วย

๒) การยื่นคำขอต่อ สปสช. ให้ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพิ่มเติม ไปยังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่ โดยแนบเอกสารประกอบ ดังนี้

๒.๑ รายงานสถานะการเงินปัจจุบัน (Statement และรายงานรับ-จ่าย)

๒.๒ แผนงาน/โครงการ ที่จะดำเนินการหากได้รับเงินเพิ่มเติม

๒.๓ หนังสือยืนยันการสมทบเงินของ อบจ. หรือสำเนารายงานการประชุมที่อนุมัติงบประมาณสมทบแล้ว

๗. บทบาทและหน้าที่ของ อบจ. ในการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ

๑. มอบหมายความรับผิดชอบ ผู้บริหารสูงสุดของ อบจ. พิจารณาออกคำสั่งมอบหมายหน่วยงานภายใน เพื่อรับผิดชอบการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ เช่น มอบสำนักปลัดอบจ. และหรือกองแผนและงบประมาณและหรือหน่วยงานอื่น เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการดำเนินงานและบริหารจัดการ ทั้งนี้อาจมีการมอบหมายเพิ่มเติม เช่น มอบสำนัก/กองคลังรับผิดชอบการเงินและบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด เป็นต้น และมอบหมายบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือเหมาะสม ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของ อบจ.ร่วมเป็นผู้ลงนามเบิกเงิน ดังนี้

๑.๑ ให้ปลัดอบจ. หรือเจ้าหน้าที่ของอบจ.ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ

๑.๒ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคลัง ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑.๓ ให้เจ้าหน้าที่ของ อบจ.ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑.๔ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของอบจ.จำนวน ๒ คน ร่วมเป็นผู้ลงนามเบิกเงินจากบัญชี "กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัด....."

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน อบจ. ดำเนินการประสานกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้กรรมการตามข้อ ๑๖ (๗) ถึง (๑๗) ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติตามบทที่ ๓ ข้อ ๓

๓. งานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนและการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ

การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ ของ อบจ. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการหรือกิจกรรมต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน อบจ. มีหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการกองทุน รวมถึงการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้

๓.๑ งานเลขานุการคณะกรรมการกองทุน อบจ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุน ดำเนินการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ ๔-๖ ครั้ง การจัดประชุมทุกครั้งควรทำหนังสือเชิญคณะกรรมการกองทุนเข้าร่วมประชุม กำหนดวาระการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม สาระการประชุมดังตัวอย่างตามตาราง

ครั้งที่	ประเด็นที่ควรนำเข้าเป็นวาระประชุม	ช่วงเวลา
๑	- สรุปผลการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา - เห็นชอบรายงานการเงินไตรมาส ๔ ของปีงบประมาณที่ผ่านมา - อนุมัติแผนการเงินประจำปีงบประมาณของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ	ตุลาคม-พฤศจิกายน
๒	- พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่าย และโครงการ/กิจกรรมตามแผนการเงินประจำปีงบประมาณ	ธันวาคม
๓	- เห็นชอบรายงานการเงินของไตรมาส ๑ - ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานที่ผ่านมา - อนุมัติค่าใช้จ่าย และโครงการ/กิจกรรมตามแผนการเงินประจำปีงบประมาณ - แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ	มกราคม
๔	- เห็นชอบรายงานการเงินของไตรมาส ๒ - ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานที่ผ่านมา - อนุมัติค่าใช้จ่าย และโครงการ/กิจกรรมตามแผนการเงินประจำปีงบประมาณ - ปรับแผนการเงินกลางปี	เมษายน
๕	- เห็นชอบรายงานการเงินของไตรมาส ๓ - ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานที่ผ่านมา - อนุมัติค่าใช้จ่าย และโครงการ/กิจกรรมตามแผนการเงินประจำปีงบประมาณ - ทบทวนแผนงานโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้วว่ามีการปฏิบัติหรือไม่	กรกฎาคม
๖	- ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานที่ผ่านมา - อนุมัติค่าใช้จ่าย และโครงการ/กิจกรรมตามแผนการเงินประจำปีงบประมาณ - เตรียมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและรายงานการเงินประจำปี - บางกองทุนฯ ที่มีความพร้อมอาจมีการอนุมัติแผนการเงินประจำปีของปีงบประมาณถัดไปในการประชุมคราวนี้ก็ได้	กันยายน

๓.๒ อบจ.เป็นเลขานุการมีหน้าที่สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการทำงานของคณะกรรมการกองทุนตามอำนาจหน้าที่ในข้อ ๒๑ แห่งประกาศฯ รวมถึงการทำงานของคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานที่คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้ง ดังนี้

๑) ศึกษานโยบาย/ทิศทางการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ/ประเด็นปัญหาการเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชนและระบบบริการ ในพื้นที่

๒) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์/สังเคราะห์ประเด็นงานและปัญหาสำคัญ แผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญ/ความเร่งด่วน

๓) จัดทำแผนการประชุมประจำปีเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการกองทุน ทั้งนี้ควรประชุมอย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง ยกเว้นกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพใหม่ที่เข้าร่วมดำเนินการในปีแรก

๔) สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการกองทุน เช่น การประชุมอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน ฯลฯ

๕) อำนวยความสะดวกในการประชุมและเป็นเลขานุการของการประชุม ซึ่งดำเนินการตั้งแต่การเชิญประชุม กำหนดวาระการประชุม จัดทำเอกสารการประชุม สรุปประเด็น/มติ จัดทำรายงานการประชุม ตลอดจนการจัดอาหารว่างและจ่ายค่าเบี้ยประชุม สำหรับวาระหรือประเด็นในการจัดประชุมแต่ละครั้งของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ

๔. จัดทำแผนการเงินและบริหารจัดการประจำปีของกองทุน เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนองตอบวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด อบจ.ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกองทุน ต้องจัดทำ (ร่าง) แผนการเงินประจำปีหรือแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพประจำปี โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑๑ และที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชน และอปท.ในพื้นที่ (การจัดทำแผนการเงินนี้อาจพิจารณาถึงความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนการดำเนินงานของ อบจ.ด้วยก็ได้) เพื่อเสนอคณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติตั้งแต่ก่อนหรือเริ่มต้นปีงบประมาณ อย่างช้าไม่เกินเดือนธันวาคม หลังจากนั้นประกาศหรือแจ้งให้หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องและประชาชนทราบ หลังจากดำเนินงานไปแล้วหากจำเป็นต้องแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนการเงินประจำปี ให้ อบจ.เสนอคณะกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ

๕. ประสานขอความร่วมมือ การสนับสนุนจากสถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชน และอปท.ในพื้นที่ ให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินงานตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ที่บรรจุในแผนการเงินประจำปี เพื่อนำแผนการเงินประจำปีไปสู่การปฏิบัติ อบจ.อาจต้องประสาน ขอความร่วมมือ และการสนับสนุนจากสถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข องค์กรหรือกลุ่มประชาชน อปท.ในพื้นที่ หรือหน่วยงานที่มีศักยภาพในพื้นที่ เพื่อเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินงานตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ที่บรรจุอยู่ในแผนการเงินประจำปีที่ได้รับอนุมัติแล้ว ซึ่งบางแผนงานหรือโครงการอาจต้องมีการเสนอแผนงานโครงการ เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนเป็นผู้อนุมัติอีกครั้งหนึ่ง

๖. จัดทำนิติกรรม บริหารสัญญาหรือข้อตกลง และสนับสนุนค่าใช้จ่าย เมื่อคณะกรรมการกองทุนเห็นชอบอนุมัติให้การสนับสนุนตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชน และ อปท. ในพื้นที่ ได้เสนอมา ต้องมีการจัดการด้านธุรกรรมตั้งแต่การอนุมัติเบิกจ่าย จัดทำนิติกรรม และบริหารสัญญาหรือข้อตกลงให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง

๗. บริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหรือพัฒนากองทุน ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมาผู้รับจ้างมาทำงานด้านธุรการ จ้างเหมาเพื่อประเมินผลผลิตผลลัพธ์ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด เป็นต้น ตามแผนการเงินประจำปีหรือแผนงาน/โครงการ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ทั้งนี้ครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้ขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สินของ อบจ.

๘. จัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ โดย

๑) จัดทำบัญชีตามรูปแบบที่สำนักงานกำหนด หรือบันทึกในระบบโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด

๒) จัดทำรายงานทางการเงินเสนอคณะกรรมการกองทุนให้ความเห็นชอบ ทุกไตรมาส

๓) ทุกสิ้นปีจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการกองทุนให้ความเห็นชอบ

๔) จัดเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อการตรวจสอบ

๙. ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จัดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ที่หน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงาน กลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ องค์กรอื่น และ อปท. ในพื้นที่ ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ตลอดจนอาจให้หน่วยงานเหล่านั้นนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการกองทุน

บทที่ ๓

บทบาท และหน้าที่ของกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงาน

๑. องค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุน

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นที่ปรึกษา
วิธีดำเนินการสรรหา.....

(๒) ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต เป็นที่ปรึกษา
(ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต .....)

(๓) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานกรรมการ
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่ง

(๔) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นกรรมการ
วิธีดำเนินการสรรหา.....

(๕) ท้องถิ่นจังหวัด เป็นกรรมการ
วิธีดำเนินการสรรหา.....

(๖) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นกรรมการ
วิธีดำเนินการสรรหา.....

(๗) ผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัดที่กรรมการกองทุนคัดเลือก จำนวน ๒ คน เป็นกรรมการ
(เมื่อได้กรรมการตามข้อ ๑๖ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗) ให้ประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น จำนวน ๒ คน เป็นกรรมการโดยกรรมการคัดเลือก)

(๘) ผู้แทนสถาบันการศึกษาในจังหวัดที่กรรมการกองทุนคัดเลือก จำนวน ๑ คน เป็นกรรมการ
วิธีดำเนินการสรรหา.....

(๙) ผู้แทนองค์กรหรือกลุ่มประชาชนในจังหวัด ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต คัดเลือกโดยกระบวนการมีส่วนร่วม จำนวน ๓ คน เป็นกรรมการ
วิธีดำเนินการสรรหา.....

(๑๐) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไป คัดเลือกโดยกระบวนการมีส่วนร่วม จำนวน ๓ คน เป็นกรรมการ วิธีดำเนินการสรรหา.....

(๑๑) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มอบหมาย จำนวน ๑ คน เป็นกรรมการ วิธีดำเนินการสรรหา.....

(๑๒) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมอบหมาย จำนวน 2 คน เป็นกรรมการ
วิธีดำเนินการสรรหา.....

(๑๓) นักกายภาพบำบัดในหน่วยบริการ ที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมอบหมาย จำนวน ๑ คน เป็นกรรมการ วิธีดำเนินการสรรหา.....

(๑๔) นายกเทศมนตรีที่เป็นผู้แทนระดับจังหวัดของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวน ๑ คน เป็นกรรมการ

วิธีดำเนินการสรรหา.....

(๑๕) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นผู้แทนระดับจังหวัด ของสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย จำนวน ๑ คน เป็นกรรมการ

วิธีดำเนินการสรรหา.....

(๑๖) ผู้แทนศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองในจังหวัด จำนวน ๑ คน เป็นกรรมการ

วิธีดำเนินการสรรหา.....

(๑๗) ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขระดับจังหวัด เป็นกรรมการ

วิธีดำเนินการสรรหา.....

(๑๘)เจ้าหน้าที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต เป็นกรรมการ ที่ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตมอบหมาย

(๑๙) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ

วิธีดำเนินการสรรหา.....

(๒๐) หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคลัง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มอบหมาย

(๒๑) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขหรือหัวหน้าส่วนราชการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ที่รับผิดชอบงานกองทุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มอบหมาย

(๒๒) เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มอบหมาย วิธีดำเนินการสรรหา.....

ข้อแนะนำสำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน

๑) กรรมการที่เป็นโดยตำแหน่งควรระบุตำแหน่ง ส่วนกรรมการที่เป็นบุคคลควรระบุชื่อนามสกุล

๒) ที่ปรึกษาไม่ได้อยู่ในองค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุนตามข้อ ๑๖ (๗) ถึง (๑๗) แต่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการกองทุน ซึ่งเป็นโดยตำแหน่งสามารถมอบผู้แทนได้ตามสายบังคับบัญชาของหน่วยงาน

๓) การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นควรพิจารณาจากความรู้ ความเชี่ยวชาญงานด้านสาธารณสุข หรือมีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ได้

๔) การมอบหมายผู้แทนของศูนย์ประสานงานฯ หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ ที่อยู่ในท้องถิ่นเป็นกรรมการตามข้อ ๑๖ (๑๖) ขอให้ อบจ. ประสานงานกับ สปสช.เขต ในการส่งรายชื่อผู้แทนดังกล่าวมาเป็น

กรรมการ ซึ่งควรเป็นบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมต่อที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนได้เป็นอย่างดี

๕) อบจ.จัดทำคำสั่งเพื่อประกาศแจ้งตำแหน่งและรายชื่อกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เมื่อได้กรรมการครบองค์ประกอบตาม (๑) ถึง (๒๒) แล้ว ทั้งนี้วิธีการจัดทำคำสั่งให้เป็นไปตามระเบียบ วิธีการปฏิบัติของ อบจ. และควรส่งสำเนาคำสั่งหรือประกาศให้ สปสช.เขต ทราบ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานหากมีการตรวจสอบ

๒. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ (ตามข้อ ๒๑ แห่งประกาศฯ พ.ศ. ๒๕๖๘) มีดังนี้

๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการกองทุนประจำปีที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กองทุนแล้วเสนอต่อสำนักงานเพื่อทราบ

๒) พิจารณาอนุมัติแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม รวมทั้งแผนการดูแลรายบุคคลสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม รวมทั้งแผนการดูแลรายบุคคลสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้เทียบเคียงตามระเบียบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด

๓) ออกระเบียบที่จำเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้

๔) สนับสนุนให้บุคคลในท้องถิ่นหรือพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชน หรือหน่วยบริการ ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

๕) ให้คำแนะนำในการจัดทำข้อมูลและการดำเนินงานที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุขของกลุ่มเป้าหมายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชน

๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุน

๓. การดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการกองทุนตามข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งประกาศฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑) กรรมการในสัดส่วนตามข้อ (๗) ผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัด (๘) ผู้แทนสถาบันการศึกษาในจังหวัด (๙) ผู้แทนองค์กรหรือกลุ่มประชาชนในจังหวัด (๑๐) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไป (๑๑) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน (๑๒) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (๑๓) นักกายภาพบำบัดในหน่วยบริการ (๑๔) นายกเทศมนตรีที่เป็นผู้แทนระดับจังหวัดของสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย (๑๕) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นผู้แทนระดับจังหวัดของสมาคมองค์การบริหารส่วน

ตำบลแห่งประเทศไทย (๑๖) ผู้แทนของศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองในจังหวัด (๑๗) ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขระดับจังหวัด มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๔ ปี นับแต่วันที่ออกคำสั่งแต่งตั้ง

๒) เมื่อกรรมการตามข้อ (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) และ (๑๗) ครบกำหนดวาระ ๔ ปีแล้ว หากยังไม่ได้มีการคัดเลือกกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการคัดเลือกขึ้นใหม่เข้ามารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกิน ๙๐ วัน นับแต่วันที่กรรมการพ้นจากตำแหน่ง

๓) กรณีกรรมการตามข้อ (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) และ (๑๗) พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้มีการคัดเลือกกรรมการแทนภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่กรรมการพ้นจากตำแหน่ง และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

๔) กรณีวาระของกรรมการตามข้อ (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) และ (๑๗) ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่ไม่ถึง ๙๐ วัน จะไม่ดำเนินการคัดเลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างนั้นก็ได้

๕) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ซึ่งยังมิได้มีการคัดเลือกกรรมการขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่

๖) กรณีกรรมการตามข้อ (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) และ (๑๗) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ๔ ปี แล้ว ให้พ้นจากตำแหน่ง ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย

(๕) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๖) ขาดประชุมสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร

๔. การประชุมคณะกรรมการกองทุนตามข้อ ๒๐ แห่งประกาศฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑) การประชุมคณะกรรมการกองทุน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

๒) กรณีประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

๓) กรรมการที่แต่งตั้งโดยตำแหน่งและไม่ระบุชื่อ สามารถมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้

๔) การลงมติ ออกเสียงได้เฉพาะผู้ที่มีตำแหน่งเป็นกรรมการ

๕) การประชุมทุกครั้งต้องมีการจัดทำบันทึกรายงานการประชุม เพื่อใช้สำหรับการอ้างอิงและการตรวจสอบ

นอกจากนั้นคณะกรรมการกองทุนมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศนี้ หรือตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย และให้นำข้อ ๒๐ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน โดยอนุโลม

ข้อเสนอแนะสำหรับเป็นแนวทางการประชุมคณะกรรมการกองทุน

๑. กรณี อบจ. ที่เข้าร่วมดำเนินงานกองทุนฯ ในปีแรก (กองทุนฯ ใหม่) ควรจัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑ เพื่อชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแนวทางการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน การออกระเบียบที่จำเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้

ครั้งที่ ๒ เพื่อพิจารณาปัญหาสุขภาพในพื้นที่ โดยใช้ข้อมูลจากหน่วยบริการ อปท. เวทีประชาชน และการระดมความเห็นจากคณะกรรมการฯ เพื่อจัดทำแผนการเงินประจำปีของกองทุนฯ หรือแผนสุขภาพของ อบจ. ตามประกาศหรือระเบียบที่คณะกรรมการเห็นชอบ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมควรมีการเผยแพร่ประกาศหรือระเบียบของกองทุนฯ หรือหลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณโครงการ และแผนสุขภาพของ อบจ. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้หน่วยบริการ และภาคีเครือข่ายในชุมชนทราบ ในการรับรู้การมีงบประมาณของกองทุนฯ เพื่อจัดทำโครงการ หรือกิจกรรมมาขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ต่อไป

ครั้งที่ ๓ เพื่อพิจารณารายละเอียดของแต่ละโครงการหรือกิจกรรมตามข้อ ๑๑ (๑) ถึง (๔) (โดยกิจกรรมตาม (๔) ให้ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาของพื้นที่ และอนุมัติการใช้งบประมาณที่สอดคล้องปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ รูปแบบการนำเสนอโครงการอาจให้ผู้เสนอโครงการมาเสนอโครงการต่อคณะกรรมการด้วยตนเองหรือเสนอโครงการต่อคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมายก็ได้ แต่ทุกโครงการ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกองทุน

การประชุมครั้งถัดไป เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ระหว่างปี รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่กองทุนฯ ให้การสนับสนุนไปแล้ว รายงานสถานะการเงินทุกไตรมาส ทบทวนปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ ติดตามการบันทึกรายงานผ่านระบบออนไลน์ https://pfr.nhso.go.th ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

๒. กองทุนฯ ที่ดำเนินการต่อเนื่อง (กองทุน-เดิม) ควรมีการประชุมอย่างน้อยทุก ๑-๓ เดือน ดังนี้

๒.๑ ในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม (ไตรมาสแรก) ควรมีการประชุมเพื่อ

- สรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา
- จัดแผนการเงินประจำปี แผนสุขภาพของกองทุนฯ กำหนดกรอบโครงการ หรือกิจกรรมของปีงบประมาณใหม่
- อนุมัติแผนการเงินประจำปี ประกาศใช้แผนฯ

๒.๒ ในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม (ไตรมาสที่ ๒) ควรมีการประชุมเพื่อ

- พิจารณารายละเอียดของแต่ละโครงการหรือกิจกรรมตามข้อ ๑๑ (๑) ถึง (๕) สำหรับรูปแบบการนำเสนอโครงการ อาจให้ผู้รับผิดชอบโครงการนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการด้วยตนเองหรือนำเสนอโครงการต่อคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานที่คณะกรรมการกองทุนฯ มอบหมาย

- อนุมัติการใช้งบประมาณอาจสอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน หรือแผนสุขภาพของกองทุนฯ หรือปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ แต่ทุกโครงการต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกองทุน

๒.๓ ในช่วงเดือนเมษายน - กันยายน (ไตรมาสที่ ๓ - ๔) ควรมีการประชุมเพื่อ

- พิจารณาโครงการ หรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ระหว่างปี

- กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ หรือกิจกรรม ของหน่วยงาน/องค์กร ที่กองทุนฯ ให้การสนับสนุน

- ติดตามการบันทึกรายงานผ่านโปรแกรมระบบออนไลน์ https://pfr.nhso.go.th ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

๓. ข้อเสนอแนะสำหรับการประชุม และการรายงาน

๓.๑ คณะกรรมการกองทุนต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อรายงานสถานะการเงินทุกไตรมาส

๓.๒ กรรมการและเลขานุการต้องจัดทำระเบียบวาระการประชุม และบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง

๓.๓ การประชุมในแต่ละครั้งองค์ประชุมต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

๓.๔ การจัดทำบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุน ควรทำเป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับใช้ในการอ้างอิงและการตรวจสอบ โดยให้ประธานกรรมการและเลขานุการเป็นผู้ลงนามรับรองรายงานการประชุมทุกครั้ง

๕. ค่าตอบแทนการประชุม ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒๓ แห่งประกาศฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑) กรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ และคณะทำงาน ได้รับค่าตอบแทนในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น โดยอัตราค่าตอบแทนเป็นไปตามข้อกำหนดในหมวด ๓ ข้อ ๗ และ ๘ เอกสารแนบท้ายประกาศ ฯ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒) บุคคลภายนอกที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมจะได้รับค่าตอบแทนในการประชุมเท่ากับกรรมการ

๓) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจำหรือพนักงานจ้างเหมาบริการ ของอบจ. ที่รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและบริหารจัดการฯ ที่เข้าร่วมประชุม มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการประชุม ให้เบิกจ่ายในอัตราเท่ากับกรรมการโดยเป็นไปตามข้อกำหนดในหมวด ๓ ข้อ ๗

ประเภท	ค่าตอบแทน
๑. กรรมการ หรือ ที่ปรึกษา	ไม่เกินครั้งละ ๕๐๐ บาทต่อคน แต่เดือนหนึ่งต้องไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
๒. อนุกรรมการ	ไม่เกินครั้งละ ๔๐๐ บาทต่อคน แต่เดือนหนึ่งต้องไม่เกิน ๘๐๐ บาท
๓. คณะทำงาน	ไม่เกินครั้งละ ๓๐๐ บาทต่อคน แต่เดือนหนึ่งต้องไม่เกิน ๖๐๐ บาท
๔. บุคคลภายนอกที่รับเชิญเข้าร่วมประชุม	เท่ากับกรรมการ หรืออนุกรรมการ หรือคณะทำงาน ที่เชิญเข้าร่วมประชุม แล้วแต่กรณี
๕. เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจำหรือพนักงานจ้างเหมาบริการ อบจ. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองทุนฯ	เท่ากับกรรมการ หรืออนุกรรมการ หรือคณะทำงาน ตามที่ได้รับมอบหมายให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ แล้วแต่กรณี

๒) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมตามข้อ ๒๓ ให้จ่ายในอัตราเทียบเคียงตามระเบียบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในอัตราไม่เกินระเบียบของ อบจ. โดยอนุโลม ทั้งนี้โดยการอนุมัติของประธานกรรมการ

๓) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการประชุม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เป็นต้น ให้จ่ายในอัตราเทียบเคียงตามระเบียบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในอัตราไม่เกินระเบียบของ อบจ. โดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยการอนุมัติของประธานกรรมการ

บทที่ ๔
แนวทางปฏิบัติการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด

เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม รวมทั้งแผนการดูแลรายบุคคล สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชนในจังหวัด เพื่อส่งเสริมประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่เข้าถึงการบริการสาธารณสุขและการแก้ปัญหาสุขภาพด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นได้มากขึ้น การขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระดับจังหวัดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ จำเป็นต้องมีการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติผ่าน "แผนงานและโครงการ" ที่มีประสิทธิภาพ บทนี้จะกล่าวถึงกรอบกิจกรรมที่กองทุนสามารถสนับสนุนได้ เพื่อให้หน่วยงานและภาคีเครือข่ายใช้เป็นแนวทางในการเขียนโครงการขอรับงบประมาณ โดยกรอบประเภทกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนในการใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประกาศฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงกำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เป็น ๔ ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ ๑ การสนับสนุนและส่งเสริมค่าบริการสาธารณสุขในชุมชน

๑.๑ การสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

๑.๒ การสนับสนุนการป้องกันโรค

๑.๓ การสนับสนุนการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก

๑.๔ การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

- การสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
- การสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดหา การซ่อมแซม ดัดแปลง เปลี่ยนชิ้นส่วน หรือการจัดทำเป็นกรณีเฉพาะของอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการตามความจำเป็น
- การสนับสนุนเพื่อเป็นการจัดตั้งและการจัดบริการให้ยืม-คืนกายอุปกรณ์และอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ
- การสนับสนุนเพื่อเป็นการดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมหรือบริการขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ประเภทที่ ๒ การสนับสนุนและส่งเสริมด้านพัฒนาศักยภาพ การมีส่วนร่วม และงานวิชาการ

- การสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการด้านพัฒนาศักยภาพ การมีส่วนร่วม และงานวิชาการ

ประเภทที่ ๓ การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเตรียมความพร้อมและรับมือโรคติดต่อ ภัยธรรมชาติ และภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและสังคม

- การสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเตรียมความพร้อมและรับมือโรคติดต่อ ภัยธรรมชาติ และภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและสังคม

ประเภทที่ ๔ การสนับสนุนการบริหารจัดการหรือพัฒนากองทุนฯ

- การสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุน

ประเภทที่ ๑ การสนับสนุนและส่งเสริมค่าบริการสาธารณสุขในชุมชน

๑.๑ การสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

๑.๒ การสนับสนุนการป้องกันโรค

๑.๓ การสนับสนุนการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก

๑.๔ การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ แนวทางและวิธีปฏิบัติ ดังนี้

๑. นิยาม

๑) **กองทุนฯ** หมายถึง กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด ซึ่งบริหารจัดการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

๒) **ผู้มีสิทธิได้รับบริการ** คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

๓) **หน่วยงานที่มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่าย** คือ หน่วยบริการในพื้นที่ หรือหน่วยบริการของ อบจ. (หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยหน่วยบริการต้องมีศักยภาพในการจัดบริการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด กรณีการให้บริการภายภาพบำบัด หรือกิจกรรมบำบัด หน่วยบริการที่มีศักยภาพต้องออกไปให้บริการในชุมชนเท่านั้น

๔) **แผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)** แผนการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จัดทำขึ้นเฉพาะบุคคล โดยผ่านการประเมินจากทีมสหวิชาชีพหรือผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาว (Care Manager)

๒. วัตถุประสงค์

๑) เพื่อสนับสนุนให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการได้อย่างทั่วถึง

๒) เพื่อส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลสุขภาพคนในชุมชน

๓) เพื่อพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพให้มีมาตรฐานและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบภายในจังหวัด

๓. ระยะเวลาดำเนินการ

๑) การยื่นเสนอโครงการ สามารถยื่นได้ตลอดปีงบประมาณ หรือตามรอบที่คณะกรรมการกองทุนฯ กำหนด (เช่น รอบที่ ๑ ต.ค.-ธ.ค., รอบที่ ๒ ม.ค.-มี.ค.)

๒) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (สิ้นสุด ๓๐ กันยายน) เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเป็นกรณีพิเศษ

๔. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑) หน่วยงานผู้สนับสนุนงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด

๒) หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

๒.๑ หน่วยบริการสาธารณสุข (รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป/รพ.ชุมชน/รพ.สต.)

๒.๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)

๒.๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/อบต.) ในพื้นที่

๒.๔ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป / ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ได้รับการรับรองตามระเบียบ

๕. หลักเกณฑ์การพิจารณา โครงการหรือแผนงานที่จะได้รับการอนุมัติ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

๑) ความสอดคล้อง ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ และสถานการณ์ปัญหาสุขภาพในพื้นที่

๒) ความคุ้มค่า มีรายละเอียดงบประมาณที่เหมาะสม เป็นจริง และประหยัด

๓) การมีส่วนร่วมแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือภาคีเครือข่าย

๔) กลุ่มเป้าหมายชัดเจนระบุจำนวนและรายชื่อผู้ได้รับประโยชน์ (กรณี Care Plan) หรือกลุ่มเป้าหมายของโครงการอย่างชัดเจน

ทั้งนี้ในแต่ละปีงบประมาณ อบจ. อาจจัดทำบันทึกข้อตกลงหรือสัญญา กับหน่วยบริการที่จัดจัดบริการพร้อมแผนการให้บริการ โดยเฉพาะการออกบริการเชิงรุกในชุมชน เพื่อทราบความต้องการให้บริการของหน่วยบริการ ร่วมทั้งสามารถประมาณการ และควบคุมค่าใช้จ่ายได้ เพื่อเป็นหลักฐานด้วยก็ได้

๖. ขอบเขตการสนับสนุน แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ ได้แก่

๑) การสนับสนุนรายโครงการ/กิจกรรม

๑.๑ บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด จิตบำบัด ในชุมชน

๑.๒ การจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ตามรายการที่ สปสช. หรือกองทุนฯ กำหนด

๗. การโอนงบประมาณ

๑) กรณีหน่วยงานรัฐ/อปท. เมื่อโครงการได้รับอนุมัติ กองทุนฯ จะโอนเงินงบประมาณเข้าบัญชีเงินบำรุงของหน่วยบริการ หรือบัญชีงบประมาณของ อปท. นั้นๆ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒) กรณีองค์กรภาคประชาชน โอนเข้าบัญชีธนาคารที่เปิดขึ้นเพื่อดำเนินโครงการโดยเฉพาะ

๘. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ลำดับ	ขั้นตอนหลัก	วิธีการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน
๑	การค้นหาและคัดกรอง	๑.๑ สำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย (คนพิการ/ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน/ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง) ในพื้นที่	รพ.สต. / หน่วยบริการ/ อปท. (กองสาธารณสุข)	แบบประเมิน ADL (Barthel Index)
		๑.๒ ประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน (ADL) เพื่อจัดกลุ่มความรุนแรง	รพ.สต. / หน่วยบริการ/ อปท. (กองสาธารณสุข)	ฐานข้อมูล Health Data
		๑.๓ วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพและความต้องการอุปกรณ์/การปรับบ้าน	Care Manager (CM)/ทีมสหวิชาชีพ	
๒	การจัดทำแผน/โครงการ	กรณีโครงการภาพรวม	ผู้เสนอโครงการ (รพ./ รพ.สต./อปท./องค์กรอื่นหรือกลุ่มประชาชน)	แบบเสนอโครงการ
		๒.๑ ประชุมทีมงานเพื่อยกร่างโครงการ กำหนดวัตถุประสงค์ และงบประมาณ		แผน Care Plan
		๒.๒ เขียนโครงการตามแบบฟอร์ม		รายการประมาณการค่าใช้จ่าย
		๒.๓ ทีมสหวิชาชีพ/CM จัดทำ Care Plan รายคน ระบุชุดบริการ (Service Package) จำนวนครั้ง และอุปกรณ์ที่จำเป็น		
๓	การยื่นเสนอขอรับงบฯ	๓.๑ รวบรวมเอกสารโครงการและแผนงานเสนอต่อ "สำนักงานเลขานุการกองทุนฯ" (ณ อบจ.)	กองทุนฯ อบจ.	หนังสือนำส่ง
		๓.๒ เจ้าหน้าที่กองทุนฯ ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารเบื้องต้น	สนง.เลขานุการกองทุนฯ	เอกสารโครงการฉบับสมบูรณ์
๔	การพิจารณากลั่นกรอง	๔.๑ คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานประชุมพิจารณารายละเอียด	คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ	บันทึกรายงานการประชุม
		๔.๒ ตรวจสอบความสอดคล้องกับระเบียบ ความคุ้มค่า และซ้ำซ้อนกับงบอื่นหรือไม่	คณะอนุกรรมการกองทุนฯ/ คณะทำงานกองทุนฯ	แบบประเมินโครงการ
		๔.๓ ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับแก้ (ถ้ามี) ก่อนนำเข้าบอร์ดใหญ่		
๕	การอนุมัติ	๕.๑ นำโครงการที่ผ่านการกลั่นกรองเข้าที่ประชุม "คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ"	คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ	มติที่ประชุม

ลำดับ	ขั้นตอนหลัก	วิธีการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน
		๕.๒ คณะกรรมการฯ มีมติ อนุมัติ/ไม่อนุมัติ/ชะลอโครงการ		ประกาศผลการพิจารณา
๖	การทำสัญญาและโอนเงิน	๖.๑ แจ้งผลการอนุมัติให้หน่วยงานทราบ	กองทุนฯ อบจ.	บันทึกข้อตกลง (MOU)
		๖.๒ จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างกองทุนฯ (อบจ.) กับผู้รับทุน	กองทุนฯ อบจ.	หลักฐานการโอนเงิน
		๖.๓ โอนเงินงบประมาณเข้าบัญชีหน่วยงาน/กลุ่มองค์กร		
๗	การดำเนินงานตามแผน	๗.๑ ด้านบริการ (Service) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน, กายภาพบำบัด, กิจกรรมบำบัด ตาม Care Plan	หน่วยบริการ / รพ.สต.	บันทึกการให้บริการ (Service Record)
		๗.๒ ด้านอุปกรณ์ จัดซื้อ/จัดหา และส่งมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ	อปท./หน่วยบริการ / รพ.สต./ศูนย์บริการคนพิการ	รูปถ่ายกิจกรรม/รูปถ่ายก่อน-หลังปรับบ้าน
		๗.๓ ด้านปรับบ้านดำเนินการจ้างเหมา/ซื้อวัสดุ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม	กองทุน อบจ./ อบต./ เทศบาล	ทะเบียนคุมครุภัณฑ์
		๗.๔ ด้านส่งเสริม จัดอบรม, กิจกรรมกลุ่ม, โรงเรียนผู้สูงอายุ	หน่วยบริการ / รพ.สต./ อบจ./อบต. /เทศบาล/ ชมรม/องค์กรอื่น	
๘	การติดตามและรายงานผล	๘.๑ หน่วยงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน	ผู้เสนอโครงการ (รพ./ รพ.สต./อปท./องค์กรอื่น หรือกลุ่มประชาชน)	รายงานผลการดำเนินงาน (Output/Outcome)
		๘.๒ ส่งคืนเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) เข้ากองทุนฯ		รายงานรับ-จ่ายเงิน
		๘.๓ รายงานปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ		ใบเสร็จรับเงิน/หลักฐานการจ่าย
๙	การประเมินผลลัพธ์	๙.๑ กองทุนฯ สุ่มตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานบริการ	คณะทำงานติดตามประเมินผล	แบบติดตามประเมินผล

๙. การกำกับติดตามและประเมินผล

๑) รายงานความก้าวหน้า ทุก ๖ เดือน หรือตามงวดงานที่กำหนด

๒) รายงานฉบับสมบูรณ์ ส่งภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดโครงการ ประกอบด้วย

- รายงานผลการดำเนินงาน (Output/Outcome)
- รายงานรับ-จ่ายเงิน (พร้อมหลักฐานสำเนาใบเสร็จรับเงิน)

๓) การติดตามลงพื้นที่ คณะทำงานติดตามประเมินผลของ อบจ. จะสุ่มลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบคุณภาพบริการและความพึงพอใจของประชาชน

การสนับสนุนและการจัดหา การซ่อมแซม ดัดแปลง เปลี่ยนชิ้นส่วน หรือการจัดทำเป็นกรณีเฉพาะของอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการตามความจำเป็น มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. นิยาม

๑) **การจัดหา** การจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการชิ้นใหม่ ตามรายการมาตรฐาน กรณีมีความจำเป็นต้องกำหนดรายการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์แก่ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำข้อเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนพิจารณาเห็นชอบได้

๒) **การซ่อมแซม/เปลี่ยนชิ้นส่วน** การเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือแก้ไขอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม

๓) **การดัดแปลง/จัดทำเป็นกรณีเฉพาะ** การแก้ไขรูปทรง ปรับขนาด หรือสร้างอุปกรณ์ขึ้นใหม่เฉพาะรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับความพิการหรือสรีระของผู้ป่วย ซึ่งไม่มีจำหน่ายทั่วไป

๒. กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ

คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัด และได้รับการประเมินจากวิชาชีพเวชกรรม/กายภาพบำบัด/กิจกรรมบำบัด ว่าจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่มีลักษณะเฉพาะบุคคล และไม่มีจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป หรืออุปกรณ์มาตรฐานไม่ตอบโจทย์การใช้งาน

๓. หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน

๑) หน่วยบริการสาธารณสุข (รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป/รพ.ชุมชน/รพ.สต.)
๒) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส่วนงานที่รับผิดชอบศูนย์สาธิตและยืม-คืน)
๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (กรณีดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการ/ศูนย์ยืมคืน)
๔) องค์กรคนพิการที่ได้รับการรับรองตามระเบียบ
๕) องค์กรภาคประชาชนที่ได้รับการรับรองตามระเบียบ

๔. **หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่าย** การสนับสนุนงบประมาณให้ใช้อัตราตามลำดับความสำคัญ ดังนี้

๑) กรณีการซ่อมแซม
๑.๑ ให้ใช้ราคาท้องตลาดโดยประหยัด (สืบราคาอย่างน้อย ๓ ราย)
๑.๒ ค่าซ่อมแซมรวมค่าแรงและค่าอะไหล่ ไม่ควรเกินร้อยละ ๖๐-๗๐ ของราคาจัดซื้อใหม่
๑.๓ กรณีดัดแปลง/ทำเฉพาะราย ให้พิจารณาตามต้นทุนวัสดุและค่าแรงตามความเหมาะสม โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ

การกำหนดรายการซ่อม ดัดแปลง เปลี่ยนชิ้นส่วน หรือการจัดทำเป็นกรณีเฉพาะของอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ อบจ.โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน กำหนดรายการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อม ดัดแปลง เปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ หรือ

การจัดทำอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการเป็นกรณีเฉพาะคนพิการ ทั้งนี้การซ่อม ดัดแปลง เปลี่ยนชิ้นส่วน ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่คนพิการได้รับในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีการจัดทำอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการเป็นกรณีเฉพาะคนพิการนั้น ๆ หรือการจัดทำใหม่ อบจ.โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนอาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสนับสนุน แยกเป็นการเฉพาะจากการซ่อม ดัดแปลง เปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์

๕. ลักษณะโครงการที่ให้การสนับสนุน

๑) การจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ สนับสนุนแก่หน่วยบริการ/อบจ. เพื่อนำไปให้บริการยืม-คืน หรือมอบให้ผู้ป่วย (ตามระเบียบกองทุน)

๒) การซ่อมแซม สนับสนุนค่าอะไหล่และค่าจ้างเหมาซ่อม

๓) การดัดแปลงและจัดทำเฉพาะ สนับสนุนค่าวัสดุและค่าแรงสำหรับช่างกายอุปกรณ์หรือช่างชุมชน

๖. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๑ การประเมินและคัดกรอง

๑) ผู้ดำเนินการ แพทย์, นักกายภาพบำบัด, หรือทีมสหวิชาชีพ

๒) การปฏิบัติ ตรวจประเมินผู้ป่วย และระบุชนิดของอุปกรณ์ที่จำเป็น หรือระบุส่วนที่ต้องซ่อมแซม/ดัดแปลง ลงใน "แผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)" หรือใบสั่งการรักษา

ขั้นตอนที่ ๒ การเสนอโครงการขอสนับสนุน

๑) กรณีรายบุคคล รพ./รพ.สต. รวบรวมรายชื่อและความต้องการ (ซื้อใหม่/ซ่อม)

๒) กรณีจัดซื้อเข้ากองกลาง หน่วยงาน (อบจ./ศูนย์ยืมคืน) สำรวจยอดรวม (Stock) และเสนอโครงการจัดซื้อประจำปี

๓) การแนบเอกสาร

๓.๑ โครงการ/แบบคำขอ

๓.๒ รายละเอียดคุณลักษณะ (Spec) และราคา (ปร.๔ หรือใบเสนอราคา)

๓.๓ แผนการดูแลรายบุคคล (กรณีระบุตัวผู้รับชัดเจน)

ขั้นตอนที่ ๓ การพิจารณาอนุมัติ

๑) คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องของรายการและราคาเทียบกับเกณฑ์ สปสช. กรมบัญชีกลาง ราคาตามท้องตลาด

๒) คณะกรรมการกองทุนฯ อนุมัติงบประมาณและโอนเงินให้หน่วยงานผู้เสนอโครงการ

ขั้นตอนที่ ๔ การดำเนินการจัดหา/ซ่อมแซม

๑) หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุของหน่วยงานนั้นๆ

๒) กรณีซ่อม/ดัดแปลง หากหน่วยงานทำเองได้ (มีช่างกายอุปกรณ์) ให้เบิกค่าวัสดุ หากทำเองไม่ได้ให้จ้างเหมาเอกชน/ร้านทำ

ขั้นตอนที่ ๕ การส่งมอบและลงทะเบียน

๑) ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบความถูกต้อง

๒) ส่งมอบ มอบให้ผู้ป่วยใช้งาน พร้อมแนะนำวิธีการใช้

๓) ลงทะเบียน

๓.๑ กรณีมอบขาด ลงทะเบียนคุมการแจกจ่าย

๓.๒ กรณีให้ยืม ลงทะเบียนทรัพย์สินศูนย์ยืม-คืน

๗. วิธีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด มีแนวทางและวิธีปฏิบัติ ดังนี้

๑) อบจ.เสนอแผนงานการจัดบริการและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ และวงเงินงบประมาณที่จะใช้บรรจุในแผนการเงินประจำปีของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพเสนอคณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติ

๒) อบจ.ประสานหน่วยงานที่มีศักยภาพให้แสดงความจำนงการจัดบริการพร้อมเสนอแผนปฏิบัติงานหรือโครงการ (การซ่อม ดัดแปลง เปลี่ยนชิ้นส่วน) ต่ออบจ. เพื่อเสนอคณะกรรมการกองทุน

๓) คณะกรรมการกองทุน พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติงาน/โครงการ และจำนวนงบประมาณตามความจำเป็น

๔) อบจ.จัดทำบันทึกข้อตกลงหรือสัญญากับหน่วยงานที่มีศักยภาพเป็นหน่วยหรือศูนย์บริการ

๕) หน่วยหรือศูนย์บริการดำเนินการจัดบริการตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ

๖) อบจ.เบิกจ่ายเงินให้กับหน่วยหรือศูนย์บริการ ตามที่กำหนดไว้

กรณีการจัดทำอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการเป็นกรณีเฉพาะคนพิการนั้น ๆ ควรให้หน่วยหรือศูนย์บริการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอขอการสนับสนุนเป็นครั้ง ๆ ไป ทั้งตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด

๘. หลักฐานและวิธีการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด มีแนวทาง และวิธีปฏิบัติ ดังนี้

๑) หน่วยบริการหรือศูนย์บริการ ส่งข้อมูลหรือรายงานการให้บริการ ให้อบจ. ตามที่กำหนดไว้ หรือ อบจ.ใช้แผนปฏิบัติงาน/โครงการ พร้อมบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าให้หน่วยบริการหรือศูนย์บริการ ตามที่ตกลงไว้ แล้วแต่กรณี

๒) อบจ.ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

๓) อบจ.ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับหน่วยบริการหรือศูนย์บริการ

๔) หน่วยบริการหรือศูนย์บริการ รายงานความก้าวหน้าให้คณะกรรมการกองทุนทราบ ตามที่กำหนด และเมื่อครบกำหนดหรือเสร็จสิ้นแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ให้สรุปรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานการจ่ายเงิน ส่งให้ อบจ. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนทราบ หากมีเงินคงเหลือจากการดำเนินงาน ให้ส่งคืนเข้ากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ

๕) หน่วยบริการหรือศูนย์บริการ เก็บหลักฐานการเบิกจ่ายไว้เพื่อรองรับการตรวจสอบ

๖) ส่งหลักฐานการจ่ายเงิน (ใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญรับเงิน) และรูปถ่ายอุปกรณ์/การซ่อมแซม ให้กองทุนฯ

๙. การกำกับติดตาม

๑) สุ่มตรวจอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนว่ามีอยู่จริงและใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์

๒) ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ที่ผ่านการซ่อมแซม/ดัดแปลง ว่ามีความแข็งแรงปลอดภัย

๓) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่ออุปกรณ์ที่ได้รับ

ภาคผนวก ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบราคา (สำหรับการตั้งงบประมาณ)

ประเภทรายการ	รายการอ้างอิงราคา	หมายเหตุ
๑. กายอุปกรณ์ทั่วไป	คู่มือรายการอุปกรณ์ฯ สปสช.	ใช้อัตราตามที่ สปสช. กำหนดเป็นเพดาน
๒. กายอุปกรณ์เทียม	กรมบัญชีกลาง (หมวดอวัยวะเทียม)	เช่น ขาเทียม, แขนเทียม
๓. งานซ่อมแซมทั่วไป	ราคาท้องตลาด (สืบราคา ๓ ร้าน)	เช่น ปะยาง, เปลี่ยนลูกปืนล้อ
๔. งานดัดแปลงเฉพาะ	ราคาประเมินวัสดุ + ค่าแรงช่าง	พิจารณาตามความยากง่ายของงาน

ข้อสังเกตเพิ่มเติมเพื่อการปฏิบัติงาน

- **การซ่อมแซมของเดิม** ควรถ่ายรูปสภาพ **"ก่อนซ่อม"** และ **"หลังซ่อม"** ไว้ทุกครั้ง เพื่อใช้ประกอบหลักฐานการเบิกจ่ายว่าได้ดำเนินการจริง

การสนับสนุนการจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ศูนย์ยืม-คืนกายอุปกรณ์และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑.นิยามการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูฯ

๑) **องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น** หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.), เทศบาล, เมืองพัทยา หรือ อปท. รูปแบบอื่น (ไม่รวม กทม.)

๒) **หน่วยบริการ** หมายความว่า สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.), โรงพยาบาลชุมชน)

๓) **องค์กรหรือกลุ่มประชาชน** หมายความว่า องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน ภาคเอกชนหรือบุคคลที่มีการรวมตัวกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลกำไร ทั้งนี้ จะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้ (เช่น ชมรมผู้สูงอายุ, ชมรมคนพิการ, กลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ)

๒. หลักการและเหตุผล การดำเนินงานต้องสอดคล้องกับระเบียบหลัก ดังนี้

๑) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง อบจ. กับ หน่วยงานในพื้นที่นั้นๆ

๓. ขั้นตอนการเตรียมการจัดตั้ง ก่อนการขออนุมัติโครงการ ต้องมีความพร้อมใน ๔ ด้าน

๑) บุคลากร ต้องมีการแต่งตั้ง "คณะกรรมการบริหารศูนย์ฟื้นฟูฯ" ประกอบด้วย

- ประธาน (ผู้บริหาร อปท. หรือ ผู้นำชุมชน)
- เลขานุการ (เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ นักกายภาพบำบัดชุมชน)
- กรรมการ (อสม., ผู้ดูแลคนพิการ, ตัวแทนคนพิการ)

- หน้าที่ วางแผน กำกับดูแล และรายงานผล

๒) สถานที่และครุภัณฑ์

- สถานที่ ต้องเข้าถึงง่ายสำหรับคนพิการ เช่น รพ.สต., วัด, หรืออาคารอเนกประสงค์ของ อบจ./อบต./เทศบาล
- ครุภัณฑ์ เตียงฝึกยืน, ราวหัดเดิน, อุปกรณ์กายภาพบำบัดพื้นฐาน, และ ธนาคารอุปกรณ์ (กายอุปกรณ์สำหรับยืมคืน)

๓) ระบบบริหารจัดการ

- ระเบียบการยืม-คืนอุปกรณ์
- ระบบทะเบียนข้อมูลคนพิการ/ผู้สูงอายุ (Database)

๔. ขั้นตอนการขอรับงบประมาณ เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบกองทุนฯ ต้องดำเนินการดังนี้

๑) สำรวจข้อมูล สำรวจจำนวนผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ และผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องฟื้นฟูฯ ในพื้นที่ เพื่อนำมาตั้งงบประมาณให้เหมาะสม

๒) เขียนโครงการ จัดทำ "โครงการจัดตั้งและดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน" โดยระบุ

๒.๑ หลักการและเหตุผล

๒.๒ วัตถุประสงค์ (เช่น เพื่อบริการกายภาพบำบัด, เพื่อบริการยืม-คืนอุปกรณ์)

๒.๓ กลุ่มเป้าหมาย (จำนวนราย)

๒.๔ กิจกรรม (อบรม Care Giver, ซ่อมแซมบ้าน, จัดหาอุปกรณ์)

๒.๕ หมวดงบประมาณ (ค่าตอบแทน, ค่าวัสดุ, ค่าครุภัณฑ์) ต้องอิงตามบัญชีราคามาตรฐาน

๓) เสนอโครงการ ยื่นต่อ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด (ที่มี นายก อบจ. เป็นประธาน)

๔) ทำสัญญารับเงิน เมื่ออนุมัติ ให้ทำบันทึกข้อตกลงการรับเงินและโอนเงินเข้าบัญชีโครงการ (แยกบัญชีเฉพาะ)

๕. แนวทางการดำเนินงานบริการ

๑) บริการฟื้นฟูสมรรถภาพต่อเนื่อง

๒) ให้บริการกายภาพบำบัดเบื้องต้นที่ศูนย์ฯ (โดยนักกายภาพบำบัด หรือ เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม)

๖. การติดตาม ประเมินผล และรายงาน

๒.การจัดตั้งศูนย์ยืม-คืน

๑. นิยาม

๑) ศูนย์ยืม-คืน หน่วยงานหรือสถานที่ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ให้ทำหน้าที่จัดหา เก็บรักษา ซ่อมแซม และให้บริการยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์และกายอุปกรณ์แก่กลุ่มเป้าหมาย

๒) กายอุปกรณ์/เครื่องช่วยความพิการ อุปกรณ์ที่ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ หรือช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน เช่น เตียงผู้ป่วย, ที่นอนลม, รถเข็น (Wheelchair), เครื่องผลิตออกซิเจน, เครื่องดูดเสมหะ, ไม้เท้า ฯลฯ

๓) กลุ่มเป้าหมาย คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน (IMC) ผู้ป่วยระยะท้าย (Palliative Care) และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่จังหวัด

๒. วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการฟื้นฟูสมรรถภาพได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

๒) เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวผู้ป่วยและภาครัฐ โดยใช้หลักการ "หมุนเวียนใช้ซ้ำ"

๓) เพื่อพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพให้ต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน

๓. **หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน** สามารถเสนอโครงการจัดตั้งหรือพัฒนาศูนย์ยืม-คืน ได้แก่

๑) หน่วยบริการสาธารณสุข (รพ., รพ.สต.)

๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล, อบต.)

๓) ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป / องค์กรคนพิการ

๔) ชมรมผู้สูงอายุหรือองค์กรภาคประชาชนที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการ

๔. **หมวดหมู่การสนับสนุน** กองทุนฯ สามารถสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานศูนย์ยืม-คืน แบ่งเป็น ๓ ส่วน ดังนี้

๑) การจัดหาครุภัณฑ์/อุปกรณ์

๑.๑ จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ (เช่น เตียง, รถเข็น) เพื่อเข้าสู่ระบบยืม-คืน

๑.๒ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการซ่อมแซมและบำรุงรักษา

๒) การบริหารจัดการศูนย์

๒.๑ ค่าปรับปรุงสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ ให้สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน

๒.๒ ค่าขนส่งอุปกรณ์ไป-กลับ บ้านผู้ป่วย (กรณีผู้ป่วยยากไร้ไม่สามารถขนย้ายเองได้)

๒.๓ ค่าวัสดุทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค

๓) การพัฒนาศักยภาพ

๓.๑ อบรมช่างชุมชน เพื่อซ่อมแซมกายอุปกรณ์

๓.๒ อบรมผู้ดูแล (Caregiver) เรื่องวิธีการใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง

๕. **หลักเกณฑ์การยืม-คืน**

๑) คุณสมบัติผู้ยืม

๑.๑ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรืออาศัยอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด

๑.๒ มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ตามการวินิจฉัยของแพทย์ นักกายภาพบำบัด หรือพยาบาลวิชาชีพ (Care Manager)

๑.๓ ผู้ยืมหรือญาติยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของศูนย์ฯ

๒) ระยะเวลาการยืม

๒.๑ กำหนดระยะเวลาตามความจำเป็นของแผนการรักษา (เช่น ๓ เดือน, ๖ เดือน)

๒.๒ สามารถต่อสัญญาได้หากยังมีความจำเป็น

๒.๓ ต้องส่งคืนเมื่อ: ผู้ป่วยเสียชีวิต, หายป่วย/เลิกใช้, ย้ายภูมิลำเนา, หรือทำผิดเงื่อนไข

๖. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๑ การจัดตั้งและจัดหา

๑) หน่วยงานเสนอโครงการขอจัดตั้งศูนย์หรือขอซื้ออุปกรณ์เพิ่มต่อกองทุน อบจ.

๒) เมื่อได้รับอนุมัติ ดำเนินการจัดซื้อและลงทะเบียนครุภัณฑ์ (ทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน ระบุรหัสครุภัณฑ์และที่มาของงบประมาณให้ชัดเจน)

ขั้นตอนที่ ๒ การให้บริการยืม

๑) ประเมิน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/CM ประเมินความจำเป็นของผู้ป่วย

๒) ทำสัญญา ผู้ป่วย/ญาติ ยื่นบัตรประชาชน ทำสัญญาการยืม (MOU) รับทราบเงื่อนไขความรับผิดชอบกรณีเสียหายจากการใช้งานผิดวิธี

๓) ส่งมอบ/สอน ส่งมอบอุปกรณ์พร้อมสอนวิธีการใช้งานและการดูแลรักษา

ขั้นตอนที่ ๓ การติดตาม

๑) เจ้าหน้าที่หรือ อสม. ติดตามเยี่ยมบ้าน ดูสภาพการใช้งานอุปกรณ์และอาการของผู้ป่วย

๒) หากอุปกรณ์ชำรุด ให้แจ้งศูนย์เพื่อนำกลับมาซ่อมแซม (ห้ามผู้ป่วยซ่อมเองหากไม่มีความรู้)

ขั้นตอนที่ ๔ การรับคืนและฟื้นฟูสภาพ

๑)เมื่อนำส่งคืน ศูนย์ฯ ทำการตรวจสอบสภาพ

๒)ทำความสะอาด/ฆ่าเชื้อ ต้องผ่านกระบวนการทำความสะอาดตามมาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ

๓)ซ่อมแซม หากชำรุด ให้ดำเนินการซ่อมแซมให้พร้อมใช้งาน

๔)นำเข้าระบบ ลงบันทึกรับคืน และเตรียมพร้อมให้รายต่อไปยืม

๗. วิธีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด มีแนวทาง และวิธีปฏิบัติ ดังนี้

๑) อบจ.เสนอแผนงานสนับสนุนการจัดบริการให้ยืมอุปกรณ์ บริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนหรือที่บ้าน และการจัดสภาพแวดล้อม และวงเงินงบประมาณที่จะใช้บรรจุในแผนการเงินประจำปีของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ เสนอคณะกรรมการกองทุน พิจารณาอนุมัติ

๒) อบจ.ประสานหน่วยงานที่สมัครใจและมีความพร้อม ให้เสนอโครงการดำเนินงานศูนย์บริการให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ต่ออบจ. เพื่อเสนอคณะกรรมการกองทุนพิจารณา

๓) คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ

๔) อบจ.จัดทำบันทึกข้อตกลงหรือสัญญากับหน่วยงานที่มีศักยภาพและได้รับอนุมัติเป็นหน่วยบริการหรือศูนย์ฯ ยืม

๕) อบจ.เบิกจ่ายเงินให้กับหน่วยบริการหรือศูนย์ฯ ยืม ตามบันทึกข้อตกลงหรือสัญญา

๖) หน่วยบริการหรือศูนย์ฯ ยืม ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ

๗) หน่วยบริการหรือศูนย์ฯ ยืม รายงานความก้าวหน้าให้คณะกรรมการทราบตามที่กำหนด

๘. หลักฐาน และวิธีการจ่ายเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ มีแนวทาง และวิธีปฏิบัติ ดังนี้

๑) อบจ.ใช้บันทึกข้อตกลงหรือสัญญาพร้อมโครงการที่ได้รับอนุมัติเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย

๒) อบจ.ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับหน่วยบริการหรือศูนย์ฯ ยืม ตามที่กำหนด

๓) หน่วยบริการหรือศูนย์ฯ ยืม ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามที่กำหนด เพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงิน และสรุปรายงานผลการดำเนินงานเมื่อครบกำหนดหรือเสร็จสิ้นตามโครงการ ส่งให้อบจ. และคณะกรรมการกองทุนทราบ ถ้ามีเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืนเข้ากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ

๔) เก็บหลักฐานการเบิกจ่ายไว้เพื่อรองรับการตรวจสอบ

๙. การบริหารจัดการทรัพย์สิน

๑) ทะเบียนคุม ศูนย์ยืม-คืน ต้องจัดทำทะเบียนคุมรายการอุปกรณ์ทั้งหมด (สถานะ: ว่าง, ถูกยืม, ส่งซ่อม, จำหน่ายออก)

๒) ความเป็นเจ้าของ ให้ถือว่าอุปกรณ์ที่จัดซื้อเป็นทรัพย์สินของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (หรือตามที่ระเบียบ อบจ. กำหนด) แต่ต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะตามโครงการเท่านั้น

๓) การจำหน่าย กรณีอุปกรณ์ชำรุดจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ ให้ดำเนินการจำหน่ายออกจากบัญชีตามระเบียบพัสดุ และรายงานให้กองทุนฯ ทราบ

๑๐. การกำกับและติดตาม

๑. ศูนย์ยืม-คืน รายงานสถานะการหมุนเวียนอุปกรณ์ (จำนวนผู้ยืม, จำนวนอุปกรณ์คงเหลือ) ให้กองทุนฯ ทราบ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

๒. คณะกรรมการกองทุนฯ ลงพื้นที่สุ่มตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ เพื่อดูความพร้อมของสถานที่และการจัดเก็บอุปกรณ์

๓. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และความคุ้มค่าของงบประมาณ (Cost-Benefit Analysis) เทียบกับการที่ผู้ป่วยต้องซื้อเอง

รายการอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีในศูนย์

ประเภท	รายการ
กลุ่มเคลื่อนไหว	รถเข็นนั่ง (Wheelchair) แบบธรรมดา/ปรับเอน, ไม้เท้า (Walker), ไม้ค้ำยัน
กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง	เตียงผู้ป่วย (มือหมุน/ไฟฟ้า), ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ, ผ้ายางรองนอน
กลุ่มระบบทางเดินหายใจ	เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen Concentrator), ถังออกซิเจน, เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว
กลุ่มดูแลทั่วไป	เครื่องดูดเสมหะ, เครื่องพ่นยา, เก้าอี้นั่งถ่าย

การสนับสนุนการดำเนินงานจัดสภาพแวดล้อมหรือบริการขั้นพื้นฐาน

๑. นิยามการจัดสภาพแวดล้อม

๑) การจัดสภาพแวดล้อม การดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับความพิการหรือภาวะสุขภาพ เพื่อความปลอดภัยและเพิ่มความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน

๒) กลุ่มเป้าหมาย คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ป่วยระยะท้าย มีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ

๒. หลักเกณฑ์การสนับสนุน

๑) สภาพบ้าน ไม่เหมาะสม ไม่ปลอดภัยต่อการอยู่อาศัย หรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตประจำวัน การฟื้นฟูสมรรถภาพ (เช่น ไม่มีทางลาด ห้องน้ำนั่งยอง ประตูแคบ)

๒) กรรมสิทธิ์ เป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง หรือหากเป็นของผู้อื่นต้องได้รับ หนังสือยินยอม จากเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือเจ้าของที่ดินให้ดำเนินการปรับปรุงได้

๓) ความเห็นทางวิชาการ ต้องผ่านการประเมินจากทีมสหวิชาชีพ (แพทย์/นักกายภาพบำบัด/นักกิจกรรมบำบัด) หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ว่ามีความจำเป็นต้องปรับปรุง

๓. รายการที่ให้การสนับสนุน

๑) ห้องน้ำ เปลี่ยนส้วมซึมเป็นชักโครก/นั่งราด, ติดตั้งราวจับ (Handrail), ปรับพื้นกันลื่น, ขยายประตูห้องน้ำ

๒) ทางเข้า/ภายในบ้าน สร้างทางลาด (Ramp) อัตราส่วน ๑:๑๒, ติดตั้งราวจับทางเดิน, ปรับระดับพื้นบ้านให้เรียบเสมอกัน

๓) ห้องนอน/ที่พัก ปรับความสูงเตียง, ติดตั้งราวจับหัวเตียง, ปรับแสงสว่างให้เพียงพอ

๔. งบประมาณ

๑) สนับสนุนตามความจำเป็นและประหยัด (วงเงินไม่เกินหลังละ ..... บาท ตามประกาศกองทุนฯ)

๒) เน้นใช้วัสดุที่คงทน หาได้ง่ายในท้องถิ่น และค่าแรงงานที่เหมาะสม (อาจใช้แรงงานจิตอาสาหรือช่างชุมชนร่วมด้วยเพื่อลดต้นทุน)

๕. ลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นระบบ ขอแบ่งเป็น ๕ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การค้นหาและยื่นคำขอ

๑) ผู้ดำเนินการ อสม., Care Manager (CM), ผู้นำชุมชน, หรือผู้ป่วย/ญาติแจ้งความประสงค์

๒) วิธีการ

๑) สำรวจผู้ที่มีความยากลำบากในการอยู่อาศัย

๒) ยื่น "แบบคำขอรับการปรับสภาพแวดล้อม" ผ่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัด , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/อบต.) ในพื้นที่

๓) แนบเอกสาร (สำเนาบัตร ปชช., ทะเบียนบ้าน, ภาพถ่ายสภาพบ้านปัจจุบัน)

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินและประมาณการ

๑) ผู้ดำเนินการ ทีมสหวิชาชีพ (นักกายภาพบำบัด/ช่าง อปท./เจ้าหน้าที่กองทุน)

๒) วิธีการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อประเมิน ๒ ส่วนหลัก

๒.๑ ประเมินทางกายภาพ (โดย สหวิชาชีพ) ประเมิน ADL (กิจวัตรประจำวัน) จุดเสี่ยงที่ต้องแก้ และสเปคอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับร่างกายผู้ป่วย

๒.๒ ประเมินทางช่าง (โดย กองช่าง) วัดพื้นที่ คำนวณวัสดุ จัดทำ ปร.๔ (ประมาณการค่าวัสดุและค่าแรง) และเขียนแบบแปลนสังเขป

๓) เอกสารสำคัญ หนังสือยินยอมให้ปรับปรุงที่อยู่อาศัย (กรณีไม่ใช่เจ้าของบ้าน)

ขั้นตอนที่ ๓ การพิจารณาอนุมัติ

๑) ผู้ดำเนินการ คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานกองทุนฯ

๒) วิธีการ

๒.๑ รวบรวมโครงการจากพื้นที่เสนอเข้าที่ประชุม

๒.๒ พิจารณาความจำเป็น ความคุ้มค่า และความถูกต้องของเอกสาร

๒.๓ มีมติอนุมัติและโอนงบประมาณให้หน่วยงานดำเนินการ (รพ.สต./อบต./เทศบาล)

ขั้นตอนที่ ๔ การดำเนินการปรับปรุง

๑) ผู้ดำเนินการ หน่วยงานที่รับเงิน/ทีมช่าง

๒) วิธีการ

๒.๑ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามระเบียบพัสดุ

๒.๒ ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง โดยช่างชุมชน ช่าง อปท. หรือจ้างเหมา

๒.๓ การควบคุมงาน ควรมีเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนชุมชนคอยดูหน้างานให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด (เช่น ทางลาดต้องไม่ชันเกินไป ราวจับต้องแน่นหนา)

ขั้นตอนที่ ๕ การส่งมอบและประเมินผล

๑) ผู้ดำเนินการ คณะกรรมการตรวจรับฯ

๒) วิธีการ

๒.๑ ตรวจสอบงานจ้างว่าเสร็จสมบูรณ์ตามแบบ

๒.๒ ส่งมอบงานให้ผู้ป่วย/ญาติใช้งาน

๒.๓ ประเมินผลลัพธ์ (Outcome) ติดตามดูว่าหลังปรับปรุงแล้ว ผู้ป่วยใช้ชีวิตดีขึ้นหรือไม่ (เช่น เข้าห้องน้ำเองได้, เข็นรถขึ้นบ้านได้สะดวก)

๒.๔ ถ่ายภาพ "หลังดำเนินการ (After)" เปรียบเทียบกับ "ก่อนดำเนินการ (Before)" เพื่อทำรายงานปิดโครงการ

๖. อบจ.ดำเนินการเองหรือร่วมกับ อบต. เทศบาล หน่วยงาน และภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกแบบระบบการดำเนินงาน โดยอาจนำเอาตัวอย่างขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย พ.ศ.๒๕๖๒ ของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานก็ได้ ทั้งนี้โดยทั่วไปมีหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

๑) อบจ. จัดทำระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสนับสนุน หรือกำหนดเป็นแนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อการจัดสภาพแวดล้อมหรือบริการขั้นพื้นฐาน และเสนอคณะกรรมการกองทุนพิจารณาเห็นชอบ (ตามประกาศฯ ข้อ ๑๕ (๓)) เพื่อประกาศให้หน่วยงาน และประชาชนทราบ

๒) รับเรื่องจากผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพหรือครอบครัว ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานราชการ หรือภาคเอกชน

๓) ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีการร้องขอหรือแจ้งความต้องการ

๔) อนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเบื้องต้น ประเมินสภาพ กำหนดรายการที่จะปรับปรุงและประเมินราคา

๕) เสนอคณะกรรมการกองทุนพิจารณา

๖) หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติโครงการ ดำเนินการจัดสภาพแวดล้อม

๗) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

ในการดำเนินงาน คณะกรรมการกองทุน อาจตั้งคณะอนุกรรมการระดับอำเภอ/คณะทำงานที่ประกอบด้วยผู้มีความรู้ด้านการปรับสภาพแวดล้อม เช่น ด้านช่าง ด้านสาธารณสุข ด้านกายภาพ มาพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามโครงการที่มาขอรับสนับสนุนก่อนการพิจารณาอนุมัติด้วยก็ได้

วงเงินค่าใช้จ่ายที่จะสนับสนุน เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการกองทุนที่จะพิจารณา โดยอาจอ้างอิงต้นทุนการปรับสภาพบ้านจากงานวิจัยเรื่อง "โครงการวิเคราะห์ต้นทุนและผลลัพธ์ของบริการปรับสภาพบ้านสำหรับคนพิการด้านการเคลื่อนไหวและผู้สูงอายุ" โดยคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พญ.ศิรินาถ ตงศิริและคณะ) หรือการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการปรับสภาพแวดล้อม และที่อยู่อาศัยของกรมกิจการผู้สูงอายุ ประกอบการพิจารณาคณะกรรมการกองทุนอาจกำหนดประเภทการปรับสภาพแวดล้อมและอัตราวงเงินสนับสนุนเป็นกรอบ ในหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข หรือแนวทางการสนับสนุนได้

๖.๑ หน่วยงานที่มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่าย คือ อบจ. อปท.อื่น สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรอื่นหรือกลุ่มประชาชน ในการอนุมัติโครงการ คณะกรรมการกองทุนควรจะพิจารณาถึงศักยภาพในการดำเนินโครงการของแต่ละหน่วยงาน

๖.๒ วิธีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด มีแนวทางและวิธีปฏิบัติ ดังนี้

๑) อบจ.เสนอแผนงานการสนับสนุนการดำเนินงานจัดสภาพแวดล้อมหรือบริการขั้นพื้นฐานการจัดสภาพแวดล้อม และวงเงินงบประมาณที่จะใช้ บรรจุในแผนการเงินประจำปีของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อเสนอคณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติ

๒) อบจ. อบต. เทศบาล หรือหน่วยงานอื่นที่มีสิทธิรับค่าใช้จ่าย จัดทำโครงการการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม เสนอ อบจ.

๓) คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติโครงการ และงบประมาณ ทั้งนี้คณะกรรมการกองทุนอาจตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานมาพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามโครงการก่อนการพิจารณาอนุมัติ

๔) อบจ.จัดทำบันทึกข้อตกลงหรือสัญญากับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

๕) อบจ.เบิกจ่ายเงินให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการตามที่กำหนด

๖) หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ และรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการให้ อบจ. และคณะกรรมการกองทุนทราบ ตามที่กำหนด

๗) อบจ.ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน

๖.๓ หลักฐานและวิธีการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด มีแนวทางและวิธีปฏิบัติ ดังนี้

๑) ใช้โครงการที่ได้รับอนุมติ และบันทึกข้อตกลงหรือสัญญา เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย

๒) ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ตามที่กำหนด

๓) หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการส่งสรุปรายงานผลการดำเนินงานเมื่อครบกำหนดหรือเสร็จสิ้นโครงการ ส่ง อบจ. เพื่อเสนอคณะกรรมการกองทุน ถ้ามีเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืนเข้ากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ

๔) เก็บหลักฐานการเบิกจ่ายไว้เพื่อรองรับการตรวจสอบ

ประเภทที่ ๒ การสนับสนุนและส่งเสริมโครงการด้านพัฒนาศักยภาพ การมีส่วนร่วม และงานวิชาการ มีแนวทางและวิธีปฏิบัติ ดังนี้

๑. นิยาม

๑.๑ **โครงการด้านพัฒนาศักยภาพ** กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถของบุคลากร อาสาสมัคร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพ

๑.๒ **โครงการด้านการมีส่วนร่วม** กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม

๑.๓ **โครงการด้านวิชาการและนวัตกรรม** การศึกษาวิจัย การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การถอดบทเรียน หรือการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อการดูแลสุขภาพ

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อยกระดับความรู้และทักษะของบุคลากร (Care Manager, Care Giver), อาสาสมัคร และครอบครัว ให้สามารถดูแลผู้ป่วยและคนพิการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ

๒.๒ เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลและงานวิชาการให้สามารถนำมาใช้วางแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของจังหวัดได้อย่างแม่นยำ

๒.๓ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนของตนเอง

๓. ระยะเวลาดำเนินการ

๓.๑ ให้ดำเนินการภายในปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน)

๓.๒ กรณีงานวิจัยหรือโครงการต้องระบุแผนงานระยะเวลาดำเนินการให้เสร็จภายในปีงบประมาณ หากเกินระยะเวลาต้องดำเนินการจัดทำหนังสือเพื่อขอขยายระยะเวลาโครงการอย่างน้อย ๑ เดือนก่อนจะสิ้นสุดโครงการและต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนฯ

๔. หลักเกณฑ์การพิจารณา

๔.๑ ความจำเป็น หัวข้อการอบรมหรือวิจัยต้องตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพเร่งด่วน หรือเป็นการปิดช่องว่างทางทักษะของบุคลากรในพื้นที่

๔.๒ มาตรฐานหลักสูตร กรณีจัดอบรม ต้องมีหลักสูตรที่ชัดเจน หรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานวิชาชีพ (เช่น กรมอนามัย, สภาวิชาชีพ)

๔.๓ ความคุ้มค่า งบประมาณต้องเป็นไปตามระเบียบราชการ (ค่าอาหาร, ค่าวิทยากร, ค่าเช่าสถานที่) และเน้นผลลัพธ์ที่นำไปใช้จริงได้

๔.๔ ไม่ซ้ำซ้อนกับภารกิจปกติหรืองบประมาณปกติของหน่วยงานต้นสังกัด

๕. ขอบเขตกิจกรรมที่ให้การสนับสนุน แบ่งเป็น ๓ หมวด ดังนี้

๕.๑ ด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากร

๑) การอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (CG) ๗๐ ชั่วโมง / ๔๒๐ ชั่วโมง

๒) การอบรมฟื้นฟูความรู้ (Refresher Course) ประจำปีสำหรับ CM/CG/อสม.

๓) การอบรมช่างชุมชน เพื่อซ่อมแซมกายอุปกรณ์หรือปรับสภาพบ้าน

๔) การอบรมทักษะเฉพาะทาง เช่น การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม, การทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น

๕.๒ ด้านการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย

๑) การจัดเวทีประชาคมสุขภาพระดับอำเภอ/จังหวัด เพื่อระดมความเห็นจัดทำแผนสุขภาพ

๒) การจัดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมสุขภาพชุมชน

๓) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างข้อตกลงร่วม (MOU) ระหว่างหน่วยงาน

๕.๓ ด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม

๑) การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสุขภาพกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่

๒) การวิจัยและประเมินผลระบบบริการสาธารณสุข

๓) การผลิตนวัตกรรมกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น

๔) การถอดบทเรียนการดำเนินงานเพื่อจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน

๖.หน่วยงานที่มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่าย คือ อบจ. อปท.อื่น สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรอื่นหรือกลุ่มประชาชน ในการอนุมัติโครงการ คณะกรรมการกองทุนควรจะพิจารณาถึงศักยภาพในการดำเนินโครงการของแต่ละหน่วยงาน

๗. วิธีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด มีแนวทางและวิธีปฏิบัติ ดังนี้

๑) อบจ.เสนอแผนงาน โครงการสนับสนุนและส่งเสริมโครงการด้านพัฒนาศักยภาพ การมีส่วนร่วม และงานวิชาการ และวงเงินงบประมาณที่จะใช้บรรจุในแผนการเงินประจำปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัดเพื่อเสนอคณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติ

๒) อบจ. อบต. เทศบาล หรือหน่วยงานอื่นที่มีสิทธิรับค่าใช้จ่าย จัดทำโครงการสนับสนุนและส่งเสริมโครงการด้านพัฒนาศักยภาพ การมีส่วนร่วม และงานวิชาการ เสนอ อบจ.

๓) คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติโครงการ และงบประมาณ ทั้งนี้คณะกรรมการกองทุนอาจตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานมาพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามโครงการก่อนการพิจารณาอนุมัติ

๔) อบจ.จัดทำบันทึกข้อตกลงหรือสัญญากับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

๕) อบจ.เบิกจ่ายเงินให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการตามที่กำหนด

๖) หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ และรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการให้ อบจ. และคณะกรรมการกองทุนทราบ ตามที่กำหนด

๗) อบจ.ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน

๘. หลักฐานและวิธีการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด มีแนวทางและวิธีปฏิบัติ ดังนี้

๑) ใช้โครงการที่ได้รับอนุมติ และบันทึกข้อตกลงหรือสัญญา เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย

๒) ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ตามที่กำหนด

๓) หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการส่งสรุปรายงานผลการดำเนินงานเมื่อครบกำหนดหรือเสร็จสิ้นโครงการ ส่ง อบจ. เพื่อเสนอคณะกรรมการกองทุน ถ้ามีเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืนเข้ากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ

๔) เก็บหลักฐานการเบิกจ่ายไว้เพื่อรองรับการตรวจสอบ

๙. การโอนงบประมาณ

๑) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

๒) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย ให้ระบุรายละเอียดหมวดค่าตอบแทนนักวิจัย ค่าเก็บข้อมูล และค่าวิเคราะห์ข้อมูลให้ชัดเจน

๓) การโอนเงินให้เป็นไปตามระเบียบกองทุนฯ (โอนเข้าบัญชีหน่วยงานรัฐ หรือ บัญชีโครงการของกลุ่มประชาชน)

ประเภทที่ ๓ การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเตรียมความพร้อมและรับมือโรคติดต่อ ภัยธรรมชาติ และภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและสังคม มีแนวทางและวิธีปฏิบัติ ดังนี้

๑. นิยามศัพท์

๑) **ภาวะฉุกเฉิน** สถานการณ์ที่มีแนวโน้มหรือเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ชีวิต ทรัพย์สิน หรือความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง

๒) **โรคติดต่อ** โรคที่เกิดจากเชื้อโรคหรือพิษของเชื้อโรค ซึ่งสามารถแพร่ระบาดจากคนสู่คน หรือสัตว์สู่คน (เช่น COVID-๑๙, ไข้เลือดออก)

๓) **ภัยธรรมชาติ** ภัยที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (เช่น น้ำท่วม, ภัยแล้ง, ฝุ่น PM๒.๕, วาตภัย)

๔) **ภาวะฉุกเฉินทางสังคม** เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางสังคมหรือจิตใจของประชาชน (เช่น ความรุนแรงในชุมชน, วิกฤตการณ์ขาดแคลนอาหาร/น้ำดื่ม)

๕) **หน่วยงานผู้เสนอโครงการ** ส่วนราชการสังกัด อบจ., อปท.อื่น, หน่วยบริการสาธารณสุข, หน่วยงานรัฐอื่น, องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ หรือกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกัน

๒. วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและทันท่วงทีในการป้องกัน ควบคุม และระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคหรือผลกระทบจากภัยพิบัติ

๒) เพื่อสนับสนุนทรัพยากร (งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์) ให้แก่หน่วยงานเครือข่ายในการปฏิบัติงานในพื้นที่

๓) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและดูแลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในชุมชน

๔) เพื่อฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่และสุขภาพจิตของประชาชนหลังเกิดภาวะวิกฤต

๓. หน่วยงานที่มีสิทธิเสนอโครงการ

๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล, อบต.

๒) หน่วยบริการสาธารณสุข สสจ., สสอ., รพ., รพ.สต.

๓) ส่วนราชการอื่น ปภ.จังหวัด, สถานศึกษา, เรือนจำ

๔) ภาคประชาชน/องค์กร อสม., มูลนิธิกู้ชีพกู้ภัย, ชมรมผู้สูงอายุ, กลุ่มแม่บ้าน

๔. ระยะเวลาดำเนินการ

๑) กรณีเตรียมความพร้อม ดำเนินการตามปีงบประมาณปกติ

๒) กรณีเผชิญเหตุเร่งด่วน ให้เริ่มดำเนินการทันทีหลังได้รับอนุมัติ (หรือตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน) และควรดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว (เช่น ภายใน ๓๐-๖๐ วัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์)

๕. หลักเกณฑ์การพิจารณา

๑) ความจำเป็นเร่งด่วน เป็นปัญหาที่หากไม่ดำเนินการจะเกิดความเสียหายต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชนในวงกว้าง

๒) สถานการณ์จริง มีข้อมูลระบาดวิทยา หรือประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรองรับ

๓) ศักยภาพ หน่วยงานผู้เสนอโครงการมีความพร้อมในการดำเนินงานทันที

๔) ไม่ซ้ำซ้อน ต้องตรวจสอบว่าไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณปกติ หรือ งบช่วยเหลือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัด (เชิงป้องกันและเติมเต็มช่องว่าง)

๖. ขอบเขตการสนับสนุนงบประมาณ

๑) ค่าวัสดุ เวชภัณฑ์, สารเคมีกำจัดเชื้อ/แมลง, อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE), วัสดุวิทยาศาสตร์

๒) ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมารถ/เรือ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่/อาสาสมัคร, ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

๓) ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนวิทยากร หรือค่าป่วยการอาสาสมัคร (ตามระเบียบราชการ)

๔) ข้อจำกัด ไม่สนับสนุนค่าครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ (ยกเว้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ)

๗. การโอนงบประมาณ

๑) กรณีปกติ โอนเงินงวดเดียวเต็มจำนวนหลังลงนามข้อตกลง

๒) กรณีเร่งด่วน หากมีความจำเป็นเร่งด่วน อาจพิจารณาอนุมัติหลักการให้ดำเนินการไปก่อน แล้วเบิกจ่ายงบประมาณตามหลัง หรือโอนเงินโดยเร่งด่วนภายใน ๓-๕ วันทำการ

๓) หน่วยงานรับเงินฝากบัญชีธนาคารของหน่วยงาน หรือบัญชีกลุ่มองค์กรที่เปิดไว้เพื่อโครงการโดยเฉพาะ

๘. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเตรียมการ

๑) หน่วยงานจัดทำแผนเตรียมความพร้อมเสนอต่อ อบจ. ตามรอบปีงบประมาณ

๒) พิจารณาอนุมัติและโอนเงินตามปกติ

ระยะเผชิญเหตุ

๑. แจ้งเหตุ/เสนอโครงการด่วน หน่วยงานทำหนังสือแจ้งสถานการณ์และขอสนับสนุนงบประมาณเร่งด่วน (บันทึกข้อความสั้น)

๒. พิจารณาอนุมัติพิเศษ คณะผู้บริหาร อบจ. หรือคณะกรรมการกองทุนฯ ประชุมพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ (วาระเร่งด่วน)

๓. ดำเนินการทันที แจ้งผลอนุมัติให้หน่วยงานเริ่มปฏิบัติงาน

๔. โอนงบประมาณ อบจ. เร่งรัดการเบิกจ่ายโอนเงินเข้าหน่วยงาน

๕. ปฏิบัติงาน หน่วยงานลงพื้นที่ควบคุมโรค/ช่วยเหลือประชาชน

๑๐. การกำกับ ติดตาม และประเมินผล

๑) รายงานสถานการณ์ กรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ ให้รายงานความคืบหน้าเป็นระยะ (เช่น รายสัปดาห์) ผ่านช่องทางสื่อสารที่รวดเร็ว (Line Group/โทรศัพท์)

๒) รายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ

๒.๑ รายงานผลการดำเนินงาน สรุปจำนวนผู้ได้รับความช่วยเหลือ ผลการควบคุมโรค

๒.๒ รายงานการเงิน หลักฐานการจ่ายเงิน ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริงหรือสำเนาตามระเบียบ)

๒.๓ เงินเหลือจ่าย ส่งคืนกองทุน/อบจ. ภายใน ๓๐ วันหลังจบโครงการ

ประเภทที่ ๔ การสนับสนุนและส่งเสริมแผนงานบริหารจัดการและพัฒนาระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด มีแนวปฏิบัติ ดังนี้

๑. นิยามศัพท์

๑) **ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ** หมายถึง รายจ่ายที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการกองทุนฯ การจัดประชุม การประชาสัมพันธ์ และค่าตอบแทนคณะกรรมการ/อนุกรรมการ

๒) **การพัฒนาศักยภาพ** หมายถึง การจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

๓) **เงินกองทุนตามข้อ ๗ (๑) และ ๗ (๒)** หมายถึง เงินรายรับหลักของกองทุนในแต่ละปีงบประมาณ ประกอบด้วย ๗ (๑) เงินที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ๗ (๒) เงินสมทบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)

๒. วัตถุประสงค์

๑) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนให้มีความคล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้

๒) เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของคณะกรรมการ คณะทำงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย

๓) เพื่อสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ และบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน ที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนงานกองทุน

๓. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการภายในปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ของปีถัดไป) กรณีมีความจำเป็นต้องก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

๔. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานเลขานุการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (หรือกองสาธารณสุข/กองยุทธศาสตร์ ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เลขานุการกองทุน)

๕. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

๑) วงเงินงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในหมวดนี้รวมกัน ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับตามข้อ ๗ (๑) และ ๗ (๒) ที่ได้รับในปีงบประมาณนั้น

๒) ความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน กรณีมีการจัดหาครุภัณฑ์ (เช่น คอมพิวเตอร์, โต๊ะทำงาน) ให้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุของ อบจ. และให้ครุภัณฑ์ดังกล่าว ตกเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

๓) การจ้างบุคลากร ต้องเป็นการจ้างเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกองทุนเป็นการเฉพาะ หรือมีความจำเป็นเร่งด่วน โดยอัตราค่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการหรือ อบจ.

๖. ขอบเขตการสนับสนุน สามารถสนับสนุนงบประมาณได้ในรายการดังต่อไปนี้

๑) ด้านการบริหารจัดการ

๑.๑ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงาน

๑.๒ ค่าวัสดุสำนักงาน (กระดาษ, หมึกพิมพ์, แฟ้ม)

๑.๓ ค่าประชาสัมพันธ์กิจการของกองทุน (ป้ายไวนิล, แผ่นพับ, สื่อออนไลน์)

๑.๔ ค่าสาธารณูปโภค (กรณีแยกมิเตอร์ชัดเจน) หรือค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

๒) ด้านการพัฒนาศักยภาพ

๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนาสำหรับคณะกรรมการและภาคีเครือข่าย

๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อกิจการของกองทุน

๓) ด้านครุภัณฑ์และบุคลากร

๓.๑ การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานที่จำเป็น (คอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์, โปรแกรมสำเร็จรูป)

๓.๒ การจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล หรือผู้ช่วยเลขานุการกองทุน

๗. การโอนงบประมาณ

๑) เมื่อโครงการได้รับอนุมัติ ให้กองทุนโอนงบประมาณเข้าบัญชี หรือตั้งเบิกจ่ายผ่านระบบการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

๒) การเก็บรักษาเงินและการเบิกจ่ายให้ถือปฏิบัติตามระเบียบงานคลังและพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม

๘. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๑ การคำนวณวงเงิน สำนักงานเลขานุการฯ ตรวจสอบยอดเงินรับจัดสรรปีปัจจุบัน (๗.๑ + ๗.๒) และคำนวณเพดาน ๑๕% เพื่อกำหนดกรอบงบประมาณสูงสุดที่ตั้งได้

ขั้นตอนที่ ๒ การเสนอโครงการ จัดทำแผนงาน/โครงการบริหารจัดการประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ (ควรทำตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ)

ขั้นตอนที่ ๓ การพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาความจำเป็น ความเหมาะสม และตรวจสอบว่าไม่เกินวงเงินร้อยละ ๑๕

ขั้นตอนที่ ๔ การดำเนินการ การจัดซื้อ/จัดจ้าง ดำเนินการตามระเบียบพัสดุของ อบจ. การจัดประชุม/อบรม ดำเนินการตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ

ขั้นตอนที่ ๕ การรายงานผล สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ

๙. การกำกับ ติดตาม และประเมินผล

๑) ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ให้มีการจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ที่จัดซื้อด้วยเงินกองทุน และระบุเลขรหัสครุภัณฑ์เป็นของ อบจ. (อาจระบุหมายเหตุว่า ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ปี พ.ศ....)

๒) การตรวจสอบบัญชี ต้องจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย แยกต่างหากจากการเงินปกติของ อบจ. เพื่อรองรับการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

๓) การประเมินความคุ้มค่า ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จ้างเหมา และความคุ้มค่าของการใช้ครุภัณฑ์ในการสนับสนุนงานกองทุน

๑๐. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด เช่น

๑) การสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน

๒) การจัดหาวัสดุที่จำเป็นในการบริหารจัดการหรือดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด

๓) การจ้างเหมาบริการ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการหรือดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด

๔) การจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการบริหารจัดการหรือดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด ในกรณีนี้ครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้ขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สินของ อบจ.

๕) การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ และดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด เช่น การอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน ของคณะกรรมการกองทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

๖) การติดตาม และประเมินผล การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

๗) อื่น ๆ เพื่อการบริหารจัดการหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด

ทั้งนี้ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ให้ดำเนินการตามกฎหรือระเบียบที่ อบจ. ถือปฏิบัติ

๑๑. วิธีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด มีแนวทาง และวิธีปฏิบัติ ดังนี้

๑) อบจ.เสนอแผนงานสนับสนุนการบริหารจัดการหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัดและวงเงินงบประมาณ บรรจุในแผนการเงินประจำปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด เสนอคณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติ

๒) อบจ.โดยฝ่ายคลัง/การเงิน หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคลังที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด บริหารค่าใช้จ่ายตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน สามารถดำเนินการได้ ๒ กรณี

๒.๑) กรณีแรก กิจกรรมที่เป็นการจัดประชุม (คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน) การจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ การจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ไม่ต้องจัดทำโครงการ ให้ฝ่ายเลขานุการหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินการแต่ละกิจกรรม ตามแผนงานสนับสนุนการบริหารจัดการหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัดที่ได้รับอนุมัติ และดำเนินการตามแนววิธีปฏิบัติของอบจ. และเบิกจ่าย ตามลำดับ

๒.๒) กรณีที่สอง กิจกรรมการประชุมอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน การติดตาม และประเมินผล ฯลฯ ให้ฝ่ายเลขานุการหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัดจัดทำโครงการแต่ละกิจกรรมเสนอนายก อบจ.พิจารณาอนุมัติโครงการ และดำเนินการตามแนววิธีปฏิบัติของอบจ. และเบิกจ่าย ตามลำดับ

ทั้งนี้ การจัดทำแผนงานสนับสนุนการบริหารจัดการหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด ที่บรรจุในแผนการเงินประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการอนุมัตินั้น จำเป็นต้องระบุรายละเอียดของ

กิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน และดำเนินการตามที่ระบุไว้ หากไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานได้ ให้เสนอขอปรับแผนงานต่อคณะกรรมการกองทุน

๑๒. หลักฐานและวิธีการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด มีแนวทาง และวิธีปฏิบัติ ดังนี้

๑) อบจ.โดยฝ่ายเลขานุการหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานส่งหลักฐานและใบสำคัญพร้อมบันทึกที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินกิจกรรม เพื่อเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด

๒) อบจ.โดยฝ่ายคลัง/การเงิน เก็บหลักฐานการเบิกจ่ายไว้ เพื่อรองรับการตรวจสอบ

๓) ฝ่ายเลขานุการหรือเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบงานสรุปรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานการจ่ายเงินให้คณะกรรมการกองทุนทราบ

บทที่ ๕
วิธีปฏิบัติในการจัดทำบัญชี และการรายงาน

หลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๑ แห่งประกาศฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดให้การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทำบัญชี และรายงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด และการกำกับติดตามเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กำหนดให้ดำเนินการตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ซึ่งมีรายละเอียดที่จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

๑. วิธีการรับเงินและการเก็บรักษาเงินกองทุน

๑.๑ บรรดาเงินรายรับของกองทุนให้นำส่งเข้าบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัด... ที่เปิดบัญชีกับสถาบันการเงินเฉพาะของรัฐ ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัด .....” เพื่อรับเงินจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เงินสมทบจาก อบจ. และรายได้อื่น ๆ หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเห็นชอบ

เว้นแต่กรณีที่ได้รับเงินค่าบริการสาธารณสุขอื่น ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเปิดบัญชีกับธนาคารที่สำนักงานกำหนด โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัด...เพื่อบริการ...” แยกออกจากบัญชีกองทุนตามวรรคหนึ่ง

กรณีเงินที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับจากแหล่งทุนอื่น ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเปิดบัญชีแยกออกจากบัญชีกองทุนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ทั้งนี้ การเปิดบัญชีและชื่อบัญชีให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานเจ้าของแหล่งทุน

ทั้งนี้ บัญชีกองทุนที่ได้เปิดบัญชีไว้แล้วก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นบัญชีเงินฝากตามประกาศนี้

๑.๒ การรับเงินเข้ากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพให้รับเป็นเงินสด เช็ค หรือโอนเข้าบัญชีทางธนาคารหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) หรือวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด และให้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชำระเงินทุกครั้ง เว้นแต่การรับเงินที่ได้รับการจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือการรับเงินสมทบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ใช้หลักฐานการโอนเงินทางธนาคารหรือหลักฐานอื่นที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร เป็นหลักฐานอ้างอิงในการบันทึกบัญชีรายรับ

๑.๓ เงินสดที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพได้รับไว้ ให้นำฝากเข้าบัญชี ตามข้อ ๑.๑ ภายในวันที่ได้รับเงิน หากไม่สามารถนำเงินดังกล่าวฝากเข้าบัญชีได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย ฝ่ายคลัง/เจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด นำเงินสดจำนวนดังกล่าวเก็บรวมไว้ในซองหรือหีบห่อ ระบุเงินกองทุน จำนวนเงินปิดผนึกลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบ และนำฝากไว้ที่ตู้นิรภัยหรือสถานที่เก็บรักษาเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วให้นำฝากเข้าบัญชีในวันทำการถัดไป

๑.๔ การสมทบเงินจาก อบจ. ให้ดำเนินการโดยเร็วเมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณ อย่างช้าไม่ควรเกินไตรมาสแรกของปีงบประมาณ กรณีมีความจำเป็น ให้สมทบได้ไม่เกินปีงบประมาณที่ สปสช.จ่ายเงินสนับสนุน (ดูรายละเอียดการตั้งสมทบในบทที่ ๒)

๒. วิธีการจ่ายเงินกองทุน

๒.๑ ให้นายก อบจ. สั่งจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด เป็นผู้สั่งจ่ายตามเงื่อนไขข้อ ๑๑ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ แล้วแต่กรณี เว้นแต่กรณีการจ่ายเงินกองทุนตามข้อ ๑๒ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อตกลงระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงาน และหน่วยงานเจ้าของแหล่งทุนนั้น

๒.๒ วิธีการจ่ายเงินกองทุนให้จ่ายได้ มีดังนี้

๑) จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม

๒) จ่ายเป็นการโอนเข้าบัญชีทางธนาคารหรือทางอิเล็กทรอนิกส์

๓) จ่ายวิธีอื่นตามที่ตกลงกับสำนักงาน

๒.๓ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนใดคนหนึ่งลงนามร่วมกับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด คนใดคนหนึ่ง ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายไว้จำนวนสองคน รวมเป็นผู้ลงนามหรืออนุมัติจำนวนสองคน เป็นผู้เบิกเงินจากบัญชีกองทุนตามเงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุน

๒.๔ การจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น ให้ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าของหน่วยงานนั้น ๆ เป็นผู้รับเงิน หากไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทนก็ให้กระทำได้ทั้งนี้ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่ชัดเจน

๒.๕ การจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นองค์กรหรือกลุ่มประชาชน ให้ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรหรือกลุ่มประชาชน ไม่น้อยกว่าสองคนขึ้นไปเป็นผู้รับเงิน

๒.๖ การจ่ายเงินกองทุนต้องมีหลักฐานการจ่ายเป็นใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญรับเงิน หรือหลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน หรือหลักฐานการรับเงินอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด เก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ

ข้อแนะนำสำหรับเป็นแนวทางประกอบการดำเนินงาน

๑) การรับเงินเข้าบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด ควรออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ชำระเงินทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงในการบันทึกบัญชี

๒) การรับเงินโอนจาก สปสช. สามารถใช้หลักฐานการโอนเงินทางธนาคารเป็นหลักฐานอ้างอิงในการบันทึกบัญชีได้เลย โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://smt.nhso.go.th

- เลือกสืบค้นตามเขตพื้นที่ / จังหวัด
- ระบุรหัสหน่วยงานกองทุน MF.....
- เลือกวันที่..... ถึง วันที่....
- เลือกค้นหาเอกสาร

๓) การรับเงินสมทบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ใช้หลักฐานการโอนเงินทางธนาคารหรือหลักฐานอื่นเพิ่มเติมได้ ตามที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร

๔) การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด กรณีจ่ายตามข้อตกลงหรือสัญญาเงื่อนไขการจ่ายเงินจะกำหนดจ่ายงวดเดียวหรือแบ่งจ่ายเป็นงวด ให้เป็นไปตามแนววิธีปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยโครงการหรือกิจกรรมต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน และประธานกรรมการได้ลงนามอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรเรียบร้อยแล้ว หากมีกรณีจำเป็นไม่สามารถปฏิบัติตามแนววิธีปฏิบัติได้ ให้เสนอคณะกรรมการกองทุนพิจารณาให้ความเห็นชอบ แบบบันทึกข้อตกลงหรือสัญญายึดตามแบบของอบจ. ซึ่งควรระบุรายละเอียดอันเป็นสาระสำคัญให้ครบถ้วน ประกอบด้วย

- รายละเอียดโครงการ เช่น ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ที่อยู่ เป็นต้น

- รายละเอียดงวดเงิน (เงื่อนไขการจ่ายเงิน) ว่ามีการจ่ายอย่างไร กี่งวด งวดละเท่าไร จ่ายเมื่อไร เช่น

งวดที่ ๑ จ่ายให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ร้อยละ ... ของเงินทั้งหมดเป็นเงิน ... บาท (.....) เมื่อมีการลงนามในข้อตกลงแล้ว

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) จ่ายให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ร้อยละ ... ของเงินทั้งหมดเป็นเงิน ... บาท (.....) เมื่อผู้รับผิดชอบส่งรายงานผลสรุปตามโครงการทั้งหมด

- งวดงาน เป็นการกำหนดการส่งมอบงาน หรือรายงานผลงานที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานตามโครงการ ซึ่งข้อมูลนี้จะเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งในการพิจารณาการเบิกจ่ายเงิน

- การกำหนดหรือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือติดตามผลการดำเนินงาน

- หลักฐานการรับเงินของผู้รับผิดชอบโครงการ

- หลักฐานการส่งมอบงานหรือรายงานผลการดำเนินงาน จัดทำหรือส่งตามการกำหนดงวดงาน งวดเงิน

๓. การจัดทำบัญชีและรายงานกองทุน

วิธีการจัดทำบัญชี

๓.๑ การบันทึกบัญชี ให้บันทึกตามรูปแบบที่สำนักงานกำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เว็บไซต์ https://pfr.nhso.go.th ซึ่งมีรายละเอียดที่จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

๑. การบันทึกบัญชีผ่านโปรแกรม https://pfr.nhso.go.th โดยสรุปเบื้องต้น ดังนี้

๑) ให้บันทึกแผนการเงินประจำปี แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม (ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนแล้ว)

๒) ให้บันทึกรายการรับเมื่อมีรายรับเกิดขึ้น โดยเข้าไปบันทึกรายการในบันทึกรายการรับ

- เงินที่ได้รับจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ตามข้อ ๗ (๑))

- เงินสมทบจาก อบจ. (ตามข้อ ๗(๒))

- เงินสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่นที่มีวัตถุประสงค์หรือภารกิจที่สอดคล้องกับกองทุน โดยความเห็นชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและสำนักงาน (ตามข้อ ๗ (๓))

- รายได้อื่น ๆ (โดยระบุรายการ เช่น ดอกเบี้ย เงินบริจาค) (ตามข้อ ๗ (๔))

๓) ให้บันทึกรายการจ่าย เพื่อนำมาสู่การบันทึกวิธีการจ่ายเงิน และจำนวนเงินที่จ่าย

- จ่ายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชนในจังหวัด เพื่อส่งเสริมประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่เข้าถึงการบริการสาธารณสุขและการแก้ปัญหาสุขภาพด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นได้มากขึ้น (ตามข้อ ๑๑ (๑))

- จ่ายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชนในจังหวัด เพื่อให้การบริการสาธารณสุขและการแก้ปัญหาสุขภาพด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นในพื้นที่ให้มีศักยภาพและเข้มแข็งมากขึ้น (ตามข้อ ๑๑ (๒))

- จ่ายกรณีเกิดโรคติดต่อ หรือภัยธรรมชาติ หรือภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและสังคมที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ (ตามข้อ ๑๑ (๓))

- จ่ายให้ อบจ. (ตามข้อ ๑๑ (๔))

๕) รายงานทางบัญชีจะถูกประมวลผลโดยโปรแกรมฯ

- รายงานสรุปสถานะการเงิน (ประจำเดือน/ไตรมาส/ปี)

- รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ (ประจำเดือน/ไตรมาส/ปี)

- ทะเบียนคุมเงินรายรับ (ประจำเดือน/ไตรมาส/ปี)

- ทะเบียนคุมเงินรายจ่าย (ประจำเดือน/ไตรมาส/ปี)

- ทะเบียนคุมการจัดทำเช็ค / โอนเงิน (ประจำเดือน/ไตรมาส/ปี)

- ทะเบียนคุมเช็ค (ประจำเดือน/ไตรมาส/ปี)

- ทะเบียนคุมเงินรับคืนจากโครงการ (ประจำเดือน/ไตรมาส/ปี)

- อื่น ๆ ที่กำหนดเพิ่มเติม

๖) เอกสาร / แบบฟอร์ม อิเล็กทรอนิกส์ (E-From) โปรแกรมฯ สามารถสร้างได้

- บันทึกข้อตกลงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ

- ฎีกาเบิกเงิน จากบัญชีเงินกองทุนฯ

- ใบเสร็จรับเงิน กรณีรับเงินเข้ากองทุนฯ

- ใบสำคัญรับเงิน กรณีจ่ายเงินออกจากกองทุนฯ ให้กับผู้รับเงินที่ไม่สมารถออกใบเสร็จรับเงิน

๓. การรายงาน

๑) อบจ. จัดทำรายงานสถานะการเงิน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ ด้วยระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมฯ https://pfr.nhso.go.th

๒) อบจ. จัดส่งรายงานสถานะการเงิน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนแล้วให้ สปสช.เขต ทุกไตรมาส โดยให้จัดส่งภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นไตรมาส ด้วยระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม https://pfr.nhso.go.th

๓.๒ รอบระยะเวลาบัญชีให้ถือตามปีงบประมาณ กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เข้าร่วมดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน (พื้นที่ดำเนินงานใหม่ในปีงบประมาณ) ระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีให้เริ่มระบบบัญชี ณ วันที่ได้รับเงินเป็นครั้งแรกจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๓.๓ จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศ หรือระบบอื่น และจัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนแล้ว ให้สำนักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ เขต ทุกไตรมาส โดยให้จัดส่งภายในสามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาส ตามรูปแบบที่สำนักงานกำหนด

ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุน ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนแล้วเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ

๓.๔ การจัดทำบัญชีและรายงานการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแหล่งทุนอื่น ให้เป็นตามที่กำหนดในข้อตกลงระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงาน และหน่วยงานเจ้าของแหล่งทุนนั้น.

หมายเหตุ : ในระหว่างที่รูปแบบการบันทึกบัญชีและรายงานแบบออนไลน์อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทำทะเบียนคุมบัญชี และรายงานตามแบบฟอร์มเดิมส่งให้ สำนักงาน เขต ทุกไตรมาส ไปพลางก่อน

ข้อแนะนำสำหรับเป็นแนวทางประกอบการจัดทำบัญชีและรายงาน

๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทำทะเบียนคุมรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนฯ เป็นประจำทุกครั้งที่มีรายการรับหรือจ่ายเงิน และเมื่อถึงสิ้นเดือนควรจัดทำสรุปรายงานประจำเดือนเพื่อให้ประธานกรรมการทราบพร้อมลงนามรับรองและเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ และเมื่อสิ้นสุดแต่ละไตรมาส อบจ. ต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ เสนอคณะกรรมการกองทุนให้ความเห็นชอบ และส่งให้สปสช. เขต ทุกไตรมาส โดยจัดส่งภายใน ๓๐ วัน นับจากสิ้นไตรมาส ตัวอย่างการจัดทำรายการรับจ่ายเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ มีรายละเอียด ดังนี้

ไตรมาสที่ ๑ จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือในเดือนตุลาคม-ธันวาคม และจัดส่งให้สปสช.เขต ภายในวันที่ ๓๐ ของเดือนมกราคม และ อบจ.เก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ

ไตรมาสที่ ๒ จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือในเดือนมกราคม-มีนาคม และจัดส่งให้สปสช.เขต ภายในวันที่ ๓๐ ของเดือนเมษายน และ อบจ.เก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ

ไตรมาสที่ ๓ จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือในเดือนเมษายน-มิถุนายน และจัดส่งให้สปสช.เขต ภายในวันที่ ๓๐ ของเดือนกรกฎาคม และ อบจ. เก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ

ไตรมาสที่ ๔ จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือในเดือนกรกฎาคม-กันยายน และจัดส่งให้สปสช.เขต ภายในวันที่ ๓๐ ของเดือนตุลาคม และ อบจ. เก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ

๒) องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ ของปีที่ผ่านมา เสนอคณะกรรมการกองทุนให้ความเห็นชอบ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ

๔. วิธีการกำกับติดตามเงินกองทุน

๔.๑ กรณีผู้มีสิทธิรับเงินเป็น อบจ อปท. อื่น สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชน

๑) ให้นำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด ที่ระบุในโครงการซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน โดยการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน และการจัดทำบัญชี ให้เป็นไปตามระเบียบที่หน่วยงานนั้น ๆ ถือปฏิบัติ

๒) ให้เก็บหลักฐานการจ่ายเงินจากบัญชีไว้เพื่อการตรวจสอบ

๓) เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน ตามโครงการ หรือกิจกรรม ให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานการจ่ายเงิน ส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อให้คณะกรรมการกองทุนทราบ และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ

๔) กรณีที่มีเงินเหลือจากการดำเนินงาน ตามโครงการ หรือกิจกรรม ให้นำเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด

๔.๒ กรณีผู้มีสิทธิรับเงินเป็นกลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุ องค์กรอื่นหรือกลุ่มประชาชน

๑) ให้นำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด ภายใต้โครงการ หรือกิจกรรม ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ยกเว้นรายการค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

๑.๑) ค่าใช้จ่ายสำหรับบุคคลที่ดำเนินงานตามโครงการ หรือกิจกรรม ให้เบิกจ่ายในอัตราเทียบเคียงตามระเบียบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยอนุโลม

๑.๒) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับบุคคลที่ดำเนินงานตามโครงการ หรือกิจกรรม ให้เบิกจ่ายในอัตราเทียบเคียงตามระเบียบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยอนุโลม

๒) การจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ หรือกิจกรรม ให้ถือราคากลางตามระเบียบของทางราชการ หรือราคาตลาดโดยทั่วไปในขณะที่จัดซื้อจัดจ้าง

๓) การจัดหาครุภัณฑ์ให้แนบเอกสารใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญรับเงินไว้กับรายงานการจ่ายเงินดังกล่าวด้วย

๔) เมื่อเสร็จสิ้นโครงการให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานการจ่ายเงินตามโครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนทราบ และให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ

๕) กรณีที่มีเงินเหลือจากการดำเนินงาน ให้นำเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด

บทที่ ๖

การติดตาม และประเมินการบริหารจัดการกองทุนฯ

หลักเกณฑ์ตามข้อ ๒๔ แห่งประกาศฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้กองทุนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จัดให้มีกลไกสำหรับส่งเสริมการสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และดำเนินการกำกับ ติดตาม ประเมินผล โดยรายงานให้สำนักงานทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประสานงาน ติดตาม ประเมินผล และส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯ ส่วนการกำกับอาจกระทำได้ตามขั้นตอนการสั่งการตามระเบียบวิธีปฏิบัติของหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งแบบประเมินดังกล่าวนี้สามารถนำไปปรับให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการของแต่ละพื้นที่ได้

กรอบการประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด ได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณาไว้ ๔ ด้าน รวม ๑๐๐ คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ประสิทธิภาพการบริหารเงินกองทุนฯ
๒. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ
๓. ประสิทธิผลการสนับสนุนโครงการ
๔. ประสิทธิผลการได้รับประโยชน์เชิงรูปธรรม ทางสุขภาพ และทางสังคม

แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด

ชื่อ กองทุน : กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด .....

องค์การบริหารส่วนจังหวัด .....

วันที่ประเมิน ..... เดือน ..... พ.ศ.....

คำชี้แจง แบบประเมินนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดใช้สำหรับการประเมินตนเองในการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และโปรดจัดส่งให้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขต เพื่อการติดตาม และประเมินผล และร่วมพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดต่อไป

แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....

(สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๘)

ชื่อกองทุน: กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด .....

องค์การบริหารส่วนจังหวัด .....

วันที่ประเมิน ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

เกณฑ์การประเมิน (I-A-V-O Model)

แบ่งน้ำหนักคะแนนออกเป็น ๔ ด้าน รวม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้:

๑. **ด้านปัจจัยนำเข้า (Input):** ความพร้อมของแผน, ข้อมูล และคณะกรรมการ (๓๐ คะแนน)

๒. **ด้านกระบวนการ (Action):** ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเงิน (๒๐ คะแนน)

๓. **ด้านผลผลิต (Output):** ความสำเร็จของโครงการและการเบิกจ่าย (๒๕ คะแนน)

๔. **ด้านผลลัพธ์ (Value):** ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับและผลกระทบ (๒๕ คะแนน)

ตารางรายละเอียดการให้คะแนน

หมวดประเมิน	ตัวชี้วัด (KPIs)	คะแนนเต็ม	เกณฑ์การให้คะแนนและหลักฐานอ้างอิง
ส่วนที่ ๑ ปัจจัยนำเข้า (Input)	๓๐		
๑.๑ การจัดทำและอนุมัติแผนการเงิน	มีแผนการเงินที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ทั้ง ๕ ด้านตามประกาศฯ ข้อ ๑๑	๑๐	• ๑๐ คะแนน อนุมัติแผนภายใน ธ.ค. และครอบคลุมทั้งสร้างเสริม, ป้องกัน, ฟื้นฟู, รักษาปฐมภูมิ และบริหารจัดการ • ๕ คะแนน: มีแผนแต่ไม่ครบทุกด้าน หรืออนุมัติล่าช้า • ๐ คะแนน ไม่มีแผน

หมวดประเมิน	ตัวชี้วัด (KPIs)	คะแนนเต็ม	เกณฑ์การให้คะแนนและหลักฐานอ้างอิง
๑.๒ องค์ประกอบคณะกรรมการกองทุน	มีการแต่งตั้งกรรมการครบองค์ประกอบตามข้อ ๑๖	๑๐	• ๑๐ คะแนน กรรมการครบทุกภาคส่วน • ๕ คะแนน อยู่ระหว่างสรรหาบางตำแหน่ง • ๐ คะแนน องค์ประกอบไม่ครบ
๑.๓ ฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย	มีฐานข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการและกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ (ใช้ประกอบการทำแผนข้อ ๑๑(๑)	๕	• ๕ คะแนน มีฐานข้อมูลเป็นปัจจุบัน ระบุพิกัดหรือจำนวนชัดเจน • ๒ คะแนน มีข้อมูลแต่ไม่เป็นปัจจุบัน • ๐ คะแนน ไม่มีข้อมูล
๑.๔ การสมทบงบประมาณ	อบจ. สมทบเงินเข้ากองทุนครบถ้วนตามข้อ ๗(๒)	๕	• ๕ คะแนน สมทบครบ ๑๐๐% ภายในไตรมาส ๑-๒ • ๐ คะแนน ยังไม่สมทบ
ส่วนที่ ๒กระบวนการ (Action)	๒๐		
๒.๑ การประชุมคณะกรรมการ	มีการประชุมอย่างน้อย ๔ ครั้ง/ปี เพื่อติดตามงาน (ตามข้อ ๒๐)	๕	• ๕ คะแนน ประชุมครบ ๔ ครั้ง มีรายงานการประชุม • ๓ คะแนน ประชุม ๒-๓ ครั้ง • ๐ คะแนน ประชุมน้อยกว่า ๒ ครั้ง
๒.๒ การควบคุมค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ	ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ (หมวด ๔) ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินกองทุน	๕	• ๕ คะแนน ควบคุมได้ไม่เกิน ๑๕% • ๐ คะแนน เกิน ๑๕%
๒.๓ ระบบบัญชีและการรายงานผล	บันทึกบัญชีและรายงานผลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ครบถ้วน (ตามข้อ ๒๕)	๕	• ๕ คะแนน รายงานครบ ๔ ไตรมาส ภายในกำหนด • ๓ คะแนน รายงานล่าช้าบางไตรมาส • ๐ คะแนน ไม่รายงาน

หมวดประเมิน	ตัวชี้วัด (KPIs)	คะแนนเต็ม	เกณฑ์การให้คะแนนและหลักฐานอ้างอิง
๒.๔ การกำกับติดตามหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณ	มีกลไกติดตามโครงการของหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ข้อ ๒๕)	๕	• ๕ คะแนน มีการลงพื้นที่หรือมีเอกสารติดตามผล • ๐ คะแนน ไม่มีการติดตาม
ส่วนที่ ๓ ผลผลิต (Output)	๒๕		
๓.๑ ความสำเร็จของโครงการ	ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	๑๕	• ๑๕ คะแนน แล้วเสร็จ > ๘๐% • ๑๐ คะแนน แล้วเสร็จ ๖๐-๗๙% • ๕ คะแนน แล้วเสร็จ < ๖๐%
๓.๒ การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม	๑๐	• ๑๐ คะแนน เบิกจ่าย > ๘๐% ของรายรับ • ๕ คะแนน เบิกจ่าย ๕๐-๗๙% • คะแนน เบิกจ่าย < ๕๐%
ส่วนที่ ๔ ผลลัพธ์ (Value)	๒๕		
๔.๑ การเข้าถึงบริการ	กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการสาธารณสุข ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และ ฟื้นฟูฯ ตามวัตถุประสงค์กองทุน	๑๕	• ๑๕ คะแนน เข้าถึงบริการ > ๘๐% ของกลุ่มเป้าหมาย • ๑๐ คะแนน เข้าถึงบริการ ๕๐-๗๙% • ๕ คะแนน เข้าถึงบริการ < ๕๐%

สรุปผลการประเมิน

คะแนนรวม ..... / ๑๐๐ คะแนน

ระดับผลการประเมิน

- Grade A+ (๙๐-๑๐๐) กองทุนศักยภาพสูง (ศูนย์เรียนรู้)
- Grade A (๗๐-๘๙) กองทุนศักยภาพดี
- Grade B (๕๐-๖๙) กองทุนศักยภาพปานกลาง
- Grade C (๐-๔๙) กองทุนต้องได้รับการพัฒนาเร่งด่วน

ความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

(ลงชื่อ) ..... ผู้ประเมิน

(.....)

ตำแหน่ง .....

(ลงชื่อ) ..... รับทราบผลการประเมิน

(.....)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประธานกรรมการกองทุนฯ)



QR CODE Facebook

QR CODE Line

กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง

ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ชั้น 6
140 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

โทร. 038-617-430 ต่อ 203 หรือ มือถือ. 095-818-0720